

于此项研究得出了一些结论（Vaillant, 1977; Vaillant & Vaillant, 1990）。

在20岁出头的时候，这些男性往往会受父母权威的影响。但此后直到30多岁，他们逐渐独立自主。他们结婚生子，同时将精力集中于工作，此即职业巩固阶段。

韦兰特为这一阶段的人描绘了一幅相当乏味的肖像。他的被试为了获得晋升，非常努力地工作。他们循规蹈矩，努力向职业规范靠拢，并没有表现在大学里的独立性和质疑精神，而且通常会不加质疑地投入工作。

韦兰特指出，工作对青年人的发展起着非常重要的作用，职业巩固阶段应被视为对埃里克森理论中“亲密对疏离阶段”的心理发展阶段的补充。韦兰特认为，个体此时对职业的关注逐渐取代了对亲密关系的关注，而职业巩固阶段恰恰可以使亲密对疏离阶段过渡到再生力对停滞阶段（再生力是指个人对社会的贡献，我们将在之后的章节讨论）。

然而，人们对韦兰特的观点反应不一。有批评者指出，尽管韦兰特的样本量足够大，但仅由特定的、聪明非凡的男性群体组成。此外，自20世纪30年代至今，社会规范已有相当程度的改变，人们对工作重要性的认识也可能发生了变化。最后，样本中女性的缺失以及工作在女性生活中重要性的变化限制了韦兰特结论的普适性。

对大多数人的生活而言，很难说工作到底有多重要，但研究表明，工作构成了男性和女性同一性的一个重要部分，因为相对其他任何活动而言，工作都占据了人们更多的时间。

人们为什么工作 青年人找工作的原因有很多，不只是为了赚钱。

内在动机和外在动机 大部分情况下，人们工作是为了获得具体的奖赏，这是源于外在动机。外在动机（**extrinsic motivation**） 驱使人

们获取实际的奖赏，如金钱和声望（Singer, Stacey, & Lange, 1993）。

有时候，人们也在为各自的乐趣而工作、为个人奖赏而工作，这就是所谓的内在动机（**intrinsic motivation**）。在许多社会中，人们比较认可工作本身就很重这一观点。鉴于这个观点，工作就是一个富有意义的行为，能给人带来幸福感和满足感。

工作也影响着个人的认同。回忆一下人们初次见面时是如何进行自我介绍的，在说完姓名和家乡后，人们往往会告诉对方自己的职业。也就是说，人们从事的工作在很大程度上决定了“自己是谁”。

工作也是人类社会生活的中心内容，是人们结交朋友和进行活动的重要纽带。人们建立的工作关系也很容易变为私人朋友关系。此外，工作还通常带来社会义务，如和客户共进晚餐或参加年终派对等。

最后，人们所从事的工作也会决定其社会地位（**status**）。很多职业都和特定的社会地位有关。例如，医生和大学教师居于社会地位等级的较高层，而擦鞋工则位于社会地位较低层。

工作满意度 社会地位会影响个体的工作满意度，人们所从事工作的社会地位越高，其工作的满意度往往也越高。此外，家庭中主要收入提供者工作的社会地位，也会对其他家庭成员的社会地位产生影响（Green, 1995; Schieman, McBrier, & van Gundy, 2003）。

除了社会地位，个体的工作满意度还依赖许多因素，工作本身的性质就是重要因素之一。一些用电脑办公的职员每时每刻都受到监控，上级能一直观察他们的击键次数；一些员工进行电话销售或签单，上级也会监听他们的对话；很多雇主会对员工如何使用网络和收发电子邮件等加以监控或限制。在这种形式的工作压力下，员工的工作满意度往往偏低（MacDonald, 2003）。

如果员工能全身心投入工作，并且感到自己的想法和观点是受重视的，那么他们的工作满意度往往会比较高。人们也更喜欢内容丰富且需

要多种技能配合方可完成的工作。最后，如果员工可以对其他人产生更多影响，不管这种影响能否像上级那样直接和正式，他们都将拥有更高的工作满意度（Peterson & Wilson, 2004; Thompson & Prottas, 2006; Carton & Aiello, 2009）。



外在动机驱使人们获取实际的奖赏，如金钱、声望或昂贵的轿车。在许多不发达国家，外在动机是如何起作用的呢？

选择一份职业：选择一生的工作

学习目标**7.15** 概述金兹伯格的职业选择理论、霍兰德的人格类型理论，以及性别对工作选择的影响。

有些人从童年起就知道要从事何种工作，而另一些人对职业的选择出于偶然。大多数人处在这两者之间。

金兹伯格的职业选择理论 伊莱·金兹伯格（Eli Ginzberg）在1972年提出，人们在选择职业过程中往往会经历一系列典型阶段。第一个阶段是幻想阶段（**fantasy period**），这一阶段会持续到11岁左右，在幻想阶段，人们对职业的选择不考虑技术、能力或工作机会的可获得性。

一个孩子可能决定自己将来要成为摇滚歌星，尽管他唱歌总是跑调。

第二个阶段是尝试阶段（**tentative period**），涵盖整个青春期，人们开始考虑一些实际情况，务实地考虑各种职业的要求以及自己的能力和兴趣。他们也会考虑某一特定职业能在多大程度上满足自身价值和目标。

第三个阶段是现实阶段（**realistic period**），成年早期个体在这一阶段通过工作实践或职业培训来探索特定的职业选择。通过最初对自己能做什么的探索，人们开始缩小职业选择的范围，并最终对特定职业做出承诺。

有批评者认为金兹伯格对选择职业过程的划分过于简单。由于他研究的被试处于中等水平的社会经济地位，所以他的理论夸大了处于较低经济地位水平的人可选择的工作机会。此外，该理论对于不同阶段的年龄划分也过于死板。例如，一个高中毕业就工作的人，可能比一个上大学的人更早开始进行认真的职业决策。同时，经济因素也导致了许多人在成年期的不同阶段更换职业。

霍兰德人格类型理论 其他有关职业选择的理论强调人格对职业决策的影响。美国心理学家约翰·霍兰德（John Holland）认为，特定的人格类型与特定的职业可以进行完美匹配。如果人格与职业匹配得很好，那么个体会更加喜爱自己的职业，且离职率较小；相反，如果人格与职业的匹配度很低，那么个体就会觉得不开心，且更有可能更换其他工作（Holland, 1997）。

根据霍兰德的观点，六种人格类型对职业选择的影响较大：

- 现实型。这类人注重实效、善于解决实际问题且身体强健，但社交技能平庸。他们是优秀的农民、劳工和卡车司机。
- 智力型。这类人在理论和抽象思维上占优。虽然不擅长与人打交道，但他们适合从事数学和自然科学相关的职业。

- 社交型。这类人的语言能力和人际关系处理能力很强。他们是优秀的销售员、教师和咨询师。
- 常规型。这类人喜欢从事条理明晰的工作。他们是优秀的职员、秘书和银行出纳员。
- 进取型。这类人喜欢冒险，敢于负责。他们是优秀的领导、高效的经理人或政治家。
- 艺术型。这类人擅长以艺术形式表达自己，相比人际交往，他们更愿意置身于艺术的世界里。他们最适合从事与艺术有关的职业。

霍兰德的理论有一个核心的缺陷：并不是每个人都能完全归入这些人格类型中。而且，现实中很多人从事的工作都和他们的人格类型不符。尽管如此，该理论的基本观点已经被证实有一定的价值，人们还以此为基础设立了一系列职业测评，人们可以通过这些测评来确定适合自己的职业。关于如何选择职业，“成为发展心理学知识的明智运用者”专栏提供了一些可行性建议（Deng, Armstrong, & Rounds, 2007; Armstrong, Rounds, & Hubert, 2008）。



从金兹伯格的职业选择理论来看，人们选择职业的过程往往会经历一系列生命阶段。第一个阶段是幻想阶段，持续到11岁左右。

成为发展心理学知识的明智运用者 关于职业选择的一些建议

成年早期个体所必须面对的一个重大挑战，就是做出对其今后人生产生重大影响的决定：选择职业。尽管大多数人可以适应不同的工作并且都干得很开心，但做出选择毕竟是需要勇气的。以下是指导人们解决职业问题的建议。

- 系统地评估各种选择。图书馆里的许多书都能提供丰富的职业信息，大多数学院和高校也有就业指导中心。
- 了解自己。评价自己的优势和劣势，可通过在学校的就业指导中心填写问卷的方式来了解自己的兴趣、技能和价值观。
- 制作一张“平衡表”，列出你从事某项职业可能获得的收益和付出的成本。首先列出你将从中获得的收益和付出的成本，接着列出你的家庭成员等人将从中获得的收益和付出的成本，然后写下你将从目标职业中获得的自我肯定、自我否定，以及他人

对你从事这个职业所持的社会肯定和社会否定。

- 通过带薪或无薪实习尝试不同的职业。通过直接的观察与操作，实习生会对目标职业有一种真实的感知。
- 切记，没有永久的错误。如今，越来越多的人在成年早期或后期频繁地更换工作。人们不该将自己锁定在人生早期阶段所做的选择上。正如我们在这本书中所看到的，人的毕生都在发展。
- 随着价值观、兴趣、能力和生活环境的变化，人们可能会选择另一种不同于成年早期所选择的职业，因为这更加适合个体之后的人生发展。

性别和职业选择：女性的工作 对上一代人来说，很多成年早期的女性都会认为最合适自己的职业是家庭主妇。即使是那些在外工作的女性，往往也只能获得较低的职位。在20世纪60年代之前，美国的报纸招聘广告大致分为两个版面——“急聘：男”和“急聘：女”。男性职位包括警察、建筑工人和法律顾问等；女性职位则包括秘书、教师、收款员和图书管理员等。

职业分类反映了社会对两性工作角色分配的观点。传统观点认为，女性最适合从事公共性职业（**communal professions**），即与人际关系相关的工作，例如护理师；相反，男性最适合从事行动性职业（**agentic professions**），行动性职业是指与任务完成相关的工作，例如木工。而公共性职业相对于行动性职业的社会地位和薪水更低的事实也并不让人意外（Eagly & Steffen, 1986; Hattery, 2000; Trapnell & Paulhus, 2012）。

从社会工作者的视角看问题

公共性职业和行动性职业的划分，与传统的男女差异的观点有何关系？

虽然现在性别歧视现象已远不如几十年前那样严重，例如在美国，现在的招聘广告如果明确规定只招收某一性别，那它就是不合法的，但

社会对性别的偏见仍然存在。在传统的男性占主导的职业领域，如工程学和计算机编程领域内，很难见到女性的身影。尽管在过去的40年中，女性的收入水平有了显著增长，但其仍然低于男性（见图7-15）。事实上，尽管越来越多的女性开始走出家门参加工作，但在许多行业中，女性的待遇仍然低于从事相同工作的男性（Frome et al., 2006; U. S. Bureau of Labor Statistics, 2014）。1950—2010年，美国16岁及以上的劳动力中女性所占比例从35%左右增长到了60%以上，如今女性劳动力占总劳动力的47%左右。几乎所有女性都期望能够谋生，而且几乎所有女性在一生中的某个阶段都有过工作的经历。此外，在将近24%的美国家庭中，女性的收入甚至比她们的丈夫还多（U. S. Bureau of Labor Statistics, 2010, 2013）。

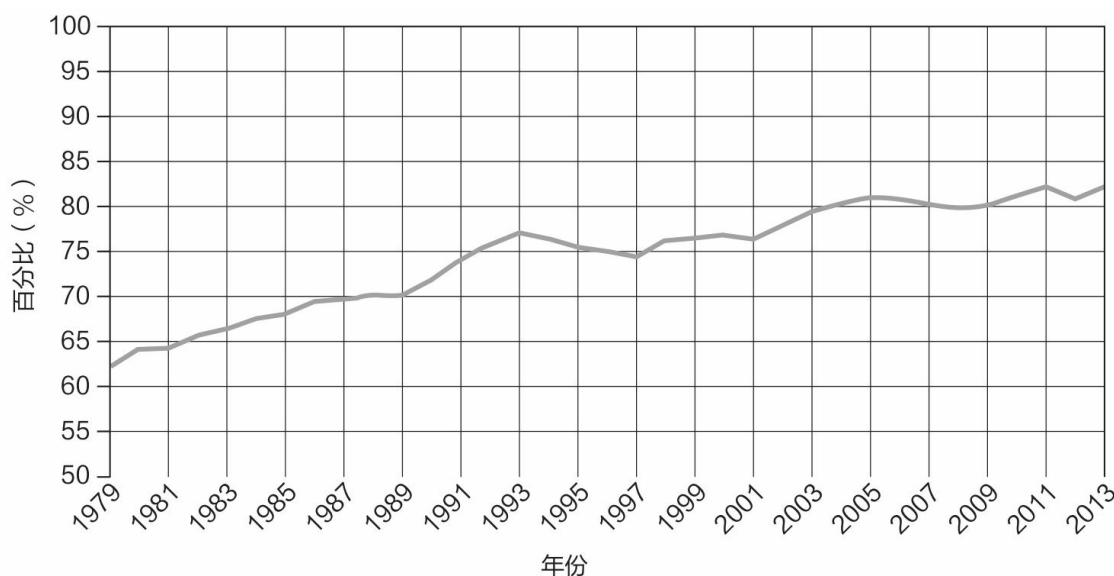


图7-15 工资的性别鸿沟

女性的周工资占男性周工资的百分比从1979年开始增长，但是仍然只略高于79%，而且在2011—2013年基本保持稳定。

资料来源：U. S. Bureau of the Labor Statistics, 2014.

女性的工作机会有了相当程度的增长。与过去相比，有更多女性成为医生、律师、保险代理人 and 巴士司机。然而，在职业分类中，性别差异仍然存在。例如，女巴士司机更多地从事校园路线的兼职工作，而男

巴士司机则从事待遇更好的城市路线的全职工作。女药剂师更有可能在医院工作，而男药剂师则在待遇更好的零售药店工作（Crawford & Unger, 2004）。

处于显然较高职务的女性和少数族裔，通常会在职业发展过程中遭遇所谓的玻璃天花板（glass ceiling）。玻璃天花板是指在某一机构内部，阻止个人晋升至高级职位的无形障碍。它产生作用的方式非常微妙，而那些造成这一障碍的人通常都没有意识到他们的行为其实是一种歧视（Goodman, Fields, & Blum, 2003; Stockdale & Crosby, 2004; Dobeles, Rundle-Thiele, & Kopanidis, 2014）。

回顾、检测和应用

回顾

学习目标7.9 解释年轻人是如何应对亲密关系和友谊需求的，以及喜欢之情是怎么变成爱情的。

在年轻人面对埃里克森的亲密对疏离阶段时，能够解决这一冲突的人会顺利与他人发展出亲密关系。

学习目标7.10 区分不同类型的爱情。

激情之爱的特点是强烈的生理唤醒、亲密和关怀，而伴侣之爱则以尊重、钦佩和喜爱为特征。斯滕伯格的爱情三元论确定了三个基本组成部分——亲密、激情、决心或承诺，它们可以结合起来形成不同类型的爱，个体间的关系也由此得以发展。

学习目标7.11 识别影响年轻人选择伴侣的因素，并举例说明这些因素如何受到性别和文化的影响。

选择配偶的参考因素很多，包括爱情和相互吸引，在某些文化中，

这些因素意味着个体的健康和成熟。男性更倾向于对伴侣的身体吸引力方面进行评价，对其关注度高于女性对伴侣该方面的评价。女性则对伴侣的雄心和勤奋程度给予更多的关注。试图解释这些差异的演化论受到了批评。跨文化的性别偏好可能反映了类似的性别刻板印象。一般来说，异性恋和同性恋伴侣关系中的价值观的相同点多于不同点。

学习目标7.12 概述人们在成年早期所进入的关系类型，并说明成功婚姻的特点。

虽然大多数年轻人有意愿结婚，但如今有很多年轻人选择同居，而其他人则更喜欢没有亲密伴侣的独居。成功婚姻的特点在于伴侣能明显表达情感、传达相对较少的消极情绪、将两人视为相互依赖的夫妻而不是两个独立的个体、分享相似的兴趣，并就角色分配达成一致。

学习目标7.13 说明影响夫妻决定生育子女的因素，并总结孩子对婚姻的影响。

人们生孩子的最常见原因是心理上的。父母从帮助孩子成长、孩子的成就以及与他们建立紧密联系的乐趣中获得快乐。孩子的出生几乎改变了家庭生活的方方面面，新手父母会发现自己处于新角色，面临自己新增的生理、心理需求和财务责任。许多婚姻都会受到这种压力的影响，但对那些保持沟通和合作并共同努力解决问题的夫妻来说，婚姻幸福感仍然会保持稳定或上升。

学习目标7.14 解释韦兰特的职业巩固阶段理论，并找出人们寻找工作时除金钱以外的动机。

根据韦兰特的说法，年轻人进入职业巩固阶段后，会将精力集中在工作中。人们因外在和内在动机而工作。工作的性质、所赋予的地位以及所提供的多样性都有助于提高个体的工作满意度。对工作者来说，觉得他们的想法和意见得到了重视也很重要。

学习目标**7.15** 概述金兹伯格的职业选择理论、霍兰德的人格类型理论，以及性别对工作选择的影响。

金兹伯格提出了职业发展的三阶段理论。批评者认为他的理论过于简化了人们选择职业的过程，而且可能并不适用于社会经济水平较低的年轻人。霍兰德提出，某些人格类型与某些职业相匹配，较高的匹配度可以提高个体的工作满意度，并使一个人更有可能在一个岗位上待更久。性别角色偏见和刻板印象仍然是工作场所以及人们准备和选择职业时要面临的问题。

自我检测

1. 埃里克森的理论表明，成人在成年早期会____。
 - a. 巩固事业
 - b. 发展同一性
 - c. 勤勉刻苦
 - d. 与他人发展关系
2. ____之爱是对与我们生活密切相关个体的强烈感情。
 - a. 激情
 - b. 完美
 - c. 亲密
 - d. 伴侣
3. 当被问及为什么要生孩子时，大多数年轻人都会给出关于____理由。
 - a. 个人的
 - b. 心理的

- c. 财务的
 - d. 社会的
4. 韦兰特的理论指出，个体在成年早期开始将精力集中在工作中，这一阶段被称为_____。
- a. 职业巩固
 - b. 生命理解
 - c. 个人成就
 - d. 职业理解

应用于毕生发展

如果韦兰特的研究对象是当今的女性，那么该结果会与之前的研究结果有什么共同点和区别？

总结

本章开头的塔基夫和赖特面临着成年早期的许多典型发展问题。他们需要考虑健康和衰老的问题，并不安地承认他们的时间并不充裕。他们需要审视两人的关系，并考虑是否像社会 and 朋友们期望的那样迈出合乎逻辑的一步——结婚。他们需要面对关于孩子和职业生涯的问题，以及搬家、辞职的可能性。他们需要重新评估继续接受教育的愿望。幸运的是，他们拥有彼此的关爱、支持其接受继续教育的供职单位和许多有用的发展技能，来应对这些问题和抉择所带来的压力。

7.1 成年早期的生理发展

- 塔基夫和赖特的身体和感觉都正处巅峰，生理发展已基本完成。
- 这一阶段中，这对情侣需要越来越多地注意饮食和锻炼。
- 因为他们面临如此多的重大决策，塔基夫和赖特是应激的高危人群。

7.2 成年早期的认知发展

- 塔基夫和赖特正处在沙因理论中的实现阶段，面对着重大的人生问题，包括职业的和婚姻的。
- 他们可以应用后形式思维解决正面临的复杂问题。
- 处理重大人生问题在导致应激的同时可能也促进了他俩的认知发展。
- 塔基夫和赖特关于重返大学的想法在今天并不罕见，大学正越来越多地接收多元化的学生并为之提供服务，包括接收许多大龄学生。

7.3 成年早期的社会性和人格发展

- 塔基夫和赖特正处于爱情和友谊对他们来说都格外重要的时期。
- 这对情侣很可能经历一段包含亲密、激情、决心或承诺的关系。
- 塔基夫和赖特已经同居了，现在正在探索婚姻关系。
- 塔基夫和赖特关于婚姻和孩子的决定并不罕见——这些决定对个体与他人的关系有着重要意义。
- 这对情侣一定也考虑好了如何处理从双薪到暂时性单薪的转变——这一决定不仅是财务方面的。



医疗保健工作者会做什么？



考虑到塔基夫和赖特还年轻健康、身材适宜，你会建议他们采取何种策略加以保持？

职业咨询师会做什么？



假设塔基夫和赖特决定要孩子，针对他们面临的主要开销和孩子对他们职业的影响，你会给出怎样的建议？

教育工作者会做什么？



赖特的一位朋友告诉他，如果他在毕业这么久后参与管理培训或进入商学院，他可能会“感觉自己像个老人”。你同意吗？你会建议赖特立刻开始继续深造，还是先等他的生活稳定下来？

你会做什么？



如果你是塔基夫和赖特的朋友，当他们考虑由同居进入婚姻时，你会建议他们考虑哪些因素？当塔基夫和赖特中的一个人单独询问时，你的建议还一样吗？

第8章 成年中期

50岁的特里是纽约市一名养育了5个孩子的全职城市规划师。“那不是一项轻松的工作，”特里说，“我整日在城市里到处奔走，基本上每天晚上都有会议。好在我丈夫布赖恩喜欢烹饪。”当然，特里也会加入孩子的教育之中。“我从未缺席过校园剧和演奏会，大多数时候也是由我来读睡前故事，周末的时候我几乎和孩子们形影不离，甚至一起洗衣服。”有时候她也会觉得快疯了，但当去年最小的孩子也离开了家后，她徘徊了3个月，开始思索接下来该做什么。

最终，还是布赖恩帮她找到了答案。他安排了一次去意大利的旅行，这是他们十几年来第一次真正意义上的旅行。“我们四处观光、品尝美食，但大多数时候，我们最在意的是在一起。”回到家，她和布赖恩制订了每周一次的约会计划。“我们终于有时间来享受性生活、长距离的散步以及在纽约时代广场享受周日早午餐。”她说。特里每周也会抽出一个晚上的时间到当地的流动厨房帮忙。“我们帮助的那些人有很多有趣的故事，他们看待事物的方式也与众不同，这些都开阔了我的眼界。”

最大的转变是特里决定辞职。“我想帮助我们社区里的人。”她正竞选州议会的席位，与此同时她的长女怀孕了。“当孩子们离开家以后，我意识到他们早已不再是我生活的内容，尽管此前我一直将他们当作我生活的中心，”特里说，“现在虽然女儿他们家不会和我一起住，但我依然期盼着外孙的诞生。”

成年中期是个体发生重大转变的时期。孩子们长大并离开了家，人们也开始改变他们对事业的看法。有时人们会像特里那样彻底地转换职业，并重新审视婚姻。通常，处于“空巢”时期的夫妻会发现他们拥有了大量不被打扰的时间，这可以让他们加深彼此的亲密度，因此成年中期是个体加强亲密度的时期。但这一时期也会有人选择离婚。中年期也是一个人“深化根系”的时期，家庭和朋友变得更重要，人们的事业心也开始退居次位，并开始有大量娱乐和放松的时间。

在本章中，我们将首先介绍成年中期个体的生理变化及其应对方式。然后我们将讨论成年中期个体的性生活和更年期，并讨论女性激素替代药物的使用情况。我们也会探讨中年人越来越关注的健康问题。

之后我们将讨论成年中期个体智力的变化情况，并提出以下问题：智力是否会随着年龄的增长而下降？我们将考察多种类型的智力，探索衰老对各种智力都有何影响。我们也会介绍记忆力。最后我们会关注社会性发展的问题，探讨人们的个性特征如何在一段时间内保持稳定或发生变化。我们还关心“中年危机”的各种迹象，并讨论在面对新情况时家庭关系会发生怎样的改变。我们会以中年时期的工作和休闲这一话题结束本章。

8.1 成年中期的生理发展

男人也会经历更年期吗？

8.2 成年中期的认知发展

成年中期智力会衰退吗？

8.3 成年中期社会性和人格发展

中年危机：真实的还是虚构的？

8.1 成年中期的生理发展

与时间赛跑

52岁的卡拉为自己的成功感到自豪。“我不认为完美主义者是一个贬义词。”她说。卡拉在大学时接受过建筑师训练，并在27岁时创办了自己的公司。与酗酒的丈夫离婚后，她独自抚养了两个孩子。

卡拉每天早上跑5英里（约8千米），吃低热量、高钙的早餐，每周参加现代舞、击剑和普拉提的课程。晚上，她会审阅员工提出的各种项目的设计方案。周末没有应酬的时候，她会和伴侣史蒂芬一起去海边。

最近，在竞标一项重要的合同时，卡拉的公司受到了一位新建筑师的挑战。“这个20多岁的男孩太自大了，”她说，“但我的经验是无法超越的。”卡拉的公司最终赢得了合同。“我到70岁的时候，仍然会赢得冠军，”她说，“年龄会拖累我？我可不相信。”

在40~65岁的中年时期，人们通常会开始注意并感受到衰老的影响。在某种程度上，人们的身体以及认知能力以不受欢迎的方式改变。然而，这也是许多中年个体的生理、认知和社会性达到自身能力顶峰的时候，他们正以前所未有的方式塑造自己的生活。

在这一节，我们将从个体的生理发展开始探讨。身高、体重和力量的变化是我们所关注的，各种感官能力的细微下降也在我们的讨论范围当中。

我们将研究成年中期个体的性行为。我们会研究男性和女性激素分泌变化所带来的影响以及缓解这种转变的各种疗法，尤其是与绝经相关的话题。我们也会考虑个人心态在这一过程中发挥的作用。

然后我们将考察中年个体的健康和疾病状况。我们会考虑压力的影响，并特别关注两个主要的健康问题——心脏病和癌症。

生理发展与性

刚过40岁，莎伦就发现，即使自己只得了一些诸如感冒或流感之类的小病，康复所需的时间也更长了。此外，她发现视力也变差了，需要更亮的灯光才能看清小号的字，需要仔细调整报纸和脸的距离才能看清上面的字。最后，她再也无法忽视头上的白发了，快30岁时还仅仅是掺杂几根银丝的头发，现在几乎全白了。

生理转变：身体机能上的渐变

学习目标8.1 描述影响成年中期个体的生理变化。

在成年中期，人们开始意识到衰老带给身体的变化。其中有些变化是由衰老，或者说是自然衰退导致的，另一些则和人们的生活方式有关，如日常饮食、体育锻炼、吸烟、喝酒及药物使用状况等。我们发现，不同的生活方式对中年人的生理状态，甚至认知能力和健康水平都有很大的影响。

虽然生理的变化伴随我们终身，但中年时期的生理变化有着新的重要意义，在注重青春外貌的文化中更是如此。对大多数人来说，这些变化带来的心理意义远超过他们正在经历的微小且缓慢的生理变化本身。莎伦在20多岁时就有了白头发，但在40岁时，这些白头发的产生速度已经让她无法忽视了。她已经不再年轻了。

人们对中年时期生理变化产生的情绪反应，在某种程度上依赖于其自我概念。当人们的自我意象与身体特征紧密联系在一起时，如对于知名的男、女运动员或具有迷人外表的人来说，成年中期对他们来说将会是一个非常艰难的时期。他们从镜中看到了自己的种种衰老迹象，这不仅意味着他们的外在吸引力在下降，也意味着死亡的临近。与之相反的是，那些不将自己与生理特点紧密联系的中年人，对身体的满意度则和年轻人比起来并未减少（Hillman, 2012; Murray & Lewis, 2014）。

通常，外表在某种程度上影响了女人如何看待自己。在许多文化中，女性都要面临保持年轻外表的强大社会压力。社会对男人和女人的外表评价采取了双重标准：“年老的女人”是个让人不愉快的描述，但年老的男人则常常被认为是“成熟”的和有吸引力的（Andreoni & Petrie, 2008; Pruis & Janowsky, 2010）。

身高、体重和体能：变化的基准 大多数人会在20多岁时达到身高的顶峰，并能维持此身高到55岁左右。之后人们的身高会开始一个“沉降”的过程，连接脊柱的骨骼开始变得疏松。身体变矮的进程非常缓慢，最终女性平均降低5厘米，男性则平均降低2.5厘米（Bennani et al., 2009）。

女性更容易变矮是因为她们患骨质疏松的风险更大。虽然个体患骨质疏松有遗传的因素，但这也是衰老的一个方面，会受到不同生活方式的影响。女性和男性都可以通过摄取牛奶、乳酪、奶酪和其他富含钙质的食物，以及定期的体育锻炼，来降低患骨质疏松的风险（Wang et al., 2013; Rizzoli & Brandi, 2014; Peng et al., 2016）。

成年中期，身体的脂肪开始增加。即使是那些一直都很苗条的人，体重在这一时期也很有可能增加。由于成年中期个体的身高不再增长，甚至还会降低，体重增加很可能导致肥胖。人们也可以避免体重的增加，选择恰当的生活方式就是重要手段，比如那些定期锻炼的人通常不会过度肥胖。有些文化比较崇尚运动，生活在这种文化背景下的人相比于其他人更不容易发胖。

伴随着身高和体重的变化，人们的体能也会衰退。个体的肌肉力量会逐渐下降，尤其是后背及腿部肌肉。到60岁时，相比于顶峰状态，个体的体能平均下降了10%。不过这种损失并不严重，大多数人可以轻易地弥补这种损失（Spence, 1989）。选择恰当的生活方式再次发挥了作用。定期的运动可以让人们感觉自己强壮且更容易弥补各种损失。

感觉能力：中年时的视力和听力 类似莎伦经历的那种视力变化是非常普遍的现象，放大镜和远近视两用眼镜都已经成为中年人典型形象的标志。很多人都像莎伦一样，视敏度会发生变化，不仅如此，其他感官的灵敏程度也大不如前。所有的器官似乎都正以大致相同的速度发生变化，但是视力和听力的变化最为明显。

视力 从40岁左右开始，视敏度开始下降。眼睛晶状体的形状开始改变，弹性也开始变差，致使视觉映象难以汇聚到视网膜。晶状体变得更加浑浊，导致穿过眼睛的光线减少（Yan, Li, & Liao, 2010）。

个体在中年时期近乎一致的变化是近距离视力的衰退，俗称老花眼（**presbyopia**）。即使从来没有戴过眼镜或隐形眼镜的人也会发现，他们需要把读物拿得越来越远才能看清，最后不得不戴上眼镜读书。而近

视眼的人则可能需要远近视两用眼镜或者配两副眼镜才能满足需要（Koopmans & Kooijman, 2006; Kemper, 2012）。

中年个体还会有其他类型的视力改变。深度知觉、距离知觉以及三维知觉能力都会减退。视杆细胞⁽²⁴⁾的减少和晶状体混浊还会损伤人们的暗适应能力，使人们在黑暗的房间中行走变得更加困难（Spear, 1993）。

不仅正常的衰老会带来视力的变化，疾病也同样会对视觉产生影响。青光眼（**glaucoma**）就是一种最常见的眼部疾病，如果不及时治疗将最终导致失明。青光眼是由于眼内液体分泌过多或没有被适当地排出，导致眼内液压增高而引起的眼部疾病。1%~2%的人在40岁时会患此病，而非裔美国人更易患此病（Wilson, 1989）。



视敏度会在40岁左右开始减弱。大多数人开始出现老花眼，看不清近处的东西。

开始时，液压可能会压迫视觉的外周神经系统导致视野狭窄，长此以往，压力会大到压迫所有的神经细胞并最终导致患者失明。好在如果能够早发现早治疗，青光眼是完全可以治愈的。药物治疗可以降低液力，手术也可以恢复眼内液体的正常排出能力（Lambiase et al., 2009; Jindal, 2013; Sentis et al., 2016）。

听力 虽然听觉的变化不像视觉那样明显，但在中年时期，个体

听觉的敏锐性也下降了。

一些环境因素同样会导致人们的听觉损伤。在巨大噪声中工作的人，比如飞机机修工和建筑工人，其听力更有可能受损，甚至产生永久性的损伤。

还有很多听力的变化是由衰老直接导致的。声波引起的振动会使内耳毛细胞弯曲，它们通过这种方式将神经信息传递给大脑细胞，但衰老会导致毛细胞减少。和眼睛的晶状体一样，耳膜的弹性会随着年龄的增加而减弱，这会导致个体对声音的敏感度降低（Wiley et al., 2005）。

个体对高音调和高频的听力一般是最先下降的，这也被称为老年性耳聋（**presbycusis**）。45~65岁的人群中大约有12%的人患有老年性耳聋。男性听觉损伤的可能性比女性大，一般在55岁就开始了。听力有问题的人可能在声音定位，即辨别声音的传播方向以及声源时出现困难（Veras & Mattos, 2007; Gopinath et al., 2012; Koike, 2014）。

中年时期的听觉损伤并不会给人们带来太大的影响。大多情况下人们都能较轻易地找到补偿的方法，如要求别人说话大声一些、把电视声音放大或更仔细地听他人说话。

反应时 人们共同担忧的一个问题是，自己到中年会变得迟钝，但在多数情况下这种担忧并没有根据。个体的反应时（**reaction time**），即从刺激到呈现反应的时间的确增加了，但一般来说其增量非常小，甚至难以被人察觉。比如，个体从20岁到60岁，对大声噪声的反应时增加了大约20%。那些需要协调多种能力来完成的任务，如开车的反应时增加得很少，但面对紧急情况时把脚从油门换到刹车的反应时则有稍多的增加。这是由于神经系统产生神经冲动的速度的变化导致了个体反应时的增加（Roggeveen, Prime, & Ward, 2007; Godefroy et al., 2010）。

即使反应时增加了，与年轻人相比，中年人发生车祸的比例仍然更

低，这可能是由于他们驾驶时会更小心且不会冒险。另外，长年的驾驶者往往拥有更多经验，他们的专业性技能补偿了轻微的反应时变化

（Makishita & Matsunaga, 2008; Cantin et al., 2009; Endrass Schreiber & Kathmann, 2012）。

健康的生活习惯可以减缓个体反应时增加的过程。主动锻炼也可以缓和衰老带来的影响，改善健康状况、增强肌肉力量和耐力（见图8-1）。



肌肉系统

减缓身体在能量分子、肌肉细胞厚度、肌肉细胞数量、肌肉厚度、肌肉块、肌肉力量、血液供应、运动速度以及耐力上的衰退

减缓身体在脂肪、纤维、反应时、恢复时间和肌肉疼痛等方面的增长



神经系统

减缓中枢神经系统中神经冲动加工能力的衰退

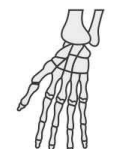
减缓运动神经元脉冲速度变异的增大



循环系统

保持低密度脂蛋白在较低水平、高密度脂蛋白 / 胆固醇在较高水平以及高密度脂蛋白 / 低密度脂蛋白的较高比例

降低患高血压、动脉硬化、心脏病及中风的风险



骨骼系统

减缓骨骼中矿物质的流失

降低骨折及患骨质疏松的风险



心理上的裨益

使情绪高昂

感觉幸福

舒缓压力

图8-1 锻炼的好处

终身保持高水平的身体活动有很多好处。

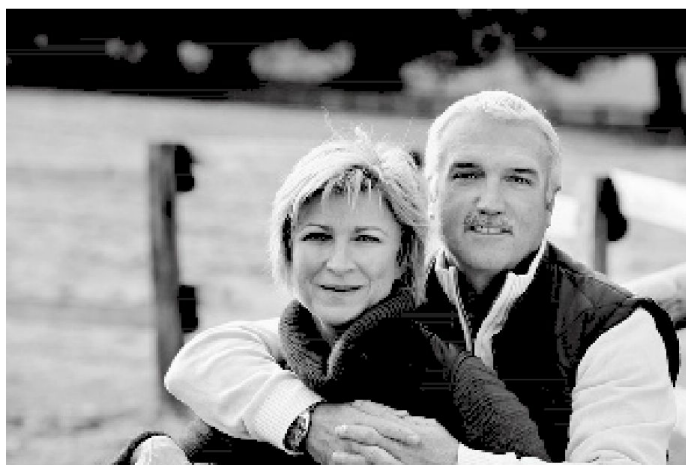
资料来源：DiGiovanna, 1994.

成年中期的性：事实、谣言以及争议

学习目标**8.2** 分析成年中期个体性行为的变化本质。

51岁时，伊莱恩非常期待停经后的生活。她最小的儿子刚离家去学习艺术，而她最近也把工作量减少到了可以轻松完成的程度，一周只需30个小时。她觉得这一年会是自己和丈夫格雷格的“第二个蜜月”，不用避孕，也不需要担心会怀孕。

她的蜜月幻想很快在几次潮热和夜间盗汗中破碎。伊莱恩知道这是停经后正常的症状，她现在每天至少要换三次衣服。而且她还时常头痛，医生给她开了些含激素的药物来补充停经后身体减少分泌的雌性激素。她对此类药物并不过敏，所以就遵照医嘱开始服药。药剂减轻了她的症状，并让她恢复了精神。4个月后，她和丈夫格雷格预定了在希腊为期一个月的浪漫游。



对大多数中年人来说，性生活仍然是生活中很重要的一部分。

虽然多数中年人对性依然保持较高的兴趣，但衰老带来的生理变化，如女性的停经，仍然会降低人们的兴致。我们来看看影响中年人性生活的一些因素，以及态度和治疗药物对这一阶段出现的问题的作用。

中年时期仍然持续的性生活 这一年龄段人们性生活的频率会逐

渐下降（见图8-2），但性快感仍然是多数中年人生活的重要部分。在美国，大约有一半的年龄在45~59岁的人报告说一周至少会有一次性生活。50~59岁的人群中，接近75%的男性和超过一半的女性会手淫；在过去一年中，该年龄段中1/2的男性和1/3的女性与不同的性伴侣进行过口交。对男、女同性恋夫妻来说，性仍然是中年时期重要的活动（Herbenick et al., 2010； Koh & Sewell, 2015）。

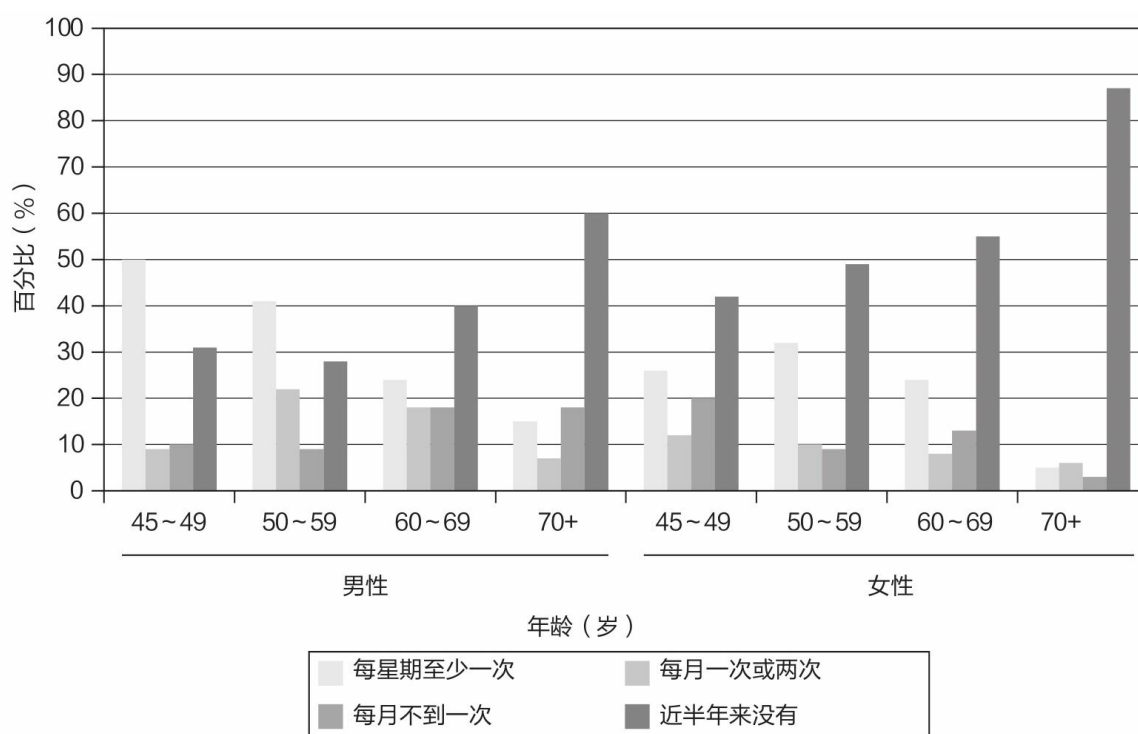


图8-2 成年中期和晚期异性性行为的频率

2009年美国退休人员协会（American Association of Retired Persons, AARP）的性行为调查显示，成年中期和晚期的性生活频率在逐渐下降，但仍然是生活中的重要活动。

资料来源：Fisher, 2010.

多数情况下，人们能在中年时期重新找回之前失去的性愉悦感和自由。孩子们逐渐长大并离开家，夫妻可以有大量时间进行性活动而不再会被打断。停经后的女性不用再担心怀孕或进行节育（Lamont, 1997; DeLamater, 2012）。

男性和女性的性生活在中年时期都会面临一定的挑战。男性需要更

长的时间才能勃起，并且一次高潮后需要更长的时间才能进行下一次。男性射出的精液和睾丸激素的量都会减少（Hyde & DeLameter, 2003）。

在这一阶段，女性的阴道壁会变薄且失去弹性。阴道开始萎缩和收紧，致使性交过程产生疼痛感，但这并不会降低绝大多数女性的性快感。那些觉得性交过程不够愉悦的女性可以通过一系列提高性快感的药物，如局部润滑乳、睾酮贴剂等来增加性愉悦感（Laumann, Paik, & Rosen, 1999; Freedman & Ellison, 2004; Nappi & Polatti, 2009; Spring, 2015）。

女性更年期和停经 女性到45岁左右会进入更年期，更年期将持续15~20年。女性更年期（**female climacteric**）的到来标志着女性由能生育到不能生育的转变。

这种转变的一个明显信号就是停经（**menopause**），停经就是停止来月经。妇女的经期在47~48岁这两年会紊乱，而且来月经的频率会降低，这种变化也可能早在40多岁就发生，或晚至60多岁才发生。如果女性整整一年都不再来月经，就可以认为她进入了停经期。

停经意味着女性失去了自然生育的能力，不过植入卵子仍可以让停经后的女性怀孕。另外，此时雌性激素和黄体酮素的水平也会开始下降（Schwenkhagen, 2007）。

上述激素分泌的改变会使个体产生一系列的症狀，而个体间的症狀差异很大。最普遍的症狀之一就是“潮热”，女性会感到一股热流涌向腰部以上的部位，在潮热发生时女性可能会变得燥热并出汗，之后又会发冷。有的女性一天之内可能会发生多次潮热，而有的一次都没有。

头痛、困倦、心悸、关节痛是女性在停经期比较常见的症狀，但并不是普遍存在的。一项调查发现，大约一半的女性称曾经历过潮热，但只有1/10的女性对此感到非常痛苦，超过一半的女性根本没有任何明显

的症状（Grady, 2006; Ishizuka, Kudo, & Tango, 2008; Strauss, 2013）。

很多女性的停经期症状可能早在真正停经的10年前就开始出现了。围绝经期（perimenopause）指停经之前激素分泌发生变化的一段时期。其特点是女性的激素基础水平发生波动，导致一些与停经期相同的症状出现（Winterich, 2003; Shea, 2006; Shuster et al., 2010）。

一些女性的围绝经期和停经期症状相当严重，处理这些问题也颇具挑战性。

激素疗法的困境：没有简单的答案 桑德拉很肯定自己有心脏病。她在花园中除草时会突然喘不上气，觉得自己像着火了一样，头晕眼花的，同时还感到恶心，她坚持到厨房拨打了911之后，就摔倒在地。当医护人员告诉她，这不是心脏病，而是她第一次出现潮热时，她松了一口气，但又倍感尴尬。

10年前，医生对由停经引起的潮热及其他一系列不适反应会有一个直接的治疗方法：定期开激素替代类药物。

对上百万遭遇这种麻烦的女性来说，激素疗法（hormone therapy, HT）是种不错的选择。这一疗法使用的雌性激素和黄体酮素可减轻许多女性停经后产生的各种最严重的症状。激素疗法可以缓解各种问题，如潮热和皮肤失去弹性；可以通过改变“好的”胆固醇和“坏的”胆固醇之间的比值来降低冠心病的发病率。激素疗法还可以在一定程度上解决许多中年人面临的一个重要问题——由于骨质疏松引起的骨骼变薄（Alexandersen, Karsdal, & Christiansen, 2009; Lisabeth & Bushnell, 2012; Engler-Chiurazzi, Singh, & Simpkins, 2016）。

还有一些研究显示，激素疗法能够降低个体罹患中风和结肠癌的风险。雌性激素可以减缓老年痴呆症患者的心智衰退，有些研究发现该激素能改善健康女性的记忆力和认知表现。最后，较高的雌性激素还可以增加中年个体的性欲（Cumming et al., 2009; Garcia-Portilla, 2009;

Lambrinoudaki & Pérez López, 2013)。

虽然激素疗法听起来像万灵药，但自20世纪90年代这种药剂的使用风靡一时开始，人们就逐渐意识到了它的各种风险。例如，它会增加个体患乳腺癌和血液凝结的风险。尽管如此，人们仍然认为这种疗法利大于弊。2002年，女性健康倡议协会（Women's Health Initiative）进行了大量研究，发现激素治疗法会引发长期的风险，其弊大于利，上述观点才得以改变。研究发现，使用雌性激素和黄体酮素混合剂的女性患乳腺癌、中风、肺栓塞和心脏病的风险更高。后来的研究发现，中风和肺栓塞的风险增加就和雌性激素的使用有关（Lobo, 2009）。

这些研究结果开始让人们重新思考激素疗法的益处，并对激素疗法抵抗慢性疾病的作用提出质疑。很多女性不再用激素替代类药物。数据显示，2002年美国40%的绝经女性使用了激素疗法，而10年后，这一数字降到了20%（Newton et al., 2006; Chelebowski et al., 2009; Beck, 2012）。

然而，使用激素疗法的人数急剧下降也可能是因为人们过度反应了。大多数医学专家认为，有些女性可能更适合使用激素疗法。年龄较大的女性由于患冠心病和其他各种并发症的风险增高，所以并不是很适合使用激素疗法，但对那些较年轻且正存在严重停经症状的女性，如参加女性健康倡议协会调查的被试来说，她们仍然能从该疗法中，至少从短期的治疗中获益（Rossouw et al., 2007; Lewis, 2009; Beck, 2012）。

最终，尽管大多数医学专家认为激素疗法值得一试，但它的风险性仍不可忽视。接近停经期的女性应该多查查相关资料或询问医生，深思熟虑后再做决定。

停经后的心理反应 包括专家在内的很多人都习惯性地认为停经会造成女性的抑郁、焦虑、易哭、注意力缺陷以及焦躁。一些研究者估计，约10%的停经女性患有严重的抑郁症。人们认为停经的生理变化会给女性带来以上心理问题（Soares & Frey, 2010; Mauas, Kopala-Sibley, &

Zuroff, 2014)。

然而如今，大多数研究者改变了看法，他们认为停经是女性衰老过程中的一个正常现象，其本身并不会引发心理问题。有些停经的女性的确有心理障碍，但是她们在其他时期也存在这些问题（Freeman, Sammel, & Liu, 2004; Somerset et al., 2006; Wroolie & Holcomb, 2010）。

研究显示，女性的心理预期对其停经时的体验有显著影响。那些预期停经时会很艰难的女性会把所有的生理反应和情绪波动都归因于停经，而态度积极的女性就不会这样。女性对生理反应的归因方式，会影响她的预期以及在这一时期的真实体验（Breheny & Stephens, 2003; Bauld & Brown, 2009; Strauss, 2011）。

从医疗保健工作者的视角看问题

哪些文化因素会为女性的停经体验带来负面影响，为什么？

男性更年期 男性是否会有类似于停经期的经历呢？并没有。男性没有任何与月经有关的体验，当然也无法体会那种月经不再继续后的感受。但是男性在中年时期的确会经历一些改变，也就是男性更年期（**male climacteric**）。男性更年期指的是男性由于生殖系统的改变而引发生理及心理变化的一段时期，发生于中年晚期，症状最集中的年龄是50多岁。

由于变化是逐渐形成的，所以研究者很难指出男性更年期的确切时间。比如，虽然睾丸激素和精子量减少了，但男性在整个中年时期都仍能孕育孩子。而且和女性不同的是，男性的心理变化很难归因到细微的生理原因上。

男性在这一时期一个比较常见的生理改变是前列腺肥大。大约10%的40岁左右的男性会罹患前列腺肥大，到80岁时，患该病的百分比会上

升到50%。前列腺肥大会造成男性的排尿问题，包括小便困难和夜间尿频。

随着年龄的增长，男性的性问题也在增加，尤其是勃起功能障碍，即男性普遍更难成功勃起或维持勃起状态。一些药剂，如伟哥（Viagra）、艾力达（Levitra）和犀利士（Cialis）以及一些含有睾丸激素的贴片都能起到有效的作用（Abdo et al., 2008; Shamloul & Ghanem, 2013; Glina, Cohen, & Vieira, 2014）。

健康状态会下降吗

对杰尔姆来说，运动是每天必不可少的。早上五点半起床，他踏上健身脚踏车，并开始用力蹬脚踏板，希望能维持并超过自己每小时14公里的平均速度。他打开电视，调到早间商业新闻。只偶尔瞥一眼电视，他就开始看昨晚没看完的报告，并在看到并不理想的销售额时嘀咕几句。结束半小时的锻炼后，他已经看完了报告，并在行政助理打印好的信上签名，然后给同事留下了两封语音邮件。

可能大多数人在经历如此紧凑的半小时后都会小睡一会儿，但对杰尔姆来说这已经是日常习惯了：他总试图同时进行多项工作，觉得这样更有效率。发展心理学家把这种行为模式看作一个人易患冠心病的信号。

尽管大多数中年人都很健康，但他们也渐渐更容易受到各种健康问题的困扰。接下来我们将探讨人们在中年时期最典型的一些健康问题，主要关注冠心病和癌症。

健康和疾病：成年中期的起伏波动

学习目标**8.3** 描述成年中期一般个体的健康状况。

人们对健康的关注在中年时期变得越来越重要。有关成人烦恼的调查显示，健康、安全和金钱是这一时期的人们最为关注的问题。超过半数的成年人都“担忧”或“非常担忧”自己罹患癌症（见图8-3）。

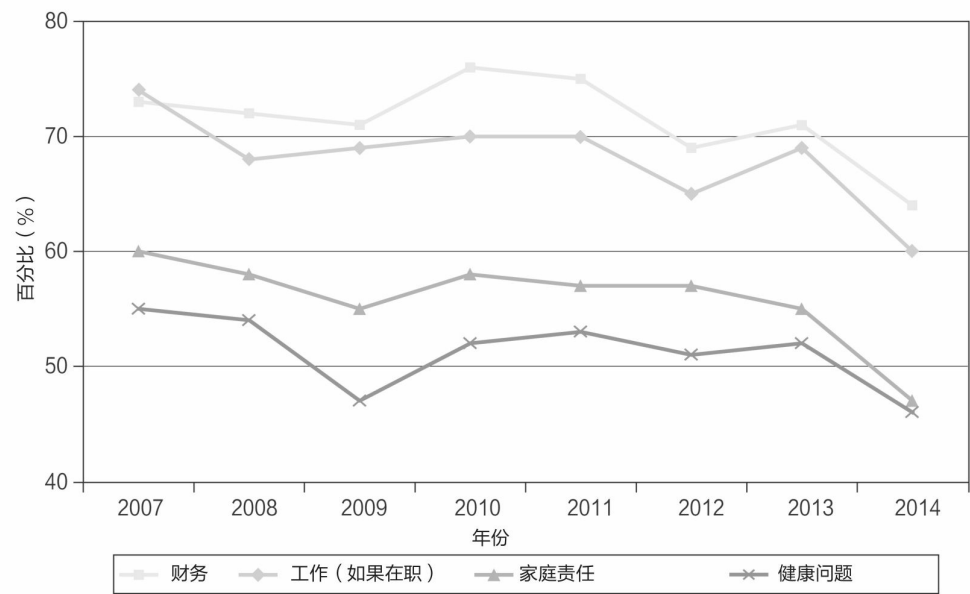


图8-3 成年人的担忧

随着人们步入中年，财务、工作、家庭、健康和安全问题变得越来越重要。

资料来源: American Psychological Association, *Stress in American: Paying with our Health*, February 4, 2015.

大多数人的中年时期都是健康的。人口统计数据显示，大多数中年人报告自己没有慢性疾病，也没有任何行动不便。

从某些角度来说，这一时期人们的健康状态比生命的早期阶段更好。45~65岁的人罹患感染、过敏、呼吸疾病以及消化系统疾病的可能性比青年人更小，因为如果他们之前患过类似的疾病，就可能对这些疾病产生免疫力。

有些慢性疾病则始于中年时期。关节炎一般在人们40岁后出现，糖尿病在50~60岁更容易出现，肥胖的人尤其容易患糖尿病。高血压是最常见的慢性疾病之一，通常被称作“沉默的杀手”，因为它的症状不明

显，但如果放任不管，它就会增加个体患中风和心脏病的风险。正是由于这些原因，笔者强烈推荐中年人做一些预防和诊断性的医学检查，具体可参照表8-1（Walters & Rye, 2009）。

表8-1 关于成人预防性健康筛查的建议

以下是为没有任何症状的健康成年个体提供的全面指导。此外，还有一些附加指导：对女性的附加指导，包括乳腺检查、乳房X射线检查、巴氏涂片法检查以及盆腔检查；对男性的附加指导，包括前列腺特异性抗原测试和睾丸自我检查。

检验项目	说明	40 ~ 49 岁	50 ~ 59 岁	60 岁以上
血压	用来探测高血压，高血压可能导致心脏病、中风或肾脏疾病	每 2 年 1 次	每 2 年 1 次	每 2 年 1 次，如果家庭病史中有高血压患者，则每年 1 次
胆固醇——所有或高密度脂蛋白	用来探测会提高心脏病发生风险的高胆固醇水平	所有成人应至少接受 1 次所有胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇以及甘油三酯检查，根据心脏病风险因素和脂蛋白检查的结果，医生将为你决定之后的检查频次		
视力检测	用来确定是否需要戴眼镜或更换眼镜	每 2 ~ 4 年 1 次，糖尿病患者每年 1 次	每 2 ~ 4 年 1 次，糖尿病患者每年 1 次	每 2 ~ 4 年 1 次，65 岁以上者每 1 ~ 2 年 1 次，糖尿病患者每年 1 次
乙状结肠病检查或双重对比剂钡灌肠造影检查或结肠镜检查	用显示器或 X 射线探测结肠或直肠癌症状	—	以 50 岁为基线，第一次检验后每 3 ~ 5 年检查 1 次	每 3 ~ 5 年 1 次，终止年龄由健康状况决定，一般在正常结肠镜检查后 8 ~ 10 年
粪便潜血检查	检测粪便中隐藏的血液，隐藏血液是结肠癌的早期信号	—	每年 1 次	每年 1 次
直肠检查（数字化）	检验前列腺或卵巢以探测癌症症状	—	每年 1 次	每年 1 次
尿检	检验尿中是否出现过多蛋白质	每 5 年 1 次	每 5 年 1 次	每 3 ~ 5 年 1 次
免疫力（注射） 破伤风	受伤后避免感染	每 10 年 1 次	每 10 年 1 次	每 10 年 1 次
流行性感冒（流感）	抵抗流感病毒	所有处于长期治疗的人，如心脏、肺、肾脏疾病、糖尿病患者	50 岁以上，每年 1 次	65 岁以上，每年 1 次
肺炎球菌	抵抗肺炎			65 岁时，之后每 6 年 1 次

各种慢性疾病的产生使中年时期个体的死亡率比早年时期要高。尽管如此，中年时期的死亡率依然不高：每 100 个 40 岁的人中，预计只有 3

人在50岁之前死亡；每100个50岁的人中，预计有8人在60岁之前死亡。此外，在过去50年中，40~60岁的人的死亡率急剧下降，与20世纪40年代相比，现在的该项数据值只是当时的一半。另外，健康问题还存在文化多样性（Smedley & Syme, 2000），这也是我们接下来要在“文化维度”专栏中讨论的。

文化维度

健康的个体差异：族群和性别差异

中年群体的整体健康状况数据中包含着大量的个体差异。大多数人是健康的，而有些人却被疾病困扰。遗传具有一定的影响，例如高血压通常会在家族中遗传。

社会和环境因素对中年个体的健康也有很大的影响。例如，非裔美国人中年时期的死亡率是白人的两倍。为什么会这样呢？

社会经济地位是一个重要的因素。社会经济地位处在相同水平的白人和非裔美国人中，非裔美国人的死亡率比白人还低一些。低收入家庭中的成员更有可能受伤或致残，造成这一结果的原因有很多。一是低社会经济地位的家庭成员更容易从事一些危险的工作，如当矿工或建筑工人。二是低收入人群的健康护理条件更差。三是低收入者聚居的社区，其犯罪率 and 环境污染程度也更高。因此，较高的意外发生率与健康风险影响了低收入家庭的死亡率

（Fingerhut & Makuc, 1992; Dahl & Birkelund, 1997; Hendren, Humiston, & Fiscella, 2012）。

不同性别之间的健康状况也有所差异。女性总体的死亡率比男性低，这种趋势从出生开始便存在，但中年女性患各种疾病的比例更高。

女性更容易患上轻微、短期或慢性但不会危及生命的疾病，如偏头疼，而男性则更容易患非常严重的疾病，如心脏病。女性吸烟的人数较少，因此她们患癌症和心脏病的风险较低；相对于男性，女性更少饮酒，这降低了她们患上肝硬化和遭遇交通事故的风险；另外，她们很少从事危险的工作也是死亡率较低的原因之一（McDonald, 1999）。

女性患有较多疾病的另一个原因可能是，更多的医学研究都是针对男性及其疾病的。大量的研究经费都用在了研究男性更容易罹患的、会威胁生命的疾病，如心脏疾病上，而不是用在一些慢性疾病上。慢性疾病虽然会带来不适和痛苦，但不会导致死亡。而且对于男女都易患上的疾病，更多的研究也集中在男性被试上。美国国家卫生研究院（National Institute of Health, NIH）正在采取措施消除这一偏见，但不可否认，历来的模式都是以男性为主要研究群体的（Vidaver et al., 2000）。

虽然压力可能来自不同的方面，但和成年早期一样，压力仍然是影响个体健康的重要因素。比如，成年早期父母可能会为自己的小婴儿是否不该再用奶嘴而忧心忡忡，而在成年中期家长则可能担心自己青春期的孩子滥用药物。

无论给人们带来压力的原因是什么，其结果都是相似的。心理神经免疫学家研究了大脑、免疫系统和心理因素之间的关系，发现压力会导致三种主要的结果（见图8-4）。首先，压力会直接引发一系列生理反应，包括血压升高和激素活动增加，从而降低免疫系统的反应；其次，压力会使人们开始进行一些不健康的活动，如减少睡眠、吸烟、饮酒或使用药物；最后，压力会间接影响一些与健康相关的行为。在巨大的压力下，人们寻求良好的医疗护理、进行运动或遵照医生建议的可能性会大大降低。这些都会给人们带来健康问题，包括诱发心脏病（Ihle et al., 2012; Emery, Anderson, & Goodwin, 2013; de Frias & Whyne, 2015）。

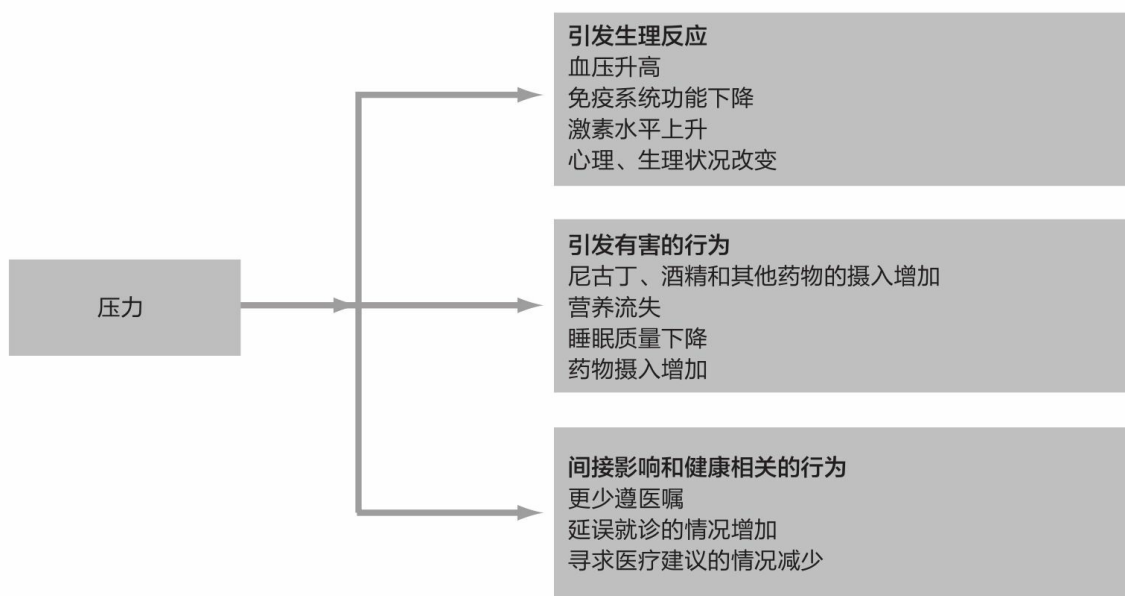


图8-4 压力带来的后果

压力会造成三种主要的后果：引发生理反应、引发有害的行为、间接影响和健康相关的行为。

资料来源：Baum, 1994.

心脏病和癌症：中年时期的重要烦恼

学习目标**8.4** 描述引发中年个体心脏病和癌症的危险因素及预防措施。

相对于其他各种原因，男性死于心脏和循环系统疾病的人数要多于女性。虽然女性较少患此类疾病，但这并非意味着她们对这些疾病有免疫力。每年因这些疾病而死亡的65岁以下的人约有15.1万，由此导致的失业和住院治疗时间比其他因素造成的都多（American Heart Association, 2010）。

A型人、B型人与心脏病：健康与人格 虽然心脏和循环系统疾病是主要的健康问题，但有些人面临该风险的可能性要小很多。这两项疾病导致的死亡率在某些国家要更低一些，如日本的只是美国的1/4，而在有些国家的死亡率却高很多，为什么呢？

答案是这两项疾病都和遗传及环境有关。有些人先天患心脏病的风险就高。如果一个人的父母患有此疾病，那他患病的可能性就会较高。同样，性别和年龄也是相关因素，男性更容易患心脏病，且患病风险会随年龄的增长而增加。

生活方式的选择也非常重要。吸烟、食用脂肪和胆固醇含量高的食物、缺乏运动都会增加罹患心脏病的风险。这些因素也许能解释为什么不同国家心脏病的发生率差异如此之大。例如在日本，心脏病导致的死亡率较低，可能是由于日本人饮食中的脂肪含量相比美国的来说低了很多（De Meersman & Stein, 2007; Scarbrough et al., 2012; Platt et al., 2014）。

心理因素，特别是如何认知和体验压力似乎也和心脏病有关，比如不同人格特征的人患心脏病的概率就有所不同。很多人都熟知的A型行为模式，就是导致冠心病发病的一个因素。

A型行为模式（Type A behavior pattern）是指竞争性高、缺乏耐心、容易挫败且容易对他人怀有敌意的行为模式。A型人充满野心，他们总会同时进行多项活动。他们是真正的多重任务执行者，你会常常看见他们在同一时间做多个工作——在上班的车上一边打电话，一边用笔记本电脑工作，还同时吃着早餐。他们很容易发怒，当无法达到目标时，他们的语言和行为都会充满敌意。

与此相反，有些人是截然相反的人格，即表现为B型行为模式（Type B behavior pattern）。B型人表现为没有竞争性、有耐心、攻击性低。与A型人不同，他们很少有时间紧迫感，并很少怀有敌意。

在中年时期这种分类变得很重要，因为研究显示，不同类型的性格与个体患冠心病的风险有关。A型人患冠心病的概率是B型人的2倍，前者致命心脏疾病发作的次数更多，各种心脏问题的患病率是B型人的5倍（Strube, 1990; Wielgosz & Nolan, 2000）。

不过有些批评者认为，那些支持A型和B型行为模式存在的证据是有问题的。而且一些证据表明，A型行为模式中只有某些特质会导致疾病，而不是整个行为模式。目前看来，A型行为模式中的敌意和愤怒成分是导致冠心病的主要原因（Demaree & Everhart, 2004; Eaker et al., 2004; Kahn, 2004; Myrtek, 2007）。



除了具有好胜的特征之外，A型人也倾向于进行多项活动，或者同时做许多事。A型人与B型人

应对压力的方式是否有差别？

虽然A型行为模式和心脏病的关系相对明确，但这并不意味着A型的中年人都会患冠心病。除了A型人的敌意之外，其他一些负性情绪也与心脏病有关。例如，心理学家约翰·德诺列特（Johan Denollet）描绘了一种D型行为模式，即抑郁，也与心脏病有一定的关系。他认为那些不安、焦虑、消极观念会让个体更容易罹患心脏病（Mols & Denollet, 2010; Kupper et al., 2013; van den Tooren & Rutte, 2016）。

癌症的威胁 很少有疾病会像癌症一样可怕，很多中年人都把癌症看作死亡判决。虽然实际情况并不尽然，因为很多种癌症经过治疗后个体反应良好，有40%被诊断为癌症的患者能活5年以上，但癌症还是引发了很多恐慌。不过不能否认的是，在美国，癌症是导致人们死亡的第二大原因（CDC, 2015）。

引发癌症的确切因素尚不清楚，但它的扩散过程却很明确。体内的癌细胞会无法被控制并迅速地繁殖。当达到足够多的数量时，这些细胞就会形成肿瘤。它们将不断地摄取健康细胞和身体组织中的营养，并最终破坏身体机能。

和心脏病一样，癌症的发病也与遗传因素有关，有些癌症有明显的遗传成分。如可能导致女性死亡的最常见癌症之一乳腺癌，如果家族史中有该疾病，那么家族中的女性患乳腺癌的风险就更高。

一些环境及行为因素也与癌症的发病有关。营养不良、吸烟、饮酒、暴晒、暴露在有放射性物质的条件下、从事某些比较危险的职业（如接触特定的化学物质或石棉）等情况，都会提高个体罹患癌症的可能性。

不同的癌症类型有多种不同的治疗方法：比如放射性治疗，即用射线来照射肿瘤，从而达到破坏和消灭肿瘤的效果的治疗方法；比如化疗，即让患者通过摄取一定量的有毒物质来毒化肿瘤，然后进行手术切

除肿瘤及其周围的一些组织。治疗方法的选择取决于首次确诊时癌细胞扩散的情况。

越早发现癌症越有助于治疗，因此根据初期症状来识别癌症的诊断技术非常关键。中年人患癌症的风险有所增加，因此早期的准确诊断对他们来说尤为重要。

医生建议，女性要定期进行乳房检查，男性要定期进行睾丸检查，以查看是否有患癌症的迹象。前列腺癌是最常见的男性癌症，通过常规的直肠测验和血液化验来鉴别前列腺特异性抗原（prostate specific antigen, PSA），可以探测人们是否患病。

乳腺X射线摄影检查可以通过扫描女性乳房的内部来发现癌症的早期征兆。然而，从什么时候开始做乳腺X射线摄影检查仍然存在争议。女性患乳腺癌的风险在30岁左右就开始出现并不断增加，95%的新病例都是在40岁及以上的女性中发生的（Surveillance, Epidemiology and End Results Program, 2005）。

难以确定何时开始进行例行的乳腺X射线摄影检查的原因主要有两点。其一是假阳性，即检查结果显示身体有问题但实际上并没有。相比于年长的女性，年轻女性乳腺的血管更加密集，因此更容易出现假阳性的情况。事实上，一些数据显示，大约有1/3进行例行乳腺X射线摄影检查的年轻女性会出现假阳性的情况，需要进一步的检查。其二是假阴性，即在患者已经患癌的情况下并没有被检查出癌症的迹象（Destounis et al., 2009; Elmore et al., 2009; Armstrong et al., 2013）。

争论还未结束，2009年美国指定的一支专家组——美国预防服务工作组（U. S. Preventive Services Task Force），建议40~50岁的女性无须进行乳腺X射线摄影常规检查，50~74岁的女性每两年检查一次即可，而不是每年一次。他们的建议是基于一项成本效益分析，该分析显示，这样安排可以将乳腺X射线摄影检查给身体带来的伤害减少一半，而效果又相当于每年检查一次的80%（Nelson et al., 2009）。

他们的建议立刻遭到了一些组织的批评，包括美国癌症协会、美国放射学会。这些组织仍坚称40岁以上的女性应该接受每年一次的检查（Grady, 2009）。

从根本上说，何时进行检查主要基于个体的具体情况。女性应该咨询相关的医生，了解最新的乳腺X射线摄影研究成果后再做出决定。但可以肯定的是，对那些有乳腺癌家族病史或是发生BRCA基因⁽²⁵⁾突变的女性来说，从40岁起就开始乳腺X射线摄影检查无疑是好处多多（Grady, 2009; Alonso et al., 2012; Smith, Duffy, & Tabár, 2012）。

从研究到实践 对重大疾病进行基因检测是个好主意吗

2013年，著名女演员安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）在《纽约时报》的一篇文章中宣布，她将接受双乳切除术，这个消息让很多人大吃一惊。她决定做手术的原因更令人惊讶——仅仅是她很有可能在一生中的某一时刻患癌症。事实上朱莉并没有真的患癌症，只是她的母亲在50多岁时患卵巢癌去世了。朱莉曾进行过基因检测，她发现自己的抑癌基因出现了一种罕见的突变。这意味着她患乳腺癌的风险接近90%。由于担心会像母亲一样早逝，朱莉决定进行预防性双侧乳房切除术，这将她患乳腺癌的风险降低到了5%（Kluger & Park, 2013）。

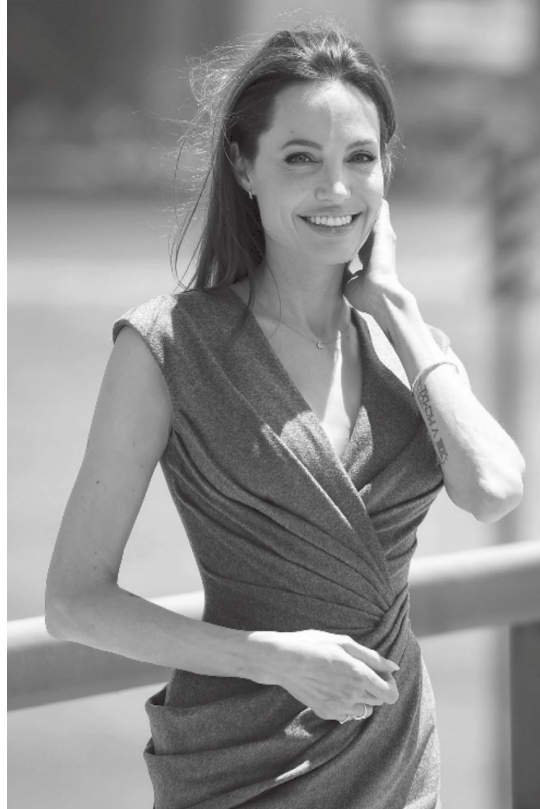
如今，成千上万的基因测试可以帮助人们确定许多特定疾病的遗传风险。朱莉的经历无疑会激励许多人进行基因检测，以规避患上重大疾病的风险。

但很多人的检测结果并不像朱莉的那样清晰可靠。因为许多疾病与多种基因病变有关，这会使结果复杂化。有时并不能确定检测出来的变异对疾病究竟会造成何种影响，而且环境因素和生活方式对疾病的影响也不可忽视。即使人们检测出在遗传因素上有很大的患病风险，也很难找到一个安全有效的预防措施——双乳切除术仅是一个个例而已（Vassy et al., 2012; Easton et al., 2015）。

当下的宣传并没有明确地告诉大众基因检测所能达到的效果以及它的局限性，而这正是医学专家所担心的。相比干巴巴的数据，生动鲜活的个例更容易说服人们。朱莉接受双乳切除术并不是基于对客观风险的充分理解，而是因母亲过早离世带来的恐惧。双乳切除术对朱莉来说确实能够起作用，但是这并不是唯一的选择，比如还可以进行预防性的化疗或者对早期信号进行高频率的监控等。适当的咨询对人们理解检测结果和选取不同的应对方式至关重要（Riley et al., 2012）。

成本问题也不容忽视。接受基因检测并进行随后的预防性和恢复性手术以及后续的护理，对一个著名的好莱坞演员来说可能不算什么，但对一般人来说就不那么简单了。基因检测费用昂贵，保险公司并不愿意无缘无故地为此买单，就像他们不肯为有家族病史的疾病进行理赔一样。因此人们在决定寻求基因检测之前，需要仔细考虑很多问题。朱莉的大胆决定对她来说可能很好，但并不适用于每一个人（Riley et al., 2012; Kluger & Park, 2013）。

为什么人们想知道自己患某种很难治愈和预防的严重疾病的风险？你想知道你自己的风险吗？为什么？



安吉丽娜·朱莉进行了双乳切除术，以降低其患乳腺癌的风险。

回顾、检测和应用

回顾

学习目标**8.1** 描述影响成年中期个体的生理变化。

成年中期个体经历着身体特征和外观的逐渐变化。个体可以通过定

期锻炼和健康饮食控制体重。在中年时期，个体感官的敏锐度，尤其是视力、听力和反应速度都略有下降。

学习目标8.2 分析成年中期个体性行为变化的本质。

个体在中年时期的性行为略有改变，但从生育和育儿中解脱出来的夫妇，可以享受到一种新水平的亲密和愉悦。影响性行为的生理变化在男女双方中都有发生。女性更年期和男性更年期似乎都有一些生理和心理上的症状。

学习目标8.3 描述成年中期一般个体的健康状况。

一般来说，虽然个体在成年中期易患一些慢性疾病，如关节炎、糖尿病和高血压，但这依然是一个相对健康的时期。在成年中期，压力会继续对人们的健康产生重大影响，导致直接的生理影响、不健康的生活方式选择，并间接影响其他与健康相关的行为。

学习目标8.4 描述引发中年个体心脏病和癌症的危险因素及预防措施。

心脏病对中年人来说是一种潜在的风险。遗传和环境因素都会影响心脏病的发病率，这些因素包括A型行为模式等。癌症的确切病因尚不明确，但其扩散过程相对明了。放疗、化疗、手术等疗法都能成功治疗某些癌症。

自我检测

1. 人们听高音调、高频率声音的能力下降被称为_____。
 - a. 青光眼
 - b. 老年性耳聋

- c. 骨质疏松
 - d. 老花眼
2. 女性从能够生育到不能生育转变的这段时期被称为_____。
- a. 中年转变
 - b. 围绝经期
 - c. 女性更年期
 - d. 产后期
3. 下列哪一项是个体在成年中期承受压力时的直接后果？
- a. 药物使用与药物滥用
 - b. 不遵照医嘱
 - c. 失眠
 - d. 免疫力降低
4. 不安全感、极端的野心、焦虑和敌意会增加个体心脏病发作的风险。这种行为模式被称为_____。
- a. A型行为模式
 - b. 双重人格
 - c. B型行为模式
 - d. 高血压

应用于毕生发展

怎样的社会政策可以减少低收入人群伤残情况的发生？

8.2 成年中期的认知发展

接受挑战

吉娜总是喜欢挑战。这也是她喜欢参加《危险边缘》智力竞答电视节目的原因。“为什么只有年轻人才能享受乐趣？”她笑着问，“我46岁了，很有经验。”该竞赛要求快速思考和反应。尽管经验丰富，但她是否会担心被那些年龄只有她一半的选手打败？“不会的，”她说，“丈夫和我每天吃早饭的时候都会猜谜。”吉娜的阅读量也很大。“每读完一本书，我都会做笔记。”她解释说，“我能记住很多东西，不仅仅是主角的名字和情节。”她也喜欢科学、历史和世界大事。“我最喜欢脑科学方面的书，”她说，“因为它们发现了老年人也能学会新的技能。”

和许多中年人一样，吉娜很享受心智方面的挑战，这能让她保持良好的状态。她非常自信地参加比拼智力和反应的比赛，与年龄只有她一半的人竞争。她知道自己有年轻人不具备的优势——阅历和知识。

在本节，我们将集中介绍个体在中年时期的认知发展。我们将讨论一个很难且无法全面回答的问题：个体在中年时期智力是否会下降？我们还将考察这一时期人们的记忆力会有何改变。

智力和记忆会下降吗

实在是糊里糊涂得可以——45岁的比娜想不起来她是否寄出了丈夫交代她要寄出的信，一瞬间她甚至怀疑这是不是自己老了的预兆。第二天，当她花了20分钟来找她写在某张纸上的电话号码时，同样的问题再次浮现。她找到号码时有些惊讶，还有些焦虑。“我的记忆力是不是减退了？”她充满烦恼、忧心忡忡地问自己。

很多40多岁的人都觉得和20年前相比，自己变得健忘了很多，并担心智力也会随着年龄的增长而衰退。常识告诉我们，人们的智力在中年

时期会有一些减退。但这种观点准确吗？

智力会在成年期下降吗

学习目标**8.5** 分析成年中期智力的性质及其变化情况

很多年来，研究者都认为人们的智力会在成年后下降：智力的顶峰时期是在18岁左右；之后会保持一段时间，直到25岁左右；然后开始渐渐下降，直到生命结束。

现在，发展心理学家有关智力毕生发展的观点已经全面很多了，他们得出了和此前不同且更复杂的结论。

回答这个问题很难 大量的研究表明，个体的智力会在25岁左右开始下降。横断研究，即在同一时间点取不同年龄段的被试进行测试这一研究方法清楚地显示出，年长的被试在传统的智力测验中的得分要比年轻被试低。

但横断研究也有其缺点，尤其是可能会出现我们在第1章提到过的同辈效应。比如，假设横断研究中年长的被试可能比年轻被试接受的教育少、工作刺激性低或者健康状况更差，在这样的情况下，横断研究得出的智力差异结果就不能部分或完全地归因于年龄。因为没有控制同辈效应，横断研究很可能低估了年长被试的智力。

为了克服横断研究中的同辈效应，发展心理学家们开始使用纵向研究。这些研究揭示了不同的智力发展模式：成人的智力测验得分到35岁左右都能保持稳定甚至有所增长，有些情况下甚至可以持续到50多岁，之后智力测验的得分开始下降（Bayley & Oden, 1955）。

但纵向研究也有不足之处。个体重复地做相同的智力测验，那么他们的得分增加可能是因为他们更熟悉或更适应于测验场景。同样，经过重复测验，他们可能会记住一些项目。最终，练习效应可能提高了他们

的表现，使纵向研究的结果正好与横断研究相反（Salthouse, 2009）。

另外，保持样本完整对研究者来说也很困难。被试可能会搬迁、不愿再做实验或者生病甚至死亡。经过一段时间后，相对于流失的被试，留下的可能是一群较健康、更稳定且心理学角度上更优的样本。如果是这样，那纵向研究结果就高估了年长被试的智力。

晶体和流体智力 我们很难对与年龄相关的智力变化下定论。比如，智商测验的有些部分是需要动手完成的，如堆积木。这些测试会进行计时，并依据完成时间来打分。如果年老的被试花了更长时间，那么他们在智商测验上不好的表现也许应该归因于生理因素，而非认知的改变，可别忘了，反应时在中年时期会变慢。



评估个体中年时期的智力很困难。也许有些心理能力会开始下降，但是晶体智力会保持恒定，事实上还有一定的增长。

中年时期个体智力难以评估的原因在于，很多研究者认为人们存在两种不同类型的智力：流体智力和晶体智力。

当发展心理学家们分别考察两种智力时，对中年时期个体的智力是否会下降的问题给出了两个答案：“是”和“否”（见图8-5）。是，是因为流体智力的确会随年龄的增长而下降；否，是因为晶体智力保持恒定，

而且实际上还有所增长（Salthouse, Pink, & Tucker-Drob, 2008; Deary, 2010; Ghisletta et al., 2012; Manard et al., 2015）。

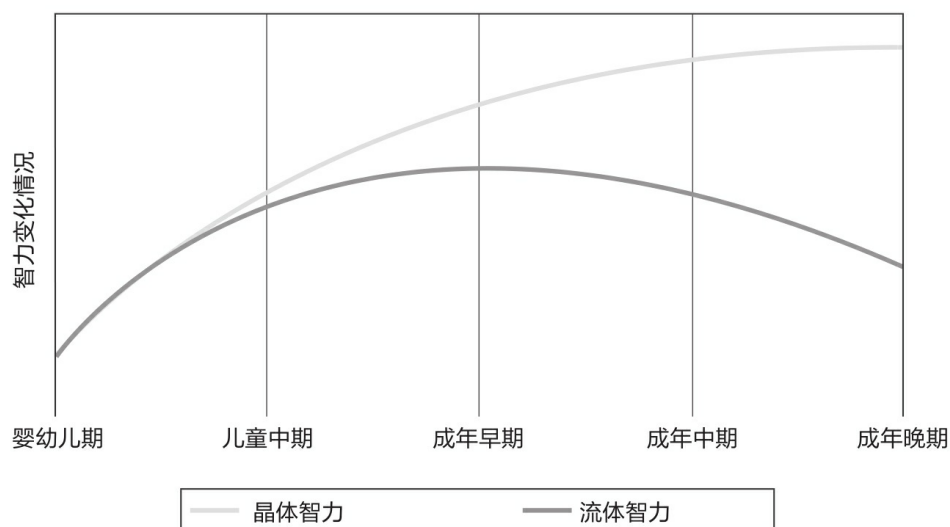


图8-5 晶体智力和流体智力的变化

晶体智力随着年龄的增长而增加，流体智力则在中年时期开始出现递减。这说明中年时期的整体智力是什么样的？

资料来源：Schaie, 1994.

如果我们能更细分智力的类型，那么与年龄相关的变化和发展特点都会显现出来。发展心理学家沙因曾进行过大量关于成人智力发展的纵向研究，他认为我们应该把智力分成多种类型，如空间定位、数字能力、言语能力等，而不是笼统地分成流体和晶体两种（Schaie, Willis, & Pennak, 2005）。

通过这种检验，成人智力的变化情况就有了更具体的描述。沙因发现，归纳推理、空间定位、速度知觉和言语记忆等能力会在人们25岁及以后的时间中缓慢下降。个体的数字和语言能力则显示出不同的变化模式，其数字能力到40多岁还在上升，到60岁有所下降，之后保持稳定；言语能力在大约40岁的成年中期前都在提升，之后会保持恒定（Schaie, Willis, & Pennak, 2005）。

人们会发生这些智力改变的一个原因是，中年时期大脑功能会发生变化。研究者发现，在学习、记忆和心理灵活性上起关键作用的20种基因的效用，在40岁时就开始减弱了。而且，随着个体年龄的增长，其完成特定任务所对应的脑区也发生了变化。例如，年轻个体只使用单一大脑半球完成任务，而年长的个体则需要大脑的两个半球同时参与完成任务（Fling et al., 2011; Phillips, 2011; Bielak et al., 2013）。

重新面对这个问题：成年中期个体竞争力的源泉是什么 尽管一些特定的认知能力会在成年中期逐渐下降，但也正是在生命的这个阶段，人们开始在社会中拥有一些最重要和最有权势的职位。应该怎样解释这种还在持续甚至增长的竞争力呢？

发展心理学家蒂莫西·索尔特豪斯（Timothy Salthouse, 1994, 2010）认为，这种矛盾存在的原因有四种。第一，很可能是由于典型的测验考查的认知能力与在特定职位上取得成功所需要的能力不同。回忆一下之前讨论的实践智力，我们会发现，传统的智商测验并不能测量与职业成功相关的认知能力。如果我们测的是实践智力而不是传统智商测验评估出的智力，也许就不会出现成年中期个体智力和认知能力下降与其实际竞争力上升之间的矛盾了。

第二个原因同样与智商测验和职场成功有关。可能最成功的中年人并不能代表整体中年人。可能只有很少一部分中年人成功了，剩下的人很可能只有很小的成就或没有什么成就，他们也许换了工作、退休或病倒，甚至死亡。那些非常成功的人也许不是有代表性的样本。

第三，可能是职业成功所要求的个体认知能力并不是特别高。这种观点表明，人们可以获得职场的成功，但同时某些认知能力也在下降。换句话说，智力够用就行。

第四，年长个体能够成功可能是由于他们发展出了特定类型的专业技能和特殊能力。智商测验测的是个体对新异场景的反应，而职场成功也许依赖于非常专业和训练良好的能力。结果就是，尽管整体智力在下

降，但中年个体仍然可以维持甚至拓展他们要取得专业成就所需的特定才能。这种解释开拓了新的研究方向，即对专业技能的研究。

从教育工作者的视角看问题

你认为返回学校求学的中年人，其不断下降的智商测验成绩和持续发展的认知能力之间的明显矛盾，对其学习能力有何影响？

比如，发展心理学家保罗·巴尔特斯和妻子玛格丽特·巴尔特斯（Margaret Baltes）提出了一种叫选择性最优化补偿的策略。选择性最优化（**selective optimization**）是指个体通过集中发展某种特定技能，来补偿其他领域能力损失的过程。保罗·巴尔特斯认为，成年中期和晚期个体的认知能力发展是一种增加和降低的混合发展。人们在某些能力丧失的同时，又通过强化其他领域的技能来提升自己，以此避免其实质性的衰退。由此，个体的总体认知能力就可以保持不变，甚至还可能增加（Ebner, Freund, & Baltes, 2006; Erber, 2010; Deary, 2012）。

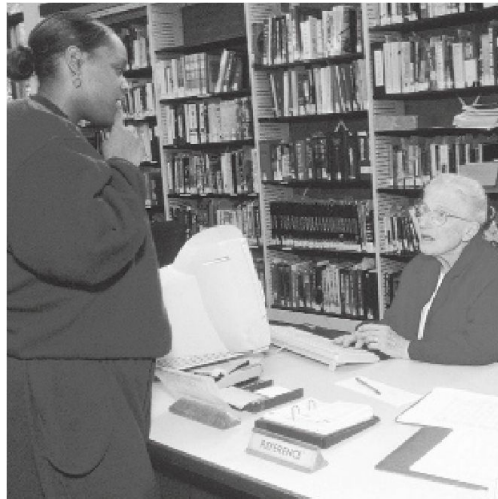
选择性最优化补偿是成人用来优化个人能力表现的策略之一。正如我们接下来要介绍的，专业知识的逐步发展也使人们在中年时能够保持甚至提高自己的能力水平。

专业技能的发展：区分专家和新手 如果你生病了需要就诊，你是更愿意找一个刚从医学院毕业的新大夫还是找一个经验丰富的中年医生呢？

如果你选择的是中年医生，那你很可能认为他拥有更多的专业技能。专业技能（**expertise**）是指个体对特定领域技能或知识的掌握。相比广义的智力，专业技能的范围更加集中。当人们在某领域集中精力进行练习，并借此来获取经验时，其专业技能就能得到发展，如医生随着经验的积累而变得更善于诊断病症，一个有丰富烹饪经验的人知道怎样

改变菜肴的配料以改变其味道（Morita et al., 2008; Reuter et al., 2012, 2014）。

是什么区分了专家和新手？初学者会采用正式的程序和规则，且常常严格遵循这些程序和规则；而专家则依赖经验和直觉，还时常会打破规则。他们的经验使其能自动化地加工信息。专家们通常无法清晰地描述和解释他们是如何得出结论的，只是自认为正确，事实上也很可能如此。脑成像研究显示，专家在解决问题时所用的脑区与新手是不同的（Grabner, Neubauer, & Stern, 2006）。



个体在成年中期和晚期的认知发展是增长和降低的混合过程。他们随着生理衰退丢失了某些能力，同时也会通过加强某些领域的技能而使总体的认知能力得以发展。

相对于非专家，专家们有更好的问题解决策略，而且方法更灵活。专业技能为他们提供了更多的解决方法，并提高了成功的可能性

（Willis, 1996; Clark, 1998; Arts, Gijselaers, & Boshuizen, 2006; McGugin & Tanaka, 2010）。

并不是所有人在中年时期都能发展出某领域的专业技能。职业责任感、闲暇时间的多少、教育水平、收入和婚姻状况都会对人们专业技能的发展产生影响。

老化是如何影响记忆的

学习目标8.6 描述衰老对记忆的双重影响。

玛丽无论什么时候找不到车钥匙，都会自言自语地说她“记忆丧失”了。就像担心不能记住字母和号码的比娜，玛丽可能认为记忆的减退在中年时期很普遍。然而，如果她的情况和典型的中年群体一样，那她就不该这么想。研究显示，大多数人会有轻微的或根本没有记忆的损失。由于社会的刻板印象，即使人们的记忆力一直都是如此，他们也可能把健忘归因于衰老。也就是说，人们往往将健忘归因于记忆力的改变，而不是记忆力实际就是如此（Chasteen et al., 2005; Hoessler & Chasteen, 2008; Hess, Hinson, & Hodges, 2009）。

记忆的类型 为了解记忆变化的本质，我们需要知道传统上记忆可分为三个连续的成分：感觉记忆、短时记忆和长时记忆。感觉记忆是对信息最初短暂的保存，只能保持一瞬间，信息被个体的感觉系统当作原始、无意义的刺激记录下来；然后信息进入可保持15~25秒的短时记忆；如果之后信息能被复述，那就能进入长时记忆，并在此相对长久地保存。

感觉记忆和短时记忆在成年中期都不会减退，长时记忆则对一些人来说有所衰减。这种减退并不是消退或完全丧失，而是随着年龄的增加，个体编码和存储信息的效率降低了。此外，衰老使人们提取信息的效率也变低了。即使信息完好地储存在长时记忆系统中，个体定位和提取这些信息也会出现困难（Salthouse, 2006, 2010）。

中年时期个体记忆的减退非常微小，在多数情况下可以通过其他认知策略进行补偿。对初次出现的信息给予更多的注意有助于日后的回忆，比如你丢失了车钥匙跟你没有留意你所放的位置有关，而非由于记忆减退了。

正如我们讨论的专业技能发展的原因一样，很多中年人发现很难在某些事情上集中注意力。他们习惯利用捷径、图式来减轻日常繁杂事物

的记忆负荷。

记忆图式 为了回忆信息，人们常常使用图式（**schemas**），即存储在记忆系统中的有条理的信息体。图式是对世界组织方式的表征，可以帮助人们对新信息进行分类和解释。比如，如果我们有在餐厅里吃饭的图式，那么在一家新的餐厅进餐就不会是完全陌生的经历了。我们知道去餐厅时，应该坐在桌前或在柜台前，拿着菜单点菜。我们有关在外吃饭的图式能告诉我们应该如何对待服务生，最先吃哪种食物以及在餐后留下小费（Hebscher & Gilboa, 2016）。

人们拥有关于个体（比如母亲、妻子和孩子特有的行为模式）、各类人群（邮递员、律师或教授）以及行为事件（在餐厅就餐或看牙医）的各种图式。图式帮人们将行为组织成有机的整体，还能解释社会事件。如果一个人拥有看医生这一事件的图式，那么他在就医时被要求脱衣服就不会感到惊讶。

图式还能传递文化信息。心理学家苏珊·菲斯克（**Susan Fiske**）和雪莱·泰勒（**Shelley Taylor**）在1991年发表的文章中，用一个古老的美国印第安人的民间故事来解释其中的原理。故事讲述了一个英雄和他的同伴在一场战争里被箭射中，但他并没有感到疼痛。当英雄回到家并讲述这个故事时，一个黑色的东西从他嘴里飘了出来，他在第二天就死了。

这个故事使很多人感到迷惑，因为他们没有接触过故事中包含的印第安文化的特殊之处。然而对那些熟知该文化的人来说，故事就很好理解：英雄没有感到疼痛是因为他的同伴是鬼魂，而从他嘴里出来的黑色东西是他正在离体的灵魂。

让印第安人来回忆这个故事可能会很容易，因为他们能够理解故事，而其他文化中的人却不能。相比没有图式可匹配的材料，能够与已有的图式匹配的材料会更好记（见“成为发展心理学知识的明智运用者”专栏）。比如，一个习惯于把钥匙放在钱包里的人，在把钥匙放在柜子上后可能就记不起来了，因为柜子并不是“通常的地点”（Tse &

Altarriba, 2007)。

成为发展心理学知识的明智运用者 如何使用记忆术进行记忆

所有人都有健忘的时候，但有些技术可以帮我们更有效地回忆。记忆术（**mnemonics**）是一种把信息组织得更容易记忆的正式策略。记忆术的运用方法如下（Bloom & Lamkin, 2006; Morris & Fritz, 2006）。

- 进行组织。对那些想不起钥匙放在了哪儿了或有什么约会的人来说，最简单的解决办法就是让他们把信息条理化和组织化。例如，准备一个备忘录、把钥匙挂在钩子上，或用便笺纸来帮助记忆。
- 给予注意。对新的信息给予特别的注意有助于改善个体的记忆，要有意识地强调这些信息是以后要回忆的。例如，当你在商场前停车时，就注意在停车的那一刻提醒一下自己：要记住停车的位置。
- 运用编码特异性原则。编码特异性原则指出，如果提取信息时的环境与学习时或编码时的环境相似，那么人们就更容易回忆出信息（Tulving & Thompson, 1973）。例如，学生如果在日常学习的教室里参加考试，他们回忆知识的效果就更好。
- 形象化。建构各种想法的心理图像有助于人们日后对其回忆。例如，如果你想记住全球变暖导致了海面上升，那你可以想象在酷热的一天站在海边，海浪越来越向你靠近的场景。
- 复述。熟能生巧，练习能使记忆完善或有所提高。通过不断练习想要记住的东西，你最终能提高记忆力。

回顾、检测和应用

回顾

学习目标**8.5** 分析成年中期智力的性质及其变化情况。

由于横断研究和纵向研究的局限性，回答成年中期个体智力是否下降的问题变得更加复杂。智力似乎可以被分为不同的部分，一些部分随着年龄的增长在下降，而另一些则相对保持稳定，甚至有所提高。一般

来说，成年中期的认知能力将会相对保持稳定，只是在一些特定的领域有所下降。许多人都会采取一定的策略来优化他们的智力表现。个体一般会通过集中发展特定的技能来弥补他们在其他领域的衰退，这一过程被称为选择性最优化补偿。当人们专注于某一主题或技能并在此过程中获得知识、技能以及经验时，他们的专业技能也会不断发展。

学习目标8.6 描述衰老对记忆的双重影响。

成年中期的个体记忆力似乎在逐渐衰退，但实际上，其长时记忆的缺失可能是由于他们缺乏有效的存储和检索策略。人们会根据自己形成的关于世界是如何组织和运作的图式对新信息进行分类和解释。记忆术能帮人们以更容易被记住的方式组织材料。这些策略包括组织化、形象化、复述、给予注意和使用编码特异性等。

自我检测

1. 根据___研究，即在同一时间点取不同年龄段的人进行测试的结果显示，年长的被试在传统的智力测验上的得分要比年轻被试低。
 - a. 纵向
 - b. 客观
 - c. 横断
 - d. 观察
2. 会随着年龄增长而增加的智力类型是___智力，即个体由长期经验积累获得的信息、技能和策略。
 - a. 情绪
 - b. 晶体
 - c. 内省

- d. 自然
- 3. 很多中年人很难对周围所有事情集中注意力并习惯使用捷径或____，以减轻对日常繁杂事物的记忆负荷。
 - a. 图式
 - b. 心理理论
 - c. 自然观察
 - d. 记忆
- 4. ____是一种把信息组织得更容易记忆的正式策略。
 - a. 记忆术
 - b. 图式
 - c. 知觉
 - d. 启发式

应用于毕生发展

图式怎样帮助中年人获得年轻人没有的优势？

8.3 成年中期的社会性和人格发展

在家庭当中

杰夫与父亲、配偶胡安以及他和胡安共同收养的6岁儿子保罗一起生活。当被问及中年生活如何时，48岁的杰夫笑了。“一切都还不错，”他说，“我20岁的时候一定无法想象自己中年时这种杂乱而又丰富的生活。”杰夫教五年级，他非常热爱这份工作。“身为父母，工作中常

和孩子们在一起能让自己时刻保持警觉。”收养保罗丰富了他的人格。“作为一个同性恋者，在成长过程中，我并没有完全接纳自己。”他承认，“但有了孩子，你就置身于一个人人都会经历的‘为人父母’的社交场景中。现在，我经常和其他的父母一起聊各自的抚养经历，并彼此分担忧虑。”

两年前，杰夫的父亲中风了，并因此导致偏瘫。“我们从来没有相处得这么好过。因为他一直不希望自己唯一的儿子是同性恋。”杰夫说，“但我说：‘你必须搬过来和我们一起住，因为你没有别的地方可去了。’”开始的几个月并不顺利，胡安厌倦了办公室政治，辞去了他在药品研究公司的工作，然后待在家里写一些关于环境问题的文章。不过这个决定很成功。“那之后，胡安变得更快乐了，并且开始有耐心和我爸爸打交道，”杰夫说，“事实上，他改变了我父亲对同性恋婚姻的看法。如今，我们都相处得很好，我爸爸开玩笑说他住在一个‘真正的男人窝’里。”

杰夫和胡安家庭生活模式的复杂和多变并不罕见：很少有人能让生活一直遵循一个固定的、可预测的模式到中年。事实上，个体在成年中期的显著特征之一就是多样性，因为不同的人选择的人生道路开始呈现多样化。在这一节中，我们关注的是个体在成年中期的个性和社会性发展。我们首先会考察这一时期的典型变化，还会探索发展心理学家对中年时期理解上存在的一些争议，包括现今媒体上经常报道的中年危机到底是真是假。

接下来我们就要看个体在中年时期所处的家庭联结是怎样把他们联系在一起或使之彼此分离的，包括经营婚姻、离异、空巢和隔代教养。我们还会探讨家庭关系中阴暗但普遍存在的一面：家庭暴力。

这一节最后考察的是中年时期个体的工作和休闲。我们将探讨工作在个体生活中的作用将如何变化以及一些和工作相关的困难，比如工作倦怠和失业。这一节最后的部分是对中年个体休闲时间的讨论，这一问

题在中年时期变得越来越重要。

人格发展

我的40岁生日可不好过。并不是说这天早晨醒来的感觉有什么不同，而是40岁这一年我开始意识到生命的有限和死亡的迫近。我曾经野心勃勃地幻想自己当上美国总统或某个行业的领军人物，但现在我明白这是不可能的了。时间不再是我的朋友，而更像是我的对手。然而奇妙的是：过去我更关注未来，计划做这做那，但现在我开始感激眼前自己所拥有的一切。我审视自己的生活，对自己的成就很满意。我开始关注那些进展顺利的事儿，而不是我所没有的东西。这种心态并不是在某一天突然产生的，而是在40岁之后，我才意识到这是在之前的几年里慢慢形成的。甚至现在，我也很难完全接受自己已经人到中年的事实。



正如这名男子所说，意识到自己已经进入中年的感觉并不好。在多数社会中，40岁毫无疑问已被认为进入了中年，并且还代表着这些人跨入了“中年危机”的行列。我们接下来就要看看这种看法是否正确，当然，答案取决于你个人的观点。

关于成年人格发展的不同观点

学习目标**8.7** 解释成年中期人格发展的不同观点。

传统的人格发展观点认为，人们会经历一系列固定的发展阶段，每一个都与年龄有着密切的联系。每个阶段都有特定的危机，个体也会从中经历疑惑和心理混乱的紧张时期。这种观点是人格发展的常规危机模型的一个特征。常规危机模型（**normative -crisis models**）将人格发展看作是由连续且与年龄相关的危机组成的一系列阶段，例如埃里克森的心理社会性理论预测人们在一生中将经历一系列阶段和危机。

有些评论家认为常规危机模型已经过时了。这种模型产生于社会角色相对僵化且单一的时期。传统观点认为男性应该工作养家，女性应该相夫教子。这些角色会在相对统一的年龄阶段表现出来。

如今，人们的角色和各阶段的起始年龄都非常多样化。有些人40岁才结婚生子，有些人则更晚，甚至还有些人根本不生孩子，他们会和同性或异性伴侣一起领养或放弃生育一个孩子。总的来说，社会的变迁开始让人们打破与年龄紧密相关的常规危机模型了（Fugate & Mitchell, 1997; Barnett & Hyde, 2001; Fraenkel, 2003）。

从社会工作者的视角看问题

人格发展的常规危机模型在哪些方面是西方文化所特有的？

由于上述变化，如拉文娜·赫尔森（Ravenna Helson）等一些研究者，开始关注生活事件模型（**life events models**），他们认为决定人格发展的不是年龄，而是特定的生活事件。一个21岁生了第一个孩子的女性可能和39岁时才生第一个孩子的女性拥有相同的心理压力。这两名女性虽然年龄不同，但都经历着相同的人格发展（Roberts, Helson, & Klohnen, 2002; Luhmann et al., 2013; Arnarson et al., 2016）。

常规危机模型和生活事件模型哪个能更准确地描绘成年期个体的人格发展情况呢？现在还无法得出肯定的答案。但有一点很清楚，即所有

的发展心理学家都认为成年中期是心理持续且显著发展的时期。

埃里克森理论中的再生力对停滞阶段 正如我们之前讨论的那样，精神分析学家埃里克森把成年中期描述为再生力对停滞（**generativity-versus-stagnation**）阶段。埃里克森认为，一个人的中年时期要么为家庭、社区、工作和社会做贡献，即埃里克森所称的再生力，要么进入停滞状态。具有再生力的人会努力引导和鼓励下一代的发展。人们通常可以通过养育孩子来获得再生力，也可以用其他方法来满足这种需要，如直接和年轻人一起工作，担任他们的导师，或者通过合作具有创造性、艺术性的作品来留下长期的贡献，从而满足其对再生力的需求。当个体能够通过他人看到自己生命的延续时，他对再生力的关注往往就会超越自我（Penningroth & Scott, 2012; Schoklitsch & Baumann, 2012; Wink & Staudinger, 2016）。

心理成长的缺乏会导致个体在这一时期的停滞。这类人把关注点集中在日常琐事中，觉得自己为社会做的贡献很少，存在的价值也很小。有些人仍在挣扎，试图寻找新的、可能更充实的职业，有些人则已经感到挫败并厌倦了。

埃里克森提出了关于人格发展的宽泛观点，但一些发展心理学家建议我们需要更精确地了解中年时期人格的变化。我们接下来将看到三个不同的理论。

建立在埃里克森的观点之上：韦兰特、古尔德和莱文森 韦兰特提出个体在45~55岁有一个重要的时期：“保持意义”对僵化，即除了寻找生命意义的精华所在，成年中期个体还会通过接受他们的优势和不足来寻找“保持意义”的感觉。尽管认识到世界是不完美的，他们还是会努力保卫自己的世界，并相对感到满足。例如本节开头所提到的那名中年人杰夫，他就对自己在生命中发现的意义而感到满足。无法保持生命意义的人就有变得僵化和日益与他人疏远的危险。

精神病学家罗杰·古尔德（Roger Gould）在1978年提出了与埃里克

森和韦兰特的理论不同的一种看法，他认同人们会经历一系列阶段和潜在的危机，并提出成人将经历七个和特定年龄段相关的阶段（见表8-2）。古尔德认为，人们会在40岁左右时，因为意识到时间的有限而感到实现生命目标的紧迫性。对于生命是有限的这一事实的领悟，能使人们变得更加成熟。

表8-2 古尔德的七个发展阶段

阶段	大致年龄	发展情况
第1阶段	16 ~ 18 岁	渴望脱离父母的控制
第2阶段	18 ~ 22 岁	离开家以及开始重新适应同龄人
第3阶段	22 ~ 28 岁	发展独立性以及对职业和孩子的承诺
第4阶段	29 ~ 34 岁	自我质疑，角色混乱，易对婚姻和职业感到不满
第5阶段	35 ~ 43 岁	迫切实现生命目标的时期，意识到时间有限，会重新调整生活目标
第6阶段	43 ~ 53 岁	安心，接受自己的生活
第7阶段	53 ~ 60 岁	更加宽容，接受过往，减少消极性，总体更成熟

资料来源： *Transformations* , by Gould, 1978, New York: Simon & Schuster.

古尔德的七个发展阶段是从一个相对较小的样本中提出来的，而且在很大程度上依赖于他自己的临床判断。事实上，他对不同阶段的描述受到了精神分析观点的很大影响，几乎没有得到具体研究的支持。

另一个不同于埃里克森理论的是心理学家丹尼尔·莱文森（Daniel Levinson）所提出的生命季节（seasons of life）理论。莱文森（1986, 1992）对一组成年男性进行了集中访谈后，认为40岁出头是个体面临危机和转变的时期。他认为成年男性从成年早期，即大约从20岁开始，一直到中年时期，将经历一系列生命阶段，开始阶段的核心是离开家并加入成人世界。

然而，大约在40岁至45岁时，人们会进入莱文森所称的中年转变的阶段。这是一个充满质疑的时期，人们开始关注生命有限的本质，并质疑自己此前的一些基本假设。他们体验到了衰老的最初迹象，并将面对

在死前仍无法实现自己所有目标这一现实。

在莱文森看来，这一评估很可能导致中年危机（**midlife crisis**），即个体不确定和优柔寡断的时期。面对生理上衰老的迹象，男性可能还会发现，即使以前那些自己最自豪的成就所带来的满足感，现在看起来也不像自己预期的那样多。他们可能试图找出哪里出了错，并寻找可以纠正过去错误的方法。中年危机是充满疑惑、痛苦和混乱的时期。

莱文森认为，大多数人都易受中年危机的影响。在接受这一观点之前，我们需要考虑莱文森的一些关键研究背景。第一，他最初的理论提出是基于40岁男性的数据，女性的数据是在几年后才补上的，而且样本量也较少。第二，莱文森夸大了自己所找的模型的稳定性和普遍性。事实上，普遍中年危机的理论受到了相当多的批评（McFadden & Rawson Swan, 2012; Cousins, 2013; Thorpe et al., 2014）。

中年危机：现实还是虚构 莱文森模型的核心是有关中年危机的概念，他假设中年危机是在40岁出头时发生的、以强烈的心理混乱为标志的时期。这个概念自身具有一定的生活含义：美国社会普遍认为40多岁是个体重要的心理转变时期。

这种看法缺乏证据的支持。大多数研究显示，多数人会相对轻松地度过中年时期。绝大部分人认为中年时期还是得到回报的时期。如果他们是父母，那他们对孩子的抚养已经基本结束，在某些家庭中，孩子已经离开了家，这给了父母重新点燃他们亲密感的机会。很多人发现他们的事业开始蒸蒸日上，而且对生活感到很满意。他们开始关注眼前，最大限度地参与和投入家庭、朋友和其他一些社交圈。那些对自己之前的生命历程感到后悔的人会希望改变方向，而这些成功得以改变的人通常会收获心理上的满足。而且，大多数进入中年期的个体觉得自己比实际年轻（Wethington, Cooper, & Holmes, 1997; Stewart & Vandewater, 1999; Willis, Martin, & Rocke, 2010）。



尽管没有充分的证据说明人们都会经历“中年危机”，但这种观点仍然普遍存在。为什么这个观点会如此流行？

此外，一个人对自己年龄的感觉与其健康状况有关。那些觉得自己比实际年龄更小的人更不容易死亡（见图8-6）。换句话说，感觉自己更年轻的人在8年内死亡的概率更低（Miche et al., 2014; Rippon & Steptoe, 2015）。

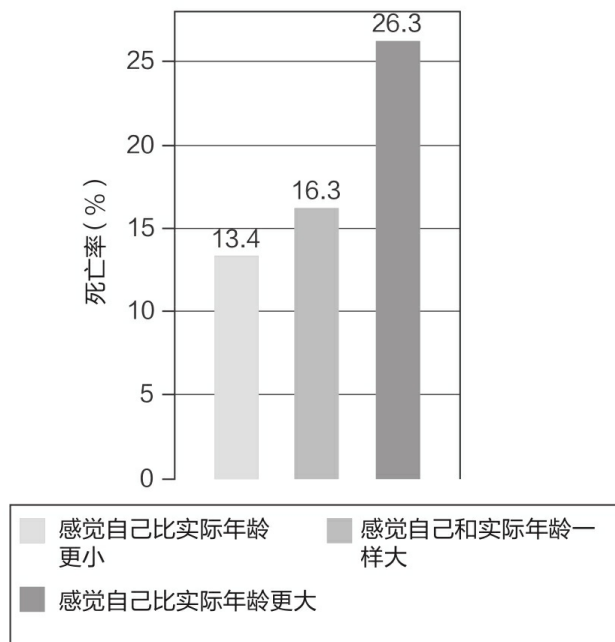


图8-6 自我感觉年轻与死亡率的关系

感觉自己比实际年龄小的人更容易长寿。

资料来源: Rippon & Steptoe, 2015.

简言之,“不可避免的中年危机”的证据远没有之前讨论过的“暴风雨般的青春期”的证据那么有说服力。然而,有关中年危机的观点仍然成了一种“常识”,这是为什么呢?

原因之一是个体在中年时期的混乱会更明显,且更容易被看见的人记住。一个40岁的男人离了婚,把稳重的福特旅行车换成了红色敞篷车,还和一个比他年纪小很多的女人再婚,看起来会比另一个还维持着与原配的婚姻并保留福特汽车的幸福已婚男子要显眼很多。我们更可能关注和联想到中年个体婚姻的不幸而不是幸福的一面。就这样,虚构、混乱又普遍的中年危机的说法一直流传开来。对大多数人来说,中年危机更多的是一种虚幻而不是现实。其实大部分人的中年时期很少会有什么改变,而且在一些文化下,中年甚至不会被视为一个独立的生命阶段(见“文化维度”专栏)。

文化维度 中年时期:在某些文化中并不存在

没有中年这样一段时期。

如果我们看到印度奥里亚人文化下女性的生活,就会得出以上的结论。发展人类学家理查德·施韦德(Richard Shweder)对种姓等级较高的印度女性如何看待衰老过程进行了研究,发现她们根本不存在中年时期。这些女性看待她们的生命进程并不是基于实际年龄,而是基于特定时间内自己的社会责任性质、家庭管理问题及道德感而定的(Shweder, 1998, 2003)。

奥里亚女性的衰老模型围绕着两个阶段:在父母家和在婆家的生活。这两个生活阶段在包办婚姻、多代大家族组成的奥里亚家庭生活中具有一定的意义。婚后,丈夫仍然和父母住在一起,妻子则要搬到婆家。结婚就意味着女性社会地位的转变,她将由某人的女儿转变为一个儿媳。

这种从女儿到儿媳的转变通常发生在18~20岁,但是,实际年龄并不能划分奥里亚女性的生活阶段,月经初潮或是停经这种生理上的改变也不能作为划分标准。相反,从女儿到儿媳的这种社会责任的显著转变,才是她们生活阶段的分水岭。例如,女性需要把关注点从父

母转移到公婆身上，而且她们必须开始性生活，来为丈夫传宗接代。

或许许多人会认为这些印度女性的生活是极其不自由的，因为多数情况下，她们都不能外出工作。但她们自己并不这么看。实际上，在奥里亚文化中，家庭事务很受人尊敬也很有价值。此外，奥里亚女性认为她们比必须在外工作的男性更有文化和教养。

独立的中年时期这一观点明显是文化的产物。事实上，不同文化对特定年龄阶段的划分有着显著的差异。

人格的稳定与变化

学习目标**8.8** 分析人格在一生当中是稳定的还是变化的。

53岁的哈里·享尼西是一家投资银行的副总裁，他觉得自己的内心仍然像个孩子。很多成年人都赞同这种想法。尽管多数人常说自己自青春期后改变了很多，而且大部分是向好的方向改变，但很多人仍感觉自己现在的基本人格特质和年轻时非常相似。

人格在一生中是保持稳定还是会有所变化？这是研究成年中期人格发展所面临的主要问题。埃里克森和莱文森等人明确指出，人格会随时间的发展产生巨大变化。埃里克森的阶段论和莱文森的生命季节理论都描述了变化的固定模式。这些改变可能是可预测的，与年龄相关并确实存在。

然而，一项令人印象深刻的研究指出，至少在个人特质上，人格还是非常稳定的，并会贯穿人的一生。发展心理学家保罗·科斯塔（Paul Costa）和罗伯特·麦克雷（Robert McCrae）发现，特定特质具有相当高的稳定性（见图8-7）。20岁时好脾气的人，75岁时仍然是好脾气；25岁时充满感情的人，50岁时仍然充满慈爱；26岁时个性紊乱的人，到60岁时仍然如此。类似地，借由30岁时的自我概念可以很好地预测80岁时的自我概念。事实上，随着年龄的增长，个体的特质是非常稳定的

（Terracciano, McCrae, & Costa, 2009; Mottus, Johnson, & Deary, 2012; Curtis, Windsor, & Soubelet, 2015）。

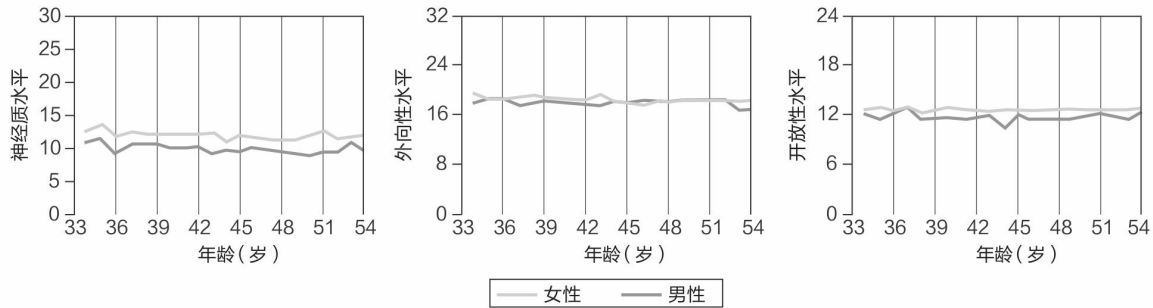


图8-7 人格的稳定性

根据科斯塔和麦克雷的观点，个体的诸如神经质、外向性和开放性等基本人格特质在整个成人阶段都保持稳定和一致。

资料来源：Costa & McCrae, 1989, p.148.

“大五”人格特质的稳定性和变化性 关于“大五”人格特质的研究有很多，因为它们代表了最主要的人格特质，即包括以下五个特质：

- 神经质（neuroticism），个体情绪化、焦虑和自责的程度。
- 外向性（extraversion），个体外向或害羞的程度。
- 开放性（openness），个体对新异事物的好奇心和兴趣水平。
- 宜人性（agreeableness），个体是否好相处，是否乐于助人。
- 尽责性（conscientiousness），个体使事情有组织性和对其责任感的程度。

大部分研究都发现，“大五”人格特质在30岁后会保持相对稳定，但是某些特质仍会有一些变化。具体来说，神经质、外向性和开放性相对成年早期来说有一定的下降，宜人性和尽责性则有上升的倾向，而且该结果还具有跨文化的一致性。不过基本的模式在整个成人阶段都会保持稳定（McCrae & Costa, 2003; Srivastava, John, & Gosling, 2003; Renner, 2010; Hahn, Gottschling, & Spinath, 2012）。

有关人格特质保持稳定的证据是否与以埃里克森、古尔德和莱文森为代表的人格变化理论相冲突？并不完全如此，冲突之处实际上并没有

看起来那样明显。

个体的基本人格特质的确在整个成人时期都具有连贯性，但也较容易发生变化，因为成人的生活充满了家庭、职业甚至经济上的各种重要变动。衰老引起的生理变化、疾病、所爱之人的死亡和越来越清晰地意识到生命的有限都会刺激个体很大程度上改变对自身和世界的看法（Krueger & Heckhausen, 1993; Robert, Walton, & Viechtbauer, 2006）。

同样支持这一观点的，是以婴儿潮时期出生的个体为研究对象的新研究，该研究发现从大学时期开始的人格特质的变化会一直延伸到成年期。

毕生的幸福感 假设你在威力球乐透彩中了大奖，你会变成更快乐的人吗？对大多数人来说，答案是否定的。越来越多的研究显示，成年人的主观幸福感或整体幸福感在一生中都保持稳定，甚至中彩票也只能暂时地增加主观幸福感，一年后，人们的幸福感又会恢复到中彩票前的水平（Diener, 2000; Stone et al., 2010）。

主观幸福感的稳定性显示出多数人都会有一个幸福感的“设定点”（set point），即使生活起伏波动，幸福感也会保持稳定的水平。尽管特定事件可能会在短时间内提升或降低一个人的情绪水平，比如一次杰出的工作评价或者失业，但人们最终会恢复到自己的一般水平。

此外，幸福感的设定点并不是完全固定的。在某些情况下，设定点会因受到离婚、伴侣死亡、失业和残疾等特殊生活事件的影响而发生改变。而且，个体对生活事件的适应能力也有所不同（Lucas, 2007; Diener, Lucas, & Scollon, 2009）。

大多数人的幸福设定点看起来都比较高。30%的美国人认为自己“非常幸福”，只有10%的人认为自己“不是很幸福”，而大多数人都说自己“很幸福”。在不同的社会阶层中所得的调查结果都类似。男性和女性对幸福程度的评估结果是一样的，非裔美国人评估自己“非常快乐”的

程度只比白人低一点。不管经济状况如何、来自哪个社区或哪个国家，全世界人的幸福感水平都类似（Diener, 2000; Diener, Oishi, & Lucas, 2003; Kahneman et al., 2006; Delle Fave et al., 2013）。所以结论就是：钱买不到幸福。

关系：中年时期的家庭

对凯茜和鲍勃来说，将儿子乔恩送进大学是家庭生活中的一个震撼性的新体验。到美国的另一端上大学并不真正意味着他会离开家，这本来并没有让他们觉得会给家里带来什么改变，直到儿子和他们道别并留在了新校园，他们才感受到很大的痛苦。像所有父母一样，凯茜和鲍勃很担心儿子，并感受到一种深深的失落，他们最基本的工作——抚养儿子已完成了。现在乔恩已经长大了，开始万事靠自己。这个想法让他们充满了骄傲和对儿子未来的期待，但也充满了伤感。他们会想念乔恩的。

在许多文化中，往往几代人一生都生活在一个家庭里，这些传统大家庭的成员在中年时期并没有什么特别的改变。但在西方文化中，家庭动态在中年时期的变化非常显著。对夫妇来说，这主要是和孩子之间的关系发生了转变，当然他们和其他成员的关系也有变化。在21世纪的西方文化中，中年时期是一个角色变化的阶段，出现了越来越多的组合和排列。我们首先来看这一时期中婚姻的发展及变化，然后关注当今家庭生活中的其他几种家庭形式（Kaslow, 2001）。

婚姻和离异

学习目标8.9 描述成年中期典型的婚姻模式以及离婚。

50年前，中年对多数人来说都是大同小异的，男人和女人在成年早期结婚，到中年仍然和原配在一起。而在人们普遍寿命不长的20世纪

初，40岁的人通常都是已婚，但不一定就是和原配在一起，因为原配通常已经去世了，所以中年时人们很可能正值步入第二次婚姻。

如今，情况又有所不同，而且变得非常多样化。很多人在中年时仍然单身，而且从未结过婚。单身的人可能独自生活，也可能和伴侣在一起。对男同性恋或女同性恋来说，虽然婚姻不一定会成为必然选择，但他们仍然很可能会长期和伴侣保持亲密关系。在异性恋中，一些人离婚后可能会独自生活也可能会再婚。很多人的婚姻会以离婚告终，很多家庭又“重组”成新的家庭，成员包含自己的亲生孩子和再婚配偶前一次婚姻中的孩子。很多夫妇仍会一起生活40~50年，这其中一大段时间就处于中年期。有些人的中年期是婚姻幸福感处于最高峰的时期。

婚姻的起伏波动 即使幸福的婚姻也有起伏波动，个体在整个婚姻历程中对婚姻的满意度会有上升下降。多数研究显示，婚姻的满意度呈U形曲线（Figley, 1973）。具体地说，婚姻满意度会在结婚后开始下降，一直下降到孩子出生并达到最低点（见图8-8）。在该点之后，满意度开始上升，最终会恢复到与结婚初期相同的水平（Gorchoff, John, & Helson, 2008; Medina, Lederhos, & Lillis, 2009; Stroope, McFarland, & Uecker, 2015）。

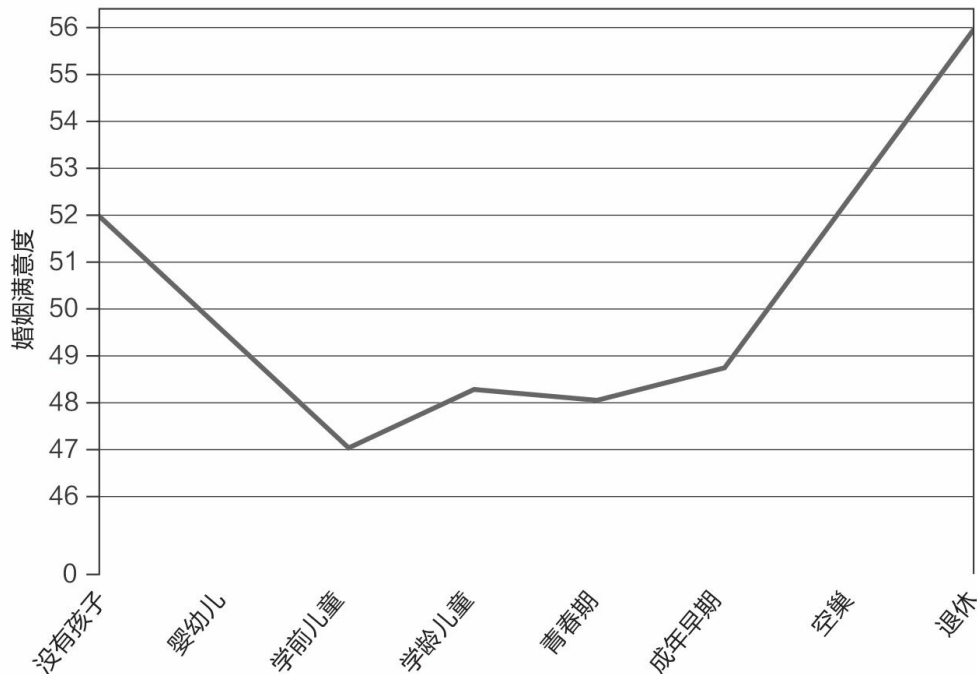


图8-8 夫妇在不同阶段的婚姻满意度

对很多夫妇来说，婚姻满意度呈U形，先下降后上升。具体来说，婚姻满意度是在孩子出生后开始下降，但在最小的孩子也离开家后回升，最终达到与婚姻刚开始时相同的水平。你觉得为什么会出现这样的满意度模式？

资料来源：Rollins & Cannon, 1974.

同时，也有一些研究对U形曲线提出了质疑。该研究结果显示，在毕生发展的过程中，婚姻满意度是持续下降的（Umberson et al., 2006; Liu, Elliott, & Umberson, 2010）。

这一分歧的原因尚不明确，可能是个体的人格差异导致了结果的不一致。但可以肯定的是，中年夫妻有很多婚姻满意度的来源。一般情况下，男性和女性都会喜欢自己配偶那样的人，并认为他们是自己“最好的朋友”。夫妻双方还把婚姻视为需要长期忠诚和追求一致目标的过程。最后，大多数人还感觉他们的配偶随着年龄的增长变得更加有趣了（Schmitt, Kliegel, & Shapiro, 2007; Landis et al., 2013）。

性生活满意度和婚姻整体满意度相关。性生活满意度与夫妻多久进行一次性生活无关，而与夫妻性生活是否和谐有关（Spence, 1997;

Litzinger & Gordon, 2005; Butzer & Campbell, 2008)。

幸福的婚姻并没有“秘诀”，但有一些应对机制能够提高夫妻的幸福水平。具体包括但不限于如下四点（Orbuch, 2009; Bernstein, 2010; Williams, 2016）：

- 保持现实的期望。幸福的夫妻明白，他们的伴侣会有一些让自己不那么喜欢的地方，并且他们能够接受伴侣在某些情况下做出一些他们不喜欢的事情。
- 关注积极的方面。想想伴侣身上那些他们欣赏的优点，能够帮助其接受伴侣的缺点。
- 妥协。拥有幸福婚姻的伴侣知道，他们不必每次争论都占得上风，这又不是比赛。
- 拒绝冷暴力。他们会让伴侣知道有些事情让他们感到了不快，但他们不会指责对方，相反，他们会在双方都很冷静的时候再沟通。

离婚 结婚才一年，路易丝就明白他们的婚姻注定会失败。汤姆从不听她说话，不问问她一天过得怎么样，也从不做家务。他完全以自我为中心，好像并没有意识到其他人的存在。但23年后，她才鼓起勇气告诉丈夫她想要离婚。丈夫的回答很随意：“你想怎么样就怎么样吧，对我来说没有差别。”一开始，她以事情很顺利来安慰自己，但随后就感觉遭到了背叛和愚弄。这段婚姻带来的所有苦恼和痛苦，以及他们做的所有努力都毫无意义。“为什么我们从没面对过现实？”她想知道。

即使整体的离婚率在近几年都有所下降，但实际上中年夫妇的离婚率却上升了（见图8-9）。第一次婚姻中的女性有1/8会在40岁后离婚（Enright, 2004; Brown & Lin, 2012; Thomas, 2012）。

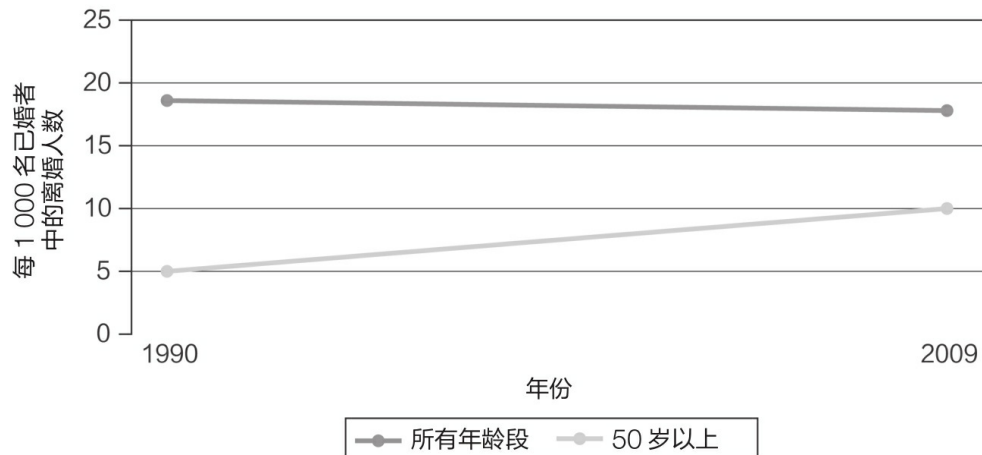


图8-9 逐渐上升的成年中期离婚率

在过去的50年，离婚率和离婚人数都显著上升，而且根据预测，这种上升趋势会一直持续。

资料来源：Brown & Lin, 2012, Figure 1.

导致离婚的原因有很多。其一，中年期人们在一起的时间比年轻时在一起的时间要少很多。尤其在崇尚个体主义的国家，个人更关注自身的快乐。如果婚姻不能带来快乐，也许离婚能提升他们的幸福感。离婚相对于过去也更容易被接受，而且离婚的法律障碍和大多数情况下的经济成本都不大。其二，随着女性的机遇越来越多，妻子们不管是情感上还是经济上都更少依赖自己的丈夫了（Fincham, 2003; Brown & Lin, 2012; Canham et al., 2014）。

其三，可能是浪漫和激情随着时间的推移减退了，没有激情往往会成为人们离婚的重要理由。其四，因为现在大部分夫妻会同时处在职场，这无疑会带来更大的压力，从而使婚姻生活极度紧张，毕竟曾经直接花在家庭和婚姻关系上的精力，现在都用在工作或其他家庭之外的义务上了（Macionis, 2001; Tsapelas, Aron, & Orbuch, 2009）。

其五，对伴侣不忠，即与第三者发生性关系，也是导致离婚的原因。一项调查发现，不足35岁的人群中，20%的男性和15%的女性承认他们曾对伴侣不忠，12%的男性和7%的女性承认近一年中与第三者发生过性关系（Atkins & Furrow, 2008; Steiner et al., 2015）。但数据的可信

度备受质疑——这些人既然能对自己的伴侣撒谎，又怎么会对数据调查人员诚实呢？

不论原因是什么，中年时期的离婚都意味着非常艰难的生活，尤其对于一直充当母亲的角色、在外没有实质性工作的女性来说。她们可能会受到年龄歧视，因为即使那些要求最低的工作都更愿意选择年轻人。这些离婚后的女性可能缺少职业训练和资源，又缺乏突出的工作能力，也就很可能一直都找不到工作（McDaniel & Coleman, 2003; Williams & Dunne-Bryant, 2006; Hilton & Anderson, 2009）。

但是很多中年离婚的人最终都能幸福，尤其是女性，她们更容易发展出新的、独立的自我认同，这也是离婚的一个积极结果。中年离婚的男性和女性很可能形成新的关系，而且他们一般都会再婚（Enright, 2004）。

再婚 75%~80%离婚的人最终都会再次结婚，而且一般是在2~5年内。他们往往会和那些同样离过婚的人结婚，因为对方也单身，并且拥有类似的经历（Pew Research Center, 2014a）。

虽然再婚率普遍较高，但某些人群的再婚率远远高于其他群体。比如，女性再婚要比男性难，尤其是较为年长的女性。90%的25岁以下的离婚女性会再婚，而只有不到1/3的40岁以上的女性会再婚（Bumpass, Sweet, & Martin, 1990; Besharov & West, 2002）。

这种年龄上的差异来源于之前讨论过的婚姻梯度：社会规范鼓励男性娶比自己年轻、矮小，社会地位更低的女性。女性年纪越大，社会规范认可的、可供选择的男性就越少，因为和她们年龄相匹配的男性可能都在找更年轻的女性。社会在男、女性外在吸引力上采取的双重标准也成为女性的劣势。年龄较大的女性可能会被认为没有吸引力，而年长的男性则被看作是“杰出的”和“成熟的”（Bernard, 1982; Buss, 2003; Doyle, 2004b）。

有很多原因使再婚比保持单身更吸引人。再婚的人可以避免离婚带来的负面社会结果。虽然已经进入21世纪，离婚变得很普遍，但人们对离婚仍然存在一定的偏见。此外，比起那些已婚的人，离婚的人整体上报告了更低的生活满意度（Lucas, 2005）。

离婚的人会怀念婚姻所能提供的那种伴侣关系，尤其是男性报告说会感到孤独，并且人们在离婚后可能会有更多的生理和心理上的问题。婚姻还能带来经济上的收益，如一起分担房子的花销以及夫妻互保的医疗保险（Ross, Microwsky, & Goldsteen, 1991; Stewart et al., 1997）。

第二次婚姻和第一次婚姻会有所不同。较为年长的夫妇在对婚姻的预期上会显得更成熟且现实。相对于年轻夫妇来说，他们不那么追求浪漫，并且更加谨慎，而且在角色和职责上更加灵活，在做家务、杂事以及做决策时地位更加平等（Mirecki et al., 2013）。



大约75%的离婚个体会在2~5年内再婚。

不幸的是，这些都不能保证第二次婚姻的持久。甚至第二次婚姻的离婚率比第一次的还要稍微高一点。原因之一可能是，第二次婚姻中会有一些第一次婚姻中没有的压力，比如不同家庭的混合。原因之二可能是经历并熬过第一次离异后，配偶们之间或许不再那么忠诚，并为走出第二个不快乐的婚姻做好了更多的准备。原因之三可能是他们自身也有一些个性和情绪特质，使他们不好相处（Cherlin, 1993; Warshak, 2000;

Coleman, Ganong, & Weaver, 2001）。

虽然第二次婚姻的离婚率很高，但很多人的再婚也很成功。在这些情况中，再婚夫妇报告的满意度水平和初婚夫妇的一样高（Bird & Melville, 1994; Michaels, 2006; Ayalon & Koren, 2015）。

家庭变化

学习目标**8.10** 分析成年中期个体家庭模式变化的影响和意义。

对很多父母来说，中年时期一个主要的转变就是和去上大学、结婚、参军或远离家庭去工作的孩子分离。即使那些较晚才当父母的人也会面临这样的转变，因为中年期会持续将近25年。正如我们看到的凯西和鲍勃的故事，和孩子分离是很痛苦的过程，实际上，这就是所谓的空巢综合征（**empty nest syndrome**），即一些家长在孩子离开后体验到不快乐、担忧、孤独和抑郁的感受（Lauer & Lauer, 1999; Erickson, Martinengo, & Hill, 2010）。

很多父母报告说自己需要对生活做一些大的调整。对那些待在家里的母亲来说，这种转变更加痛苦。传统的家庭主妇此前把主要的时间和精力都放在了孩子身上，这时她们就会面临极大的挑战。

虽然转变会很艰难，但是父母们发现这个转变也有积极的方面。即使是家庭主妇也都发现，孩子离开后，她们开始有时间来发展自己的兴趣了，如参加社区或娱乐活动等，而且她们很乐意能拥有工作或重返学校的机会。调查显示，很多女性都承认做母亲没有以前那样简单了，这样的女性可能现在会觉得终于从一系列艰难的职责中解脱出来了

（Heubuch, 1997; Morfei et al., 2004; Chen, Yang, & Dale Aagard, 2012）。

虽然失落感很普遍，但研究表明，这种失落和沮丧的感觉只是短暂的，对那些在外工作的女性来说更是如此（Crowley, Hayslip, & Hobdy,

2003; Kadam, 2014)。

实际上，孩子离开家有很多显而易见的好处。比如配偶们可以有更多的时间花在彼此身上了；已婚或未婚的人都能更投入地工作，而不用再担心要辅导孩子的功课以及和孩子共用汽车了；房子可以保持得更加整洁，电话铃响的次数也少了（Gorchoff, John, & Helson, 2008）。

多数有关空巢综合征的研究都集中于女性。由于男性传统上较少参与养育孩子，所以一般来说男性更容易接受这种转变。不过也有研究显示，男性同样会因孩子离开而感到失落，但是他们的感受可能和女性不同。

一项研究发现，虽然大多数父亲对孩子的离开感到开心或没感觉，但约有1/4的父亲会感到不开心（Lewis, Freneau, & Roberts, 1979）。这些父亲会强调自己错失了可以为孩子做很多事的机会。一些父亲则懊恼他们太忙了，以至于没法或没有充分地养育和照顾孩子。

孩子离开家后，一些父母成了“直升机式父母”，遥控干预孩子的生活。直升机式父母的明显表现就是会干预孩子大学生活的方方面面，他们会向教职人员抱怨孩子成绩差，或想方设法让孩子选某些课程。有时，这种情况会一直延续到工作之后，有些雇主曾抱怨应聘者的父母会给人事部门打电话，吹嘘自己的孩子。

尽管数据显示直升机式父母并不占多数，但其确实是真实存在的。一项包括799名雇主的调查发现，1/3的雇主表示接到过父母代投的简历，有时他们的孩子甚至不知道这件事。1/4的雇主表示曾有父母联系过他们，劝说雇主录用自己的孩子。当孩子得到工作后，有些父母甚至会帮助孩子完成工作任务（Gardner, 2007; Ludden, 2012; Frey & Tatum, 2016）。

尽管在多数情况下，孩子离开家后，父母都能够放手，但在许多家庭中，孩子可能并不会永远地离开家。我们接下来就会讨论“飞去来器

般的孩子”，他们正慢慢返回，并重新填满空巢。

飞去来器般的孩子：重填空巢 卡萝尔不知道该拿她23岁的儿子罗布怎么办。自从两年多前大学毕业后他就一直待在家里，而她另外6个较大的孩子通常只回家待几个月就走。

“我问过他：‘为什么不搬出去和你的朋友们住？’”卡萝尔说。罗布也准备好了答案：“他们也都住在家里。”

卡萝尔家的这种情况并不是个例。在美国，很多年轻人都会重返家中，和自己中年的父母住在一起。

这些所谓飞去来器般的孩子（**boomerang children**），主要是因为经济状况而回到家中的，俗称啃老族。现在的经济状况下，很多毕业生都无法找到工作，还有一些虽然找到了工作，但赚的钱根本无法糊口。还有些孩子是在离婚后重回家里的。总体来说，接近1/3的25~34岁的人正与父母住在一起。在一些欧洲国家，这个比例更高（Roberts, 2009; Parker, 2012）。

大约50%的飞去来器般的孩子会给父母租金，让父母有所收益。这种安排也不会影响家庭内部的成员关系：50%的人表示没有变化，有些甚至表示这比单独居住好（见图8-10）。只有1/4的飞去来器般的孩子表示重填空巢使他们的关系恶化了（Parker, 2012）。

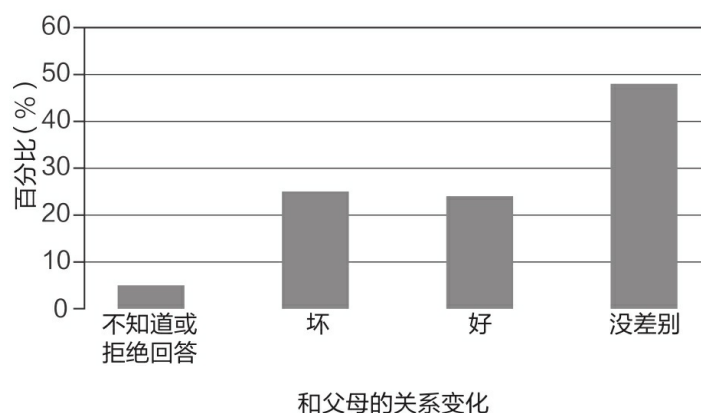


图8-10 飞去来器般的孩子和父母的关系

飞去来器般的孩子与父母关系很好、不好和没有变化的比例。

资料来源：Pew Research Center, 2012.

三明治一代：夹在孩子和父母之间 在孩子离开家，或像飞去来器那样返回家的同时，很多中年人还面临着另一个挑战：照顾年老的父母。三明治一代（**sandwich generation**）指的是那些夹在孩子和父母中间的中年人，上下老小都需要他们的关照（Riley & Bowen, 2005; Grundy & Hebretha, 2006; Chassin et al., 2009）。

三明治一代是因一系列趋势的汇集而产生的比较新的现象。首先，人们越来越晚结婚，生孩子的年龄也越来越晚。同时，人们也越来越长寿。因此大部分中年人可能既要照顾年迈的父母，又要抚养年幼的孩子。

从心理角度上来说，照顾年老的父母很棘手。因为在某种程度上，中年人和他们的父母出现了角色对换，孩子开始更像父母，而父母变得越来越不独立。我们之后会讨论，曾很独立的人年老之后，可能会怨恨和抗拒孩子的帮助，因为他们不想成为别人的负担。几乎所有单独生活的老人都说他们不希望和孩子们住在一起（Commonwealth Fund Commission on Elderly People Living Alone, 1986; Merrill, 1997）。

和父母住在一起的中年人能在生活上为父母提供许多帮助。他们可能为退休金不够用的父母提供经济上的支持，还能帮忙做家务，例如在春天时移除风窗或在冬天时铲雪。

在一些情况下，年老的父母可能会住在孩子的家里。人口调查结果显示，三代及以上的多代家庭是所有家庭模式中增长最快的一种，其增长率在1990年到2000年期间高达33%，占有家庭种类的4%（Navarro, 2006）。

多代家庭的情况往往比较复杂。一般来说，长大成年的孩子要对整个家庭负责了。他们和父母都要做出调整并在做决策时找到共同点。年

老的父母可能很不适应自己对孩子的依赖，而对孩子来说，这个适应的过程也很痛苦。年轻一代和年老的一代都有可能产生抵触情绪。

在很多情况下，夫妻双方并不是平等分担照料家庭的责任的，人们往往认为女性需要多负担一些。即使丈夫和妻子都在外工作，妻子也会更多地参与日复一日的照料，甚至对自己的公婆也是如此（Soldo, 1996; Putney & Bengtson, 2001）。

文化也会影响看护者怎样看待自己的角色。亚洲文化的成员更注重集体主义，更有可能把照料看作一种传统而正常的职责。与此相反，个体主义文化中的成员可能觉得家庭纽带并不是很重要，并且把照顾老人看成负担（Kim & Lee, 2003; Ron, 2014; Kiilo, Kasearu, & Kutsar, 2016）。

虽然作为夹在两代之间的三明治一代会有负担，但是和父母一起生活能拓展照料孩子的资源，其回报也是很重要的。中年子女和老年家长之间的心理联结会持续增强，双方都会以更现实的态度来看待彼此。他们可能会更亲密，更能包容对方的不足，并且更加感激对方的付出（Vincent, Phillipson, & Downs, 2006）。

成为祖父母 当她最大的儿子和儿媳有了第一个孩子时，利娅真不敢相信，54岁的她做了祖母！她一直都在告诉自己她很年轻，不可能成为任何人的祖母。

成年中期，个体往往会遇到一个毋庸置疑的年老的标志：成为祖父母。对某些人来说，这个新角色可能是他们已经期盼了很久的。他们可能很喜欢小孩子的那种活力和激情，甚至会主动提出当祖父母的要求，他们可能把为人祖父母看作是生命自然进程的下一个阶段。另一些人则不喜欢当祖父母，他们认为这是衰老的标志。

一般来说，祖父母可以分为几种类型。卷入型（involved）祖父母会积极地参与并影响孙辈的生活，他们对孙辈们的行为表现有明确的期

盼。卷入型祖父母在退休后会帮助自己在外工作的儿女照顾孙辈（Mueller, Wilhelm, & Elder, 2002; Fergusson, Maughan, & Golding, 2008; Mansson, 2013）。

同伴型（companionate）祖父母比较轻松。他们往往扮演着一个支持者或伙伴的角色，而不是承担对孙辈的责任。这类祖父母经常给孙辈们打电话、带他们度假或者邀请他们到家里来，也会去儿孙辈家里拜访。

最后，最冷漠的就是疏远型（remote）祖父母。这类祖父母对孙辈们很不感兴趣，甚至疏远他们并表现得很冷漠。举例来说，疏远型祖父母几乎不去看自己的孙辈，并且可能在看见时还会抱怨他们幼稚。

人们乐于成为祖父母的程度存在着显著的性别差异。一般来说，祖母比祖父更乐意成为祖母并能体验到更多的满意感，尤其是在祖孙间有较多的互动时更是如此（Smith, 1995; Smith & Drew, 2002）。

非裔美国人相比于白人来说更容易成为卷入型祖父母。最合理的解释就是多代家庭在非裔美国人中比在白人中更加普遍。此外，非裔美国人的家庭较容易由家长一方掌管，因此他们通常需要祖父母来帮助日常照看孩子，而且他们的文化标准倾向于支持祖父母在抚育下一代时起到积极的作用（Stevenson, Henderson, & Baugh, 2007; Keene, Prokos, & Held, 2012; Bertera & Crewe, 2013; Cox & Miner, 2014）。

家庭暴力：隐蔽的流行病

学习目标**8.11** 描述美国家庭暴力的产生原因和特点。

家庭暴力在美国堪称流行病，约1/4的婚姻中都存在家庭暴力（见图8-11）。近10年被杀的女性中，超过一半都是被配偶所杀。21%~34%的女性会至少一次被亲密伴侣（包括现任或前任配偶、男女朋友）扇、踢、掐、威胁或用武器攻击过，还有不少施暴者是受害者的直系亲

属（包括父母、子女和兄弟姐妹）。实际上，美国近15%的婚姻中都持续地充斥着严重的暴力行为。另外，很多女性可能会成为包括言语和情感虐待在内的心理虐待的受害者。家庭暴力也是个全球性的问题，据估计，全球有1/3的女性在生活中遭受过严重的暴力（Walker, 1999; Garcia-Moreno et al., 2005）。

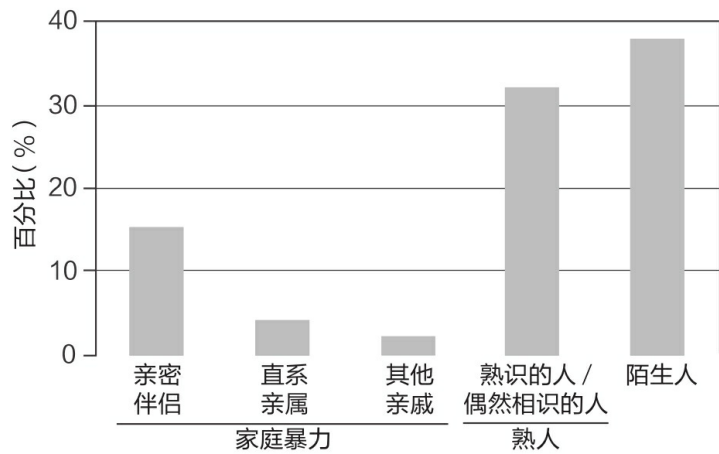


图8-11 2003—2012年暴力侵犯案件中受害者与罪犯的关系

资料来源：Truman & Morgan, 2014.

美国社会的各个阶层均无法避免配偶虐待的发生。暴力发生在各个社会阶层、种族、民族以及各种不同信仰的人群之中。同性恋和异性恋伴侣都有可能成为施暴者。暴力还会在不同性别间发生：虽然多数情况下丈夫是施暴者，但在约8%的情况中，妻子也会对丈夫进行身体攻击（Harway, 2000; Cameron, 2003; Dixon & Browne, 2003）。

一些特定的因素会增加虐待发生的可能性。对配偶的虐待更可能发生在经济紧张、言语攻击普遍的大家庭中。那些自己就在暴力环境中长大的丈夫或妻子，自己也更有可能出现暴力行为（Straus & Yodanis, 1996; Ehrensaft, Cohen, & Brown, 2003; Lackey, 2003）。

导致家庭处于暴力危险中的因素和另一种家庭暴力形式——儿童虐待的相关因素非常相似。儿童虐待在高压环境、低社会经济水平、单

亲家庭以及紧张的婚姻矛盾下发生的频率更高。有4个或更多孩子的家庭有较高的虐待发生比例，而那些年薪在15 000美元以下的家庭发生虐待的概率是较高收入家庭的7倍。但并不是所有虐待形式都发生在贫困家庭中。乱伦更可能在富裕家庭中发生（American Psychological Association, APA, 1996; Cox, Kotch, & Everson, 2003）。

配偶虐待的各个阶段 由丈夫实施的婚姻暴力通常会经历三个阶段（Walker, 1999）。在最初的紧张气氛建立阶段（tensionbuilding stage）中，暴力者开始变得不安并通过言语攻击表示不满（见图8-12）。他可能还会进行一些身体攻击，如推或猛抓。妻子可能会拼命阻止正在逼近的暴力，并试图安抚伴侣或逃离这种处境。这种行为也许只会激怒丈夫，使他察觉到妻子的弱势。她的努力逃离可能会增加丈夫施暴的危险性。

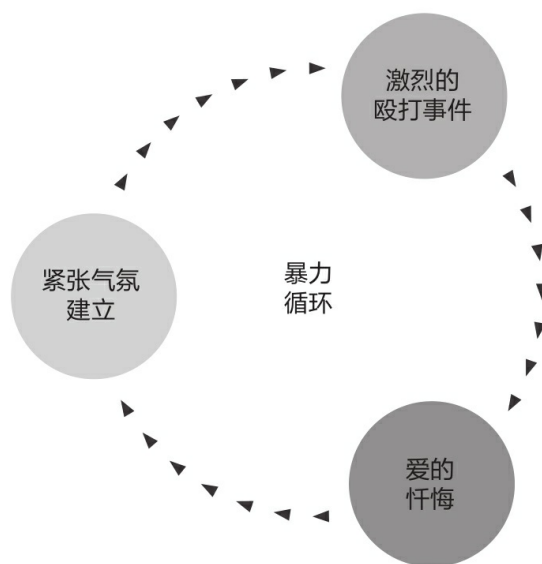


图8-12 暴力的阶段

资料来源：Walker, 1979, 1984; Gondolf, 1985.

下一个阶段是激烈的殴打事件（acute battering incident）。身体攻击会真实发生，持续时间从几分钟到几个小时不等。妻子可能被撞到墙上、被勒、被扇、被拳打脚踢以及踩踏。她们的手臂可能会被扭伤或骨

折，她们也可能被猛烈摇晃、被从一段楼梯上推下去，或被香烟及滚烫的液体烫伤。大约1/4的妻子被迫发生过性行为，其形式与性侵犯和强奸相同。

最后，在一些情况中，事件终止于爱的忏悔阶段（loving contrition stage）。在这个阶段，丈夫会感到懊悔，并为自己的行为道歉。他可能会第一时间为妻子提供急救措施并表示深刻的同情，同时向妻子保证以后再也不会使用暴力。由于妻子可能觉得自己也有一部分错误，因此会接受道歉并原谅丈夫，而且愿意相信攻击事件不会再出现。

爱的忏悔阶段解释了为什么很多妻子仍然和暴力的丈夫在一起生活并继续成为受害者。她们极其希望保持婚姻的完整，并相信自己再也没有更好的选择了，一些妻子甚至还有一种模糊的错觉，即自己也应当为虐待行为的发生负责。在另一些情况中，妻子则会担心即便自己离开后丈夫也会纠缠不休，因此无法决心脱身。

暴力的循环 有些妻子仍然会和施暴者生活在一起，是因为她们和丈夫一样，在童年就习得了“暴力是一种可接受的解决问题的方法”的观念。

虐待自己配偶和孩子的个体通常自己也是暴力的受害者。根据暴力循环假说，被虐待和忽视的儿童长大成人后也会有暴力倾向。就社会学习理论来看，暴力循环假说意味着家庭暴力将一代接一代地永远持续下去。会虐待自己妻子的丈夫通常在儿童时期就曾目击过父母虐待配偶，就像会虐待自己孩子的家长往往自己小时候就是虐待的受害者一样

（Serbin & Karp, 2004; Renner & Slack, 2006; Whiting et al., 2009; Eriksson & Mazerolle, 2015）。

从医疗保健工作者的视角看问题

如何结束暴力的循环？可以通过什么方法来阻止一个曾被虐待的儿童

长大后成为虐待者？

并不是所有在暴力家庭中长大的孩子成人后都会变成施暴者。只有1/3被虐待和忽视的儿童在长大成人后会虐待自己的孩子，而2/3的被虐者成人后并不会虐待自己的孩子。暴力循环假说并不能预测所有的虐待行为（Jacobson & Gottman, 1998）。

无论是什么导致的暴力，都有方法可以尝试解决，这也是我们接下来要讨论的。



会虐待自己配偶和孩子的家长通常自己小的时候也是暴力的受害者，这反映出暴力的循环。

配偶虐待和社会：暴力的文化根源 陈东禄把妻子打死后，他被判了二级谋杀罪，缓期5年执行。他承认了自己的所作所为，但宣称是因为妻子对他不忠。他的律师也是位人类学家，在法庭上辩解称，可能是传统的中国价值观导致了他认为可以以暴力反击妻子的不忠。

李方是一名老挝移民，他在拐骗了一名16岁的少女后，却被宣告其绑架、性侵和威胁的罪名不成立。在审判中，他的律师辩解称，“偷新娘”在老挝是一种传统习俗。

两个案件都是在美国进行审判的。在这两个案件中，律师都宣称被告是来自亚洲的移民。在某些亚洲文化中，对女性使用暴力是很常见

的，甚至还会得到社会的默许。陪审团在审判时显然会把这种“文化辩护”的正当性考虑在内（Findlen, 1990）。

虽然婚姻暴力和侵犯通常看起来是北美特有的现象，但也有另一些文化认为暴力行为是可接受的（Rao, 1997）。在男尊女卑或只把女性当作一种财产的文化中，殴打妻子尤其普遍。

在西方社会，殴打妻子曾经也是可接受的。“英国普通法”（English Common Law）允许丈夫殴打自己的妻子，该法也是美国法制体系建立的基础。在19世纪初期，该法被调整为只允许特定类型的殴打，特别是丈夫不能用比自己拇指粗的棍棒殴打妻子，这也是短语“拇指规则”的起源。直到19世纪晚期，美国才摒弃这项条律（Davidson, 1977）。

对此，一些暴力行为专家指出，殴打妻子如此常见的根本原因来自传统的男女权利结构。他们认为，男性和女性的地位差异越大，虐待发生的可能性就越大。

暴力行为专家们查阅了一项针对男性和女性在法律、政治、教育以及经济等方面所扮演角色的研究，以及对美国不同州的暴力行为数据的比较（见“成为发展心理学知识的明智运用者”专栏）。专家们发现，和其他地区相比，虐待行为更可能发生在女性地位特别低或特别高的州。显然，地位低下的女性很容易成为施暴对象，但比较令人意外的是，女性处在较高地位时丈夫也更有可能采取暴力行为，因为丈夫可能觉得因此受到了威胁（Dutton, 1994; Vandello & Cohen, 2003; Banks, 2016）。

成为发展心理学知识的明智运用者 如何应对配偶的虐待

配偶虐待在所有婚姻中的发生率达25%。国家提供的资金远不能解决问题，社会对这个问题的关注也还远远不够。实际上，一些心理学家提出，由于某些原因，社会多年来都低估了配偶虐待的问题，以致阻碍了社会采取有效的干预措施。不过仍有一些方法可以帮助遭配偶虐待的受害者（Browne, 1993; Koss et al., 1993）。

- 让夫妻双方明白最基本的前提：在任何情况下，以暴力解决争论的方法都不可取。
- 报警。包括来自配偶在内的攻击都是违法的。虽然人们可能不希望法律和警察介入自己的问题，但报警是一个现实的解决问题的途径。法官还可以发出禁令，要求暴力的丈夫远离妻子。
- 要明白，配偶的忏悔不论有多真诚动人，都不影响他未来继续施暴。即使丈夫显示出爱的忏悔，并发誓再也不会施暴，这种许诺都绝对无法保证他未来不会再出现虐待行为。
- 暴力受害者要找到安全的避难所。一些相关部门会为家庭暴力的受害者——主妇和孩子们提供避难所。避难所的管理人会保守秘密，不会让施暴者找到你。
- 如果你感觉和暴虐的伴侣在一起很危险，就可以从法官处寻求禁令。禁令会禁止配偶接近你，否则他就会受到处罚。

工作和休闲

享受每周末一次的高尔夫球运动，开始一个邻居互相监督的项目，指导一个小的棒球联盟队，参加一个投资俱乐部，和朋友去看电影，参加烹饪课程，参加一个戏剧活动，参与本地镇议会竞选，修整屋后的走廊，陪伴读高中的孩子参加一次旅行或独自旅行，在一年一度的度假时间里躺在沙滩上看书……

实际上，人们在成年中期可以享受到大量丰富多彩的活动。虽然成年中期往往处在事业和权力的最高峰，但这也是人们全身心投入闲暇和娱乐活动的时期。事实上，成年中期可能是工作和娱乐活动最容易达到平衡的时期。人们再也不会觉得需要在事业上证明自己，并渐渐更重视自己对家庭、社区以及社会所做的贡献，成年中期的人们可能会发现工作和休闲其实可以互补，从而增加整体幸福感。

成年中期的工作：好处和坏处

学习目标**8.12** 描述成年中期工作的裨益和挑战。

对很多人来说，中年时期是生产力最旺盛、赚钱能力最强也最容易成功的时期，但职业成功可能变得不再像以前那样诱人了，尤其是对那些在事业上还没有成功地达到自己所希望目标的人来说更是如此。在这样的情况下，家庭和其他兴趣将变得比工作更加重要（Howard, 1992; Simonton, 1997）。

工作和职业：中年时期的工作 在中年时期，决定个体是否对工作满意的因素会发生改变。年轻人关注抽象的和未来指向的因素，如升迁的机遇或者是他人的认可和赞许。中年员工更关心的则是眼前的工作质量。他们更在意工资、工作环境和特殊政策，如假期时间的计算方式。和之前的生命阶段一样，这一时期男女整体的工作质量变化都和压力水平的变化密切相关（Peterson & Wilson, 2004; Cohrs, Abele, & Dette, 2006; Rantanen et al., 2012; Hamlet & Herrick, 2014）。

总体上年龄和工作满意度呈正相关：员工年龄越大，其体验到的整体工作满意度就越高。这个结果很好理解：年轻人如果不喜欢他们的工作，就会辞职并寻找他们更喜欢的新工作；而较老的员工换工作的机会较少，他们就可能会学着去适应现有的工作，并认为这就是他们能得到的最好的。这种认知可能最终会转化为满意度的一部分（Tangri, Thomas, & Mednick, 2003）。

工作的挑战：工作中的不满 高工作满意度在成年中期并不普遍。对一些人来说，对工作环境或工作本质的不满会增加他们的压力。长此以往，情况可能会越来越糟，以至于人们会有工作倦怠或决定换工作。

对44岁的佩姬来说，一大早在郊外医院的加护病房工作变得越来越困难了。尽管患者的过世一直都让人难过，但最近她发现自己会在很奇怪的时刻为患者哭泣：就在她洗衣服、洗碗、看电视的时候。当她终于开始害怕去工作时，她意识到自己对工作的感觉发生了根本的变化。

佩姬的反应也许就是工作倦怠现象的反映。工作倦怠（**burnout**）

是当员工从工作中体验到不满、幻想破灭、受挫和对工作感到厌倦时发生的现象。它经常发生于需要为公众服务的工作中，并常常使那些曾经最理想主义和最热情的个体深受打击。这些个体在工作中常常过度投入，可当他们觉得自己对诸如贫穷和医护等巨大的社会问题几乎没有任何作用时，就会感到非常失望和挫败（Taris, van Horn, & Schaufeli, 2004; Bakker & Heuven, 2006; Dunford et al., 2012; Rössler et al., 2015）。



工作倦怠会在员工对工作感到不满、幻想破灭、受挫或对工作感到厌倦时发生。

工作倦怠的一个表现是对工作的牢骚日益增加。一名员工也许会对自已说：“我们这么辛苦地工作是为了什么？没有谁注意到过去两年我的付出。”员工也会对自己的工作表现得漠不关心。一个对职业充满理想的员工可能从此变得悲观并改变态度，认为解决问题的方法根本不存在（Lock, 1992）。

事实上，人们是可以克服工作倦怠的，即使那些要求很高、负担很重的职业也是如此。首先，有些护士会因为没有足够的时间照顾每一个患者而感到绝望，但他们可以采取更切实可行的护理目标，如给患者擦后背时擦得更快些。其次，可以让工作变得更有条理，这样即使疾病、贫穷、种族和不完善的教育体系问题仍然无法解决，员工及其监督者也能注意到那些微小的成就，如顾客的感激等，并从中获得激励。最后，休闲的时候就不要想工作上的事情，这也是克服工作倦怠的重要方法

（de Jonge et al., 2012; Sonnentag, 2012; Bährer-Kohler, 2013; Crowe, 2016）。

失业：梦想的破碎 对很多人来说，失业是很残酷的现实，这对他们的心理和经济状况有着双重影响。尤其是那些被解雇的、因企业缩减规模而被裁员的，或因技术发展而被迫离职的人，离开工作会对他们产生心理上甚至生理上的毁灭性影响（Sharf, 1992）。

失业会使人感到焦虑、抑郁和易怒。失业者的信心可能会受到严重打击，而且他们可能变得很难集中注意力。一项分析显示，每当失业率增长1%，自杀率就会增长4%，进入精神病机构的人数中男性会增长4%、女性人数会增长2%（Connor, 1992; Inoue et al., 2006; Paul & Moser, 2009）。

甚至，连失业后看起来有利的方面，如拥有更多的时间，也会产生消极的影响。失业的人可能会觉得抑郁和过于闲散，这让他们比在职者更少参加社区活动、去图书馆或进行阅读。他们非常有可能在约会或吃饭时迟到（Ball & Orford, 2002; Tyre & McGinn, 2003）。

失业造成的问题也许会一直延续。相对于年轻人，中年人失业的时间会更久一些，随着年龄的增长，他们获得满意工作的机会也更少了。雇主可能会歧视年长的应聘者，这让他们在找新工作时难上加难。这种歧视既不合法，也是基于错误假设的做法，因为研究发现，年长员工的旷工时间更少、工作时间更长、更可靠且更愿意学习新的技术（Connor, 1992）。

中年时期失业是令人心碎的经历。对一些人，尤其是那些再也找不到有意义的工作的人来说，这可能会改变他们对生活的看法。这种非自愿的且永久性的退休会导致失业者的悲观、玩世不恭和失望。他们往往需要用大量的时间和精力来调整自己，以应对新的处境。就算是那些找到新工作的人，也面临着很多挑战（Waters & Moore, 2002; Pelzer, Schaffrath, & Vernaleken, 2014）。



中年时期失业是令人心碎的经历，可能会改变一个人对生活的看法。

成年中期的事业：转换和重新开始 对很多人来说，成年中期都充满了对改变的渴望。那些对自己工作不满的人、失业后转行的人或离开多年后又重返职场的人，他们依然在不断开拓和发展新的事业。

人们在成年中期更换职业的原因有很多。可能是他们的工作不再具有挑战性了；可能是他们逐渐成熟的专业水平使过去很难的工作变得乏味了；可能是因为工作本身变得没意思了；可能是他们失业了；可能是他们必须用很少的资源去完成大量的工作；也可能是科技彻底改变了他们的日常活动，让他们再也无法享受工作了。

还有一些人改变职业是因为对自己的处境不满意，并希望有一个全新的开始；一些人是因为感到倦怠或觉得工作太单调；还有些人仅仅是想尝试一些新鲜事物，他们认为中年是做出有意义的事业并改变自己的最后机会。

最后，有相当数量的人会在孩子长大后重返职场，这些人大都是女

性。还有一些人重返职场是因为离婚后需要找一个经济来源。自20世纪80年代中期以后，职场中50岁以上女性的数量显著增加了。大约一半的55~64岁的女性现在正在职场中，而大学毕业的人中，女性处于职场的比例更大。

人们可能会抱着不切实际的期望进入新的职业领域，然后对现实感到失望。开始新职业的中年人可能也会被安排在初级职位，他们的同事都比自己年轻很多（Sharf, 1992; Barnett & Hyde, 2001）。

但从长远来看，在成年中期开始新的职业还是会让人欢欣鼓舞。那些转换或开始新职业的人也许会成为特别有价值的职员（Bromberger & Matthews, 1994; Otto, Dette-Hagenmeyer, & Dalbert, 2010; Feldman & Ng, 2013）。

一些人预言职业的改变将不再是特例，而将成为惯例。科技发展突飞猛进，迫使人们周期性地改变职业，而且这种改变常常是戏剧性的。人们在一生中将不只拥有一个职业，而是会有很多个。正像接下来的“文化维度”专栏所说的那样，改变职业对那些成人后移民到另一个国家的人来说更是如此。

从社会工作者的视角看问题

你觉得为什么移民的雄心和成就常常会被低估？就像人们会把对中年危机和青春期危机的特质自动套在处于相应阶段的人身上一样，那些有关移民的消极案例是否对此起到了一定的作用呢？

文化维度

移民在美国的快速发展

17年前，曼凯科洛·马兰古-恩科博由于被诬陷参与恐怖活动而在南非的莫勒山警察局被单独关了21天禁闭。1980年，当她再次因为参与反种族隔离抗议而面临监禁时，她把12岁的儿子托付给母亲，然后逃到了博茨瓦纳。1981年，她来到美国，并在4年后获得了合法身份，她现在正和13岁的女儿住在巴尔的摩一套价值6万美元的连栋住宅中。

恩科博的人生在这里获得了巨大的发展，和很多移民同伴一样，教育是他们成功的关键。恩科博来到这里之后，用奖学金和自己的积蓄先后攻读了一个神学学士学位、两个硕士学位以及一个博士学位。恩科博的学历和帮助他人而做的贡献帮她获得了两份满意的工作，一个是在巴尔的摩摩根州立大学做公共健康讲师，另一个是在华盛顿一座教堂做助理牧师（Kim, 1995, p.133）。

美国人口中大约有4 000万人是移民，约占总数的15%，接近1970年时移民人口的3倍（见图8-13）。第一代和第二代移民占美国人口的近1/4。

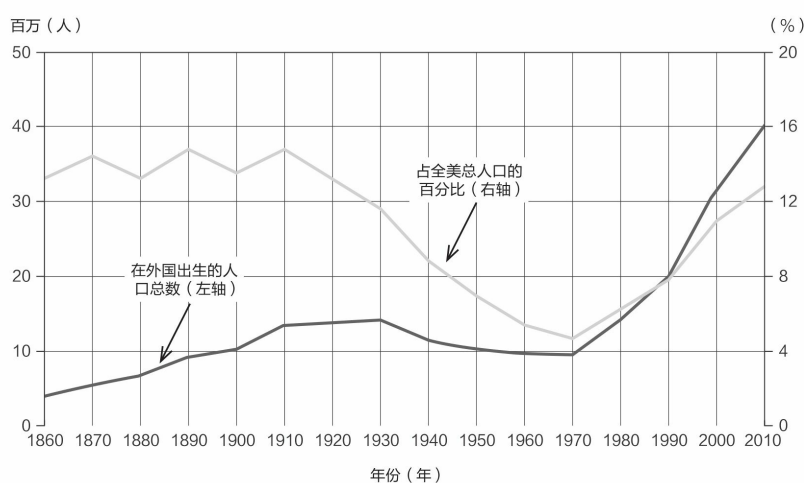


图8-13 美国的移民

自1970年以来，美国的移民人数一直在稳步攀升，正在接近历史最高水平，而且这还不包括1 200万的非法移民。

资料来源：Congressional Budget Office, 2013.

如今的移民情况和20世纪初时的有些不同。1960年以前，美国人口中几乎90%都是白

人，而现在白人只占了1/3。

有些评论家认为，这些移民缺乏为美国发展高科技经济做贡献的技能。然而，就如下数据来看，我们会发现这些批评者在很多基本方面都错了（Camarota, 2001; Flanigan, 2005; Gorman, 2010）：

- 大多合法和非法移民最终都取得了经济方面的成功。虽然他们最初大都比较贫困，但1980年以前来到美国并站稳脚跟的移民比本土美国人拥有更高的家庭收入。移民和非移民一同竞争企业家的位置，1/9的移民都能建立自己的企业。
- 只有少数移民是为了福利救济而来到美国的。相反，他们中的大部分是为了争取工作和成功的机会而来的。处于工作年龄的非难民移民相对美国本土公民来说，依靠政府福利救济的比重更小。
- 长久来看，移民对经济所做的贡献比他们得到的更多。虽然接纳移民最初对政府来说成本较高（这通常是因为他们从事低收入工作，因此不缴纳所得税），但随着年龄的增长，移民们的生产率会不断提高。

移民常常会取得经济上成功的原因之一是，那些选择离开自己本国的人都是动机十足且有好胜心的人。

闲暇时光：工作以外的生活

学习目标8.13 描述成年中期的个体如何度过闲暇时间。

美国典型的工作周一般包括35~40小时，而且对大多数人来说正越来越短，大部分中年人每周有70个小时清醒的闲暇时间（Kacapyr, 1997）。他们都用这些时间来做什么呢？

首先，中年人会看电视。他们平均每周要看大约15个小时的电视。但除电视之外，中年人在闲暇时还会干很多其他事情。对很多人来说，成年中期为人们提供了一个到室外活动的全新机会。随着孩子的离开，父母开始有大量时间参与更广泛的活动，比如做运动或参加城镇委员会。美国中年人每周约有6小时用于参与社会活动（Robinson & Godbey, 1997; Lindstrom et al., 2005）。

相当多的人发现闲暇时间具有极大的吸引力，因此纷纷选择提早退

休。对那些有足够的经济来源以维持余生的人来说，提早退休的生活是令人非常满意的。提早退休的人往往健康状况良好，而且会从事各种新的活动（Cliff, 1991; Jopp & Hertzog, 2010）。

尽管中年期提供了更多休闲的机会，但大多数人表示，他们生活的节奏并没有因此变慢。因为人们希望参加多种多样的活动，所以每周的大部分休闲时间都被切割成了15~30分钟不等的时间块。因此，虽然相比1965年以前人们每周休闲的时间增加了5小时，但很多人并不觉得自己有了更多空闲时间（Robinson & Godbey, 1997）。

多余的休闲时间看起来消失的一个原因，是美国的生活节奏比其他很多国家都要快很多。有研究测量了步行者行走18米所需的平均时间、顾客购买一张邮票的时间以及公共钟表的精确度，并通过这些数据比较了不同国家的生活节奏。这些测量结果显示，美国的生活节奏比很多国家都快，尤其是跟许多拉丁美洲、亚洲和非洲国家比起来。但很多国家的生活节奏也超过了美国，西欧国家和日本就比美国快很多，瑞士更是名列第一（Levine, 1997a, 1997b）。

回顾、检测和应用

回顾

学习目标**8.7** 解释成年中期人格发展的不同观点。

在常规危机模型中，人们将经历与年龄相关的各个阶段；生活事件模型则关注人们对不同的生活事件会做出怎样的回应和发生何种变化。埃里克森把中年生活描述为再生力对停滞的一段时期。韦兰特、古尔德和莱文森则对埃里克森的观点提出了异议。莱文森认为中年时期的转变会导致中年危机，但对大多数人来说，并没有确切的证据可以证明此论点。

学习目标**8.8** 分析人格在一生当中是稳定的还是变化的。

个体最基本的人格特征将保持相对稳定，但某些特定的方面确实会因各种生活事件而发生改变。一般来说，人们的幸福水平在一生中都会保持相对稳定。

学习目标**8.9** 描述成年中期典型的婚姻模式以及离婚。

个体在整个婚姻历程中对婚姻的满意度会有升有降，婚姻的满意度呈U形曲线。在幸福的婚姻中，大多数人会觉得他们的配偶随着年龄的增长变得更加有趣了。离婚的原因有很多，包括满意度缺失、聚少离多和不忠等。离婚可能会提高幸福感，同时社会也越来越能接受离婚。

学习目标**8.10** 分析成年中期个体家庭模式变化的影响和意义。

中年时期，家庭变化包括了和孩子的分离。而近几年，开始出现“飞去来器般的孩子”现象。人们在中年时期对年迈父母的责任通常会越来越大。

学习目标**8.11** 描述美国家庭暴力的产生原因和特点。

虐待更可能发生在经济紧张、言语攻击普遍的大家庭中。那些本身就在暴力环境中长大的成人更有可能出现暴力行为。婚姻暴力一般会经历三个阶段：紧张气氛的建立、激烈的殴打事件和爱的忏悔。

学习目标**8.12** 描述成年中期工作的裨益和挑战。

成年中期的个体看待工作的方式会和以前有所不同，他们更关注现实因素，而且会对职业奋斗和雄心壮志的关注度降低。中年时期的职业转换会变得更加普遍，主要原因是对工作的不满、对挑战和地位的需求，或是希望在孩子长大之后重返职场。

学习目标**8.13** 描述成年中期的个体如何度过闲暇时间。

成年中期的个体一般会拥有更多的休闲时间。他们通常会用这些时间来参与更多的户外娱乐或社区活动。

自我检测

1. 根据__模型，处在不同年龄的个体可能会经历相同的情绪和人格变化，因为他们在生活中有共同的经历。
 - a. 常规危机
 - b. 心理性的
 - c. 生活事件
 - d. 自我理解
2. 那些既要照顾父母又要养育孩子的中年夫妇被心理学家称为____。
 - a. 婴儿潮
 - b. 两者之间的
 - c. 三明治一代
 - d. “飞去来器般的孩子”
3. 婚姻侵犯中，殴打者对暴力行为表示悔恨和道歉，被称为____阶段。
 - a. 暴力循环
 - b. 急性打击
 - c. 紧张气氛建立
 - d. 爱的忏悔

4. 和年轻人比起来，中年时期失业的人会____。
- a. 保持失业状态的时间更久，且随着年龄增长，找到满意工作的机会也更少
 - b. 由于技术好而能更快找到工作，但很难维持在职时间
 - c. 很难找到新工作，但只要找到就能拥有较稳定的工作
 - d. 更不可能抑郁，这让他们他们更容易获得工作

应用于毕生发展

为什么和以前相比，职业奋斗对中年人来说没有那么大的吸引力了？什么样的认知和人格变化有可能导致这一现象？

总结

本章开头提到的50岁的特里，由于之前忙于工作和家庭，她发现几十年来自己的休闲时间一直很少。到了成年中期，她把最小的孩子送去了大学，在流动厨房从事志愿服务，辞去了城市规划师的工作，并参加州议会的竞选。与此同时，她与丈夫重燃了激情。尽管特里正处于中年转变期，但并没有经历中年危机。她意识到，如果一切顺利的话，她还有一半的人生要经历。尽管特里正忙于竞选，但她还是会努力地维系自己与丈夫、孙辈、那些在流动厨房遇到的人的关系，并通过竞选州议会的席位来与整个社区建立牢固的关系。

8.1 成年中期的生理发展

尽管成年中期会出现一些慢性疾病，如关节炎和高血压，但和大部分中年人一样，特里十分健康。

- 随着年龄的增长，特里通过步行来保持健康和敏捷，很多同龄人也是这样做的。
- 如果特里将步行作为一项日常训练，那她就可以弥补自己在成年中期逐渐损失的力量。
- 因为无须继续抚养子女，特里可以有更多的时间和精力与丈夫享受性生活。但是，如果没有绝经，那她就仍需避孕。

8.2 成年中期的认知发展

- 作为一名城市规划师，特里掌握了相关的专业技能，极富职业竞争力。因此，即使成年中期智力下降了，她仍旧能够在工作中取得成功。

- 如果特里感兴趣，她对城市规划的了解能够帮助她快速评估潜在的项目，了解需要做什么，并做出决定。
- 除了传统的智力之外，特里还可能拥有大量的实践智力。

8.3 成年中期的社会性和人格发展

- 尽管特里正处于中年过渡期，但她所采取的一系列行动能建立更紧密的社会联系，并以一种真正令她满意的方式来改变职业轨道，所以能够促进她的发展。
- 特里对新事物的开放态度，以及她的外向性和组织才能都属于人格特质，在其一生中都是保持稳定的。
- 在当地流动厨房参与志愿服务、竞选州议会的席位以及同丈夫重燃激情，冲淡了特里由于最小的孩子离家上大学而产生的悲伤。



职业顾问会怎么做？



你会建议特里将她的政治抱负放在一边，而继续从事她十分擅长且能够掌握进度的纽约城市规划师的工作吗？

婚姻顾问会怎么做？



你会建议特里专注于与丈夫重燃激情而将竞选推迟一两年吗？如果特里赢得了竞选，当她开始这项极富挑战的工作时，你会给出哪些建议帮助她同时对婚姻保持专注？

医疗保健工作者会怎么做？



鉴于特里的年龄和正在经历的生理变化，你会给她提供哪些饮食和锻炼方面的引导，帮助她应对疲劳以及公共服务工作所带来的压力？

你会怎么做？



你会建议特里放缓过渡期的节奏，以巩固现在所拥有的一切吗？为什么？

第9章 成年晚期

79岁的彼得和他73岁的妹妹埃拉住在他们5年前购买的房子里，他们的配偶都在那一年去世了。“我们一起住，就像孩童时代在纽瓦克一样，”彼得说，“尽管我们相差6岁，但我们相处得很好。当我们突然感到孤独的时候，就会在我妻子的灵前聊聊，而且总是在说，‘为什么不呢？’。到目前为止，一切都很顺利。至少我是这样认为的。”

这时埃拉接过话说：“没错。我们就像一对勺子那样适合，没有冲突，没有争论，和我们期望的一样团结、和睦。6岁的差距看起来并没有那么大了。”

当问到他们这种兼容性是否源于他们兄妹的相似性时，他俩忍不住笑出声来。“相似性？”彼得问道，“很难找到比我们更不相同的两个人了。比如，我是一个喜欢在家消遣的人，喜欢坐在房间里看书，又是一个影迷，有无数的电影DVD，还喜欢打理花园和烹饪。我最大的乐趣就是和一些老朋友共进晚餐、看电影。我还很喜欢打扫房间和洗衣服。”

“而我总是在外忙个不停，”埃拉说，“我加入了一个缝纫妇女会和两个读书俱乐部，经常去打高尔夫球，还在医院的礼品店工作。我在社区学校学西班牙语、学下棋，而且经常会与彼得一起或是独自去西部或国外旅行。”

“我们可以说是一个硬币的两面，”彼得说，“我很整洁，而她不是。她喜欢出去，我爱宅在家里。她很好胜，我很闲散。我做饭，她吃。但是我们从未感觉到厌烦。”

“尽管我俩都有点儿健忘，”埃拉微笑着说，“但我们似乎是会忘记不同的事情。如果我忘记了一个约定，彼得就会提醒我。当他试图回忆某个人名时，我总是知道是哪一个。最棒的事情是，我们从来不会惹毛对方。我知道我们绝不会谈有关我们各自婚姻的事情。”她大笑着。

彼得和她一起笑起来。

成年晚期开始于65岁左右，以巨大的变化和个体的持续发展为特征。老年人面临着巨大的生理、认知和社会方面的变化，而且几乎每个人都能找到应对这些变化的策略，但大家的策略都有所不同。上述例子中彼得和埃拉所选择的就是一种完全不同的策略。总的来说，大部分老年人都可以很顺利地应对这个阶段。

在成年晚期，个体的各个方面都开始出现衰退，而这将伴随他们到

生命结束。老年人在这一阶段中，包括生理的、认知的和社会性的所有方面都在很大程度上会被人们误解，从而引发广泛的刻板印象。但事实上，老年人直到他们生命逝去的那天都可以真正保持生理和心理上的力量，而他们的社会生活，也会如其所愿地保持活力并充满生机。

在生理方面，65岁以上的人在该阶段刚开始时肯定会有一个过渡时期，即从十分健壮逐渐过渡到与日俱增地担心不健康、疼痛和疾病，但这并不是他们生命的全部。老年人仍可以在很长一段时期内保持健康，并继续进行年轻时的大部分娱乐活动。在认知方面，老年人可以很好地适应生活中那些似乎有意阻碍他们的变化，他们会采用一些新的方法来解决问题，并弥补自己逐渐损失的能力。而在社会方面，大部分老年人越来越善于应对生活中的变化，比如丧偶或退休。

彼得和埃拉就是例子。他们独特的老年生活，说明老年人可以成为他们想成为的那样，而不是社会认为他们应该成为的那样。

9.1 成年晚期的生理发展

预期寿命：我会活多久？

9.2 成年晚期的认知发展

你会如何锻炼自己的大脑，以使其保持灵活？

9.3 成年晚期的社会性和人格发展

文化在我们以怎样的方式对待成年晚期的个体方面发挥着怎样的作用？

9.1 成年晚期的生理发展

长生不老

约翰觉得74岁的生活很轻松。“跟为了工作和养家而奔波相比，现在的生活轻松多了。”他说。他承认有些事情发生了改变。“我以前每天跑步，但膝盖问题从10年前就开始困扰我，所以我改为骑车，之后，关节就好受多了。”另一项改变是嗅觉。“人们说‘停下来嗅玫瑰’，但我再也嗅不到玫瑰了。”他打趣道。约翰还在享受生活中的很多事情。“我当了40年律师，在退休的时候，开始写关于最高法院判决的博客。我女儿帮我注册了博客。现在，我正在写一本关于最高法院过去50年间的案例的书。”约翰还在一支弦乐四重奏乐队中演奏中提琴——那是他10年前组织的一支乐队，并且和伴侣玛迪跳摇摆舞。“我管她叫我的小女友，因为她虽然比我大一岁，但心态年轻又时髦。我们去年春天去了巴黎，在塞纳河左岸一家家地逛咖啡馆，直到凌晨。”当被问到除了写完那本书，还有没有别的重大想法时，约翰思考了一会：“我现在的主要目标就是想长生不老。”

约翰并不是唯一一个在成年晚期重显活力的老年人。越来越多的老人正努力开辟新的领域和做新的尝试，并全面重塑社会大众对老年生活的认知。对越来越多迈入成年晚期的人来说，精力充沛的脑力和体力活动仍然是日常生活中的重要部分。

在社会过去的认知中，老年就意味着失去，失去脑细胞、智识、精力和性欲等。而如今，这种看法正逐渐被老年学家（**gerontologists**）的新观点替代。研究衰老的专家认为，与其将成年晚期看作一个衰退期，不如将其看作是个体继续变化的一个时期——个体在一些方面有所增长，在另一些方面有所衰退。



老年学家发现，成年晚期个体可以和比他们年轻许多的人一样精力充沛和充满活力。

甚至“老年”的定义也一直在变。大多数成年晚期的个体仍然像比他们年轻几十岁的人一样精力充沛、精神饱满。我们不能简单地用实际年龄来定义老年，而必须考虑到老年人的生理和心理幸福感以及他们的功能年龄（functional ages）。有些研究者根据功能年龄将老年人分成了三组：年轻老人（young old），比较健康；年老老人（old old），有一些健康问题、日常活动有困难；高龄老人（oldest old），虚弱、需要照顾。根据功能年龄来划分，一个积极、健康的百岁老人可以归入年轻老人，而一个患肺气肿晚期的65岁老年人则要归入高龄老人。

在这一节中，我们会首先讨论有关衰老的误解与现实，同时考察影响人们看待成年晚期的部分刻板印象。我们还将考察衰老的外部特征和内部迹象，以及神经系统和感官能力随着衰老而发生的变化。

接下来，我们将探讨成年晚期个体的健康状况和幸福感。在考察困扰老年人的主要障碍之后，我们将探讨决定老年人健康的因素以及老年人更易患病的原因，接着我们会讨论成年晚期的性欲。我们还将集中讨

论一些解释衰老过程的理论，以及与性别、种族和族裔有关的预期寿命的差异。

生理改变

从宇航员转行为参议员的约翰·格伦，为帮助美国国家航空航天局（NASA）研究老年人对太空旅行的适应情况，在77岁时接受了一个为期10天的重返太空的任务。尽管格伦因为飞入太空而显得与众不同，但很多平凡的成年晚期个体同样过着积极且充满活力的生活，全身心地投入生活中。

衰老：误解和现实

学习目标**9.1** 描述有关衰老的误解与现实。

成年晚期与生命中的其他阶段存在明显的差异：因为人的寿命越来越长了，成年晚期的长度也随之增加。不管将成年晚期的起始年龄定为何时，当今全球处于成年晚期的个体所占比例都处于历史最高。事实上，人口统计学家划分这一阶段所使用的术语，与研究“功能性衰老”者使用的相同，但含义却不同。对人口统计学家来说，这一术语的划分完全基于年龄。年轻老人的年龄范围为65～74岁，年老老人为75～84岁，高龄老人为85岁及以上。

成年晚期的人口统计学 在美国，有1/8的人年龄在65岁及以上；据预测，截止到2050年，这一人群将达到人口总数的近25%（见图9-1）。85岁以上的人口数将从目前的400万增长到2050年的1 800万（Schneider, 1999; Administration on Aging, 2003）。

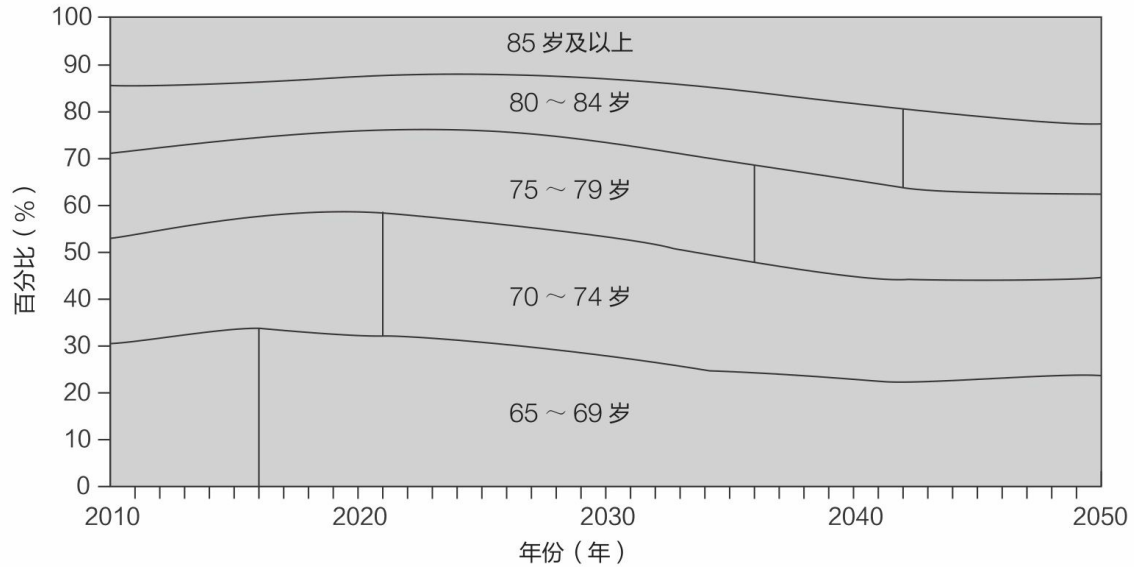


图9-1 快速增长的老年人口

到2050年，美国65岁及以上的人口数占总人口数的比例将上升至25%。你能说出导致这种增长的两个因素吗？

资料来源：U.S. Bureau of the Census，2008.

成年晚期的个体中，人口增长速度最快的是85岁及以上的高龄老人。在过去20年中，高龄老人的人口数量几乎翻了一倍。老年人口爆炸的现象并不限于美国，全球各国的老年人口数都在激增。到2050年，全球60岁以上的人数将首次超过15岁以下的人数，具体可参见图9-2（Sandis, 2000; United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2013）。

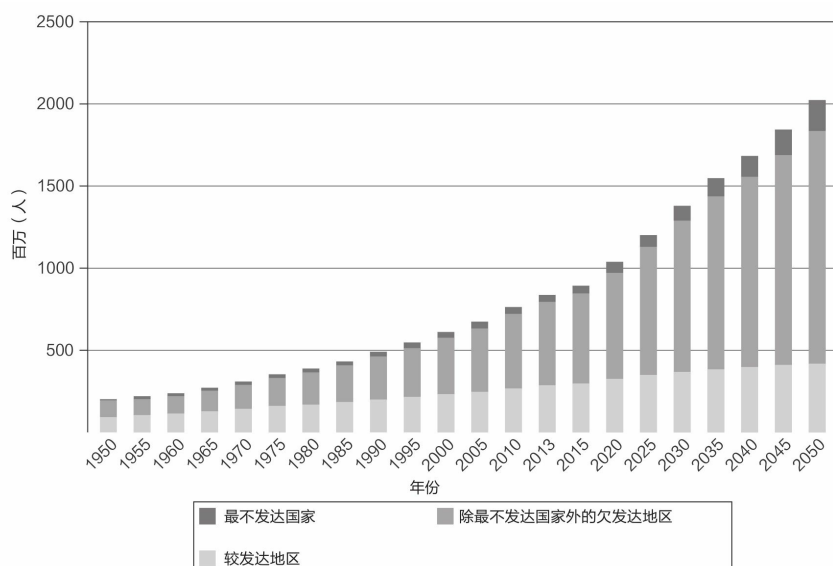


图9-2 全球老年人口数

人类平均寿命的延长正在改变全球各地的人口状况，预计到2050年，60岁及以上的老人所占比例将会大幅增加。

资料来源：United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2013.

老年歧视：老年人遭遇的刻板印象 古怪的、怪老头、老笨蛋、年老体衰、老家伙、老巫婆……这些都是社会贴给成年晚期个体的标签。这些词所描绘的特质并不美好：它们都带着贬义和偏见，正体现了社会对老年人的显性歧视和隐性歧视。老年歧视（**ageism**）是指个体或社会对老年人的偏见和歧视。

老年歧视认为老年人无法充分运用他们的心智。许多与心态有关的研究表明，与年轻人相比，人们认为老年人在许多方面的表现更加消极，特别是与一般能力和吸引力有关的特质（Helmès & Campbell, 2010; Woodsping, 2012; Jesmin, 2014; Nelson, 2016）。

许多文化都更看重年轻人，羡慕他们的青春活力和外表。除了较少专门为老年用品设计的广告外，广告中出现老年人的很少。而在电视节目中，老年人常作为某人的父母或者祖父母出现，而不是作为一个独立的个体来展现（Vernon, 1990; McVittie, McKinlay, & Widdicombe, 2003; Ferguson & Brohaugh, 2010）。

从某种程度来说，当今社会对老年人的歧视是某些现代文化的特定现象。在殖民地时期的美国，活得长意味着德高望重，因而老人会受到高度尊敬；大部分亚洲社会也非常尊敬老人，人们认为老年人因为活得长而获得了特殊的智慧；许多美国印第安人社会，传统上会把老人视为储存过去信息的仓库（Bodner, Bergman, & Cohen-Fridel, 2012; Maxmen, 2012）。



当看到图中的女人时，你会想到什么？对老年人的歧视普遍存在于针对老年人的消极态度中，人们认为老年人更难充分地运用他们的能力。

而如今，美国社会因为基于一些错误信息而对老年人普遍持有消极的看法。你可以通过回答表9-1中的问题，来测试自己关于衰老的知识。大多数人的正确率不会超过随机水平，即50%（Palmore, 1992）。

表9-1 对衰老的误解

1. 大多数 65 岁及以上的老年人记忆存在缺陷、分不清方向、精神错乱	对 ☐	错 ☐
2. 在老年期，视觉、听觉、味觉、触觉和嗅觉这五种感觉都会退化	对 ☐	错 ☐
3. 大多数老年人对性生活既没有兴趣也没有能力	对 ☐	错 ☐
4. 老年人的肺活量会衰减	对 ☐	错 ☐
5. 大多数老年人的大部分时间都在患病	对 ☐	错 ☐
6. 老年人的体能会衰减	对 ☐	错 ☐
7. 至少有 1/10 的老年人正住在护理院、精神病院、养老院等提供长期照顾服务的机构中	对 ☐	错 ☐
8. 许多老年人维持着较大的社交圈	对 ☐	错 ☐
9. 老年工作者的工作效率往往不如年轻工作者	对 ☐	错 ☐
10. 超过 3/4 的老年人非常健康，能够完成日常活动	对 ☐	错 ☐
11. 大多数老年人都无法适应新的变化	对 ☐	错 ☐
12. 老年人通常需要更长的时间来学习新东西	对 ☐	错 ☐
13. 对一般的老年人来说，学习新东西几乎是不可能的	对 ☐	错 ☐
14. 老年人的反应比年轻人慢	对 ☐	错 ☐
15. 总的来说，老年人往往在各方面都很相似	对 ☐	错 ☐
16. 大多数老年人说他们很少感到无聊	对 ☐	错 ☐
17. 大多数老年人都会逐渐与社会脱节	对 ☐	错 ☐
18. 老年工作者造成工作事故的概率比年轻工作者低	对 ☐	错 ☐

评分：所有奇数题的表述都是错的，所有偶数题的表述都是对的。大学生平均答错 6 道题，高中生平均答错 9 道题，就连大学教师也平均答错 3 道题。

资料来源：Palmore, 1988; Rowe & Kahn, 1999.

许多人对老年人的刻板印象如此普遍，而事实真的如此吗？答案多半是否定的。衰老引起的后果因人而异。一些老年人身体虚弱，存在认知困难，需要持续的照顾；一些老人却精力充沛、生活独立。除此之外，有些问题看起来似乎是由衰老引起的，但其实真正的原因是疾病、饮食不当或营养不足。正如我们下面将看到的，成年晚期会带来与之前阶段相比幅度相当甚至更大的变化与成长（Whitbourne, 2007）。

从社会工作者的视角看问题

当一个老年人因为精力充沛、积极参加活动和有活力而受到称赞和关注时，这是一种歧视，还是一种反歧视呢？

老年人的生理改变

学习目标**9.2** 总结成年晚期发生的生理变化。

“体会脂肪燃烧的感觉。”健身教练说。此时小组里的14名女性大都在跟着做。当教练继续演示各种健身练习时，女性们也在不同程度地参与其中。有些人在用力伸展，有些人则几乎只跟着音乐的节拍摆动。这里与美国上千个健身班没有多少差别，但仍然会让年轻的观察者大吃一惊：这群人中最年轻的66岁，最老的则81岁，而且都还穿着十分考究的紧身衣。

观察者的吃惊反映了人们对65岁以上老人的刻板印象：人们普遍认为老人们习惯久坐，不能参与大运动量的健身活动。事实却恰恰相反，虽然老年人的运动能力很可能已经改变了，但大多数老人的身体仍然相当灵活和健康。当然，那些成年中期悄然开始的内在和外在变化，到了老年期也会相当明显（Sargent-Cox, Anstey, & Luszcz, 2012; Fontes & Oliveira, 2013）。

在讨论衰老时，我们要注意初级衰老和次级衰老之间的区别。初级衰老（**primary aging**）或称老年期，是指基于遗传程序的预先设定所出现的普遍且不可逆转的变化。相反，次级衰老则指的是由于疾病、健康习惯和其他个体差异等因素所导致的变化，并非必然发生。尽管次级衰老伴随的生理和认知功能的改变很常见，但它们都可以避免，甚至有时会出现逆转。

衰老的外部迹象 衰老最明显的迹象之一是头发的变化。个体衰老之后，头发通常会明显变灰，最终变白，还有可能变得稀疏。脸部和身体其他部位的皮肤会失去弹性蛋白和胶原蛋白__⁽²⁶⁾__，从而出现皱纹（Bowers & Thomas, 1995; Medina, 1996）。

老年人可能会明显变矮，有些人的身高会变矮10厘米。尽管这种变矮的现象部分是因为老年人习惯的身体姿势发生了改变，但主要原因是椎间盘的软骨变薄了。对女性来说尤其如此，她们比男性更易患骨质疏松，其中的一大原因是女性在老年分泌的雌激素减少了。

在60岁及以上的老年女性中，有25%的人患有骨质疏松，这也是老

年人容易发生骨折的主要原因之一。如果早年能够摄入充足的钙和蛋白质，并进行适当锻炼，个体就能在很大程度上预防这种疾病。另外，骨质疏松可以通过服用阿仑膦酸钠（alendronate sodium）之类的药物进行预防和治疗（Swaim, Barner, & Brown, 2008; Wang et al, 2013; Hansen et al., 2014）。



即使在成年晚期，锻炼也是可实现并且有益的。

尽管对衰老外表的消极刻板印象对两性都有影响，但对女性来说影响更甚。事实上，许多文化都对外表持有双重标准，即对女性的评价更为苛刻。例如，男性的头发变成灰色常常被视为是“尊贵的”，但相同的特征出现在女性身上时，却更多地被看作是一种“上了年纪”的标志（Bell, 1989; Krekula, 2016）。

这种双重标准导致的结果是，女性会比男性感受到更大的压力，从而使她们想通过染发、整形或使用掩盖年龄的化妆品来隐藏衰老的特征。但是，这种双重标准正在淡化，因为男性也开始关注如何使自己看

起来更年轻，市场上也随之出现了许多供男性使用的化妆品，如除皱霜。不过随着双重标准的放宽，老年歧视成了男性和女性共同担心的问题。

内部衰老 随着衰老的外部特征越来越明显，身体内部各器官的功能也在发生着巨大变化（Whitbourne, 2001; Aldwin & Gilmer, 2004）。

大脑会随着个体的变老而变小、变轻。收缩的大脑会逐渐远离颅骨，所以70岁时大脑与颅骨之间的距离是20岁的两倍。大脑消耗的氧气和葡萄糖也会随着年老变少，血流量也随之降低。大脑某些部位的神经元或脑细胞会减少，但不会像我们曾经以为的那样严重。研究表明，在个体衰老的过程中，大脑皮层的细胞数目可能只有轻微减少或者根本不减少。事实上，一些证据表明，某些类型神经元的生长会持续一生（Raz et al., 2007; Ziegler et al., 2010; Gattringer et al., 2012; Jäncke et al., 2015）。

老年人脑内血流量减少的部分原因是血管的硬化和收缩导致心脏泵血能力下降。一名75岁老人的心脏泵血量还不到他成年早期泵血量的3/4（Kart, 1990; Yildiz, 2007）。

处于老年期的个体，其身体其他系统的机能也会有所下降。呼吸系统的效率会降低，消化系统分泌的消化液会减少，食物通过消化道的运动效率也降低了，这导致老年人更容易便秘。同时，老年人的一些激素水平也会有所下降，肌肉纤维的体积和数量都会减少，而且它们利用血液中的氧气和储存营养成分的效率也在降低（Deruelle et al., 2008; Suetta & Kjaer, 2010; Morely, 2012）。

尽管这些变化十分正常，但对于那些生活方式不太健康的人，这些变化会大大提前。例如，在任何年龄段，吸烟都将加速个体心血管功能的衰退。

健康的生活方式会减缓个体与衰老有关的变化。例如，参加举重类锻炼活动的人，其肌肉纤维萎缩的速度会比久坐不动的人更低。与此类似，身体越健康的人心理测验的成绩就越好，而身体健康也能防止脑组织的萎缩，甚至有助于新神经元的发展。研究表明，那些久坐不动的老年人如果进行一些适当的有氧健身训练，会在一定程度上改善认知（Pereira et al., 2007; Solberg et al., 2013; Lin et al., 2014）。

变长的反应时 当看到小孙子的游戏机屏幕上出现“游戏结束”的提示时，卡洛斯打消了玩一把的念头。他喜欢玩孩子们的游戏，却无法像孩子们那样快速地干掉游戏里的那些坏蛋。

随着变老，老年人做诸如系领带、拿起电话、玩游戏时按键等事情所需要的时间也更长了。老年人做事速度减慢的原因之一是反应时的增加。个体的反应时在中年期会开始变长，到了成年晚期则更甚（Fozard et al., 1994; Benjuya, Melzer, & Kaplanski, 2004; Der & Deary, 2006）。

人们反应变慢的原因至今仍不太明确。其中一个解释是外周减速假设（**peripheral slowing hypothesis**），即外周神经系统的整体效率随年龄增长而降低。外周神经系统包含从脊髓和大脑延伸出来到达身体各末端的神经分支。这样一来，从环境中获取的信息传递到大脑就需要更长的时间了，而大脑下达的指令传递到全身肌肉的时间也会变长（Salthouse, 2006; Kimura, Yasunaga, & Wang, 2013）。

总体减速假设（**generalized slowing hypothesis**）指出，老年人包括大脑在内的各部分神经系统的加工效率都变差了，所以老年期的个体全身都在减速，包括对简单和复杂刺激的加工以及大脑传递指令到全身肌肉的速度（Cerella, 1990）。

虽然我们不知道哪种假设的解释更准确，但毫无疑问的是，反应时的延长和总体加工速度的减慢使老年人发生事故的概率升高了。因为反应和加工时间的变长，老年人无法有效地接收可能提示危险情况的环境信息，所以他们的决策过程更加缓慢，这损害了老年人避开危险的能

力。调查显示（见图9-3），70岁以上的老年司机单位距离内发生致命事故的数量与青少年相同（Whitbourne, Jacobo, & Munoz-Ruiz, 1996; Leversen, Hopkins, & Sigmundsson, 2013）。

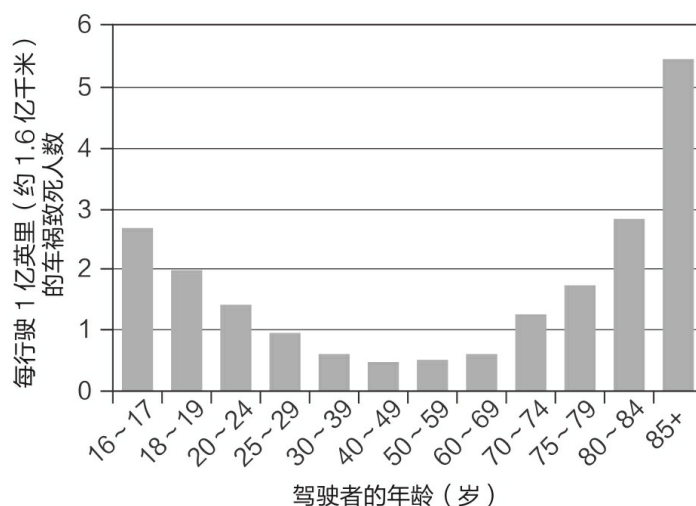


图9-3 不同年龄段驾驶者的交通事故死亡率

70岁以上的老年司机每英里（约1.6千米）内发生致命事故的数量与青少年相同，为什么会这样呢？

资料来源：Tefft, 2012.

感觉：视觉、听觉、味觉和嗅觉

学习目标9.3 解释衰老如何影响感觉。

在老年期，个体的感觉器官出现了明显衰退。由于人们是通过感觉将自己与外部世界联系起来的，所以感觉的衰退将会对个体的心理产生很大影响。

视觉 随着年龄的增长，眼睛的各部分实体结构，包括角膜、晶状体、视网膜和视神经都发生了变化，从而引起视力下降。老年人的晶状体会变浑浊，60岁时，只有相当于20岁时1/3的光线能到达视网膜；视神经传导神经冲动的效率也随之降低，导致视力在多个维度上表现出

衰退。老年人更不容易看清远处的物体，日常想要看清物体时也需要更多的光亮；眼睛从暗处到明处时需要更长的适应时间，反之亦然

（Gawande, 2007）。

这些变化给老年人的日常生活带来了很多困难。他们开车变得更具有挑战性，尤其是夜间驾车；看书时需要更多的光亮，而眼睛也更易疲劳。当然，戴眼镜有助于克服不少困难，大多数老年人都能借此看得更清楚（Owsley, Stalvey, & Phillips, 2003; Boerner et al., 2010）。

一些眼部疾病在成年晚期非常普遍。例如困扰许多老年人的白内障——这种疾病是指眼睛晶状体的某些区域出现了云状物或不透明区域，从而阻挡了光线的通过。白内障患者在明亮光线下看东西会模糊不清并觉得刺眼。如果老年人患有白内障而不进行治疗，晶状体就会慢慢变成乳白色，并最终导致失明。好在白内障可以通过手术去除，视力可通过佩戴眼镜或通过眼内晶状体植入[\(27\)](#)来恢复（Walker, Anstey, & Lord, 2006）。

另一个严重影响老年人的眼部疾病是青光眼。如我们之前所提及的，当眼睛内的液体未能适当排出或生成过多时，眼内液体的压力就会增加，进而形成青光眼。如果发现及时，人们可以通过药物或手术治愈青光眼。

60岁及以上老人失明的常见原因之一是老年性黄斑变性（age-related macular degeneration, AMD），它会影响视网膜附近的黄色区域，即视觉最敏锐的黄斑（macula）。当一部分黄斑变薄退化时，视力就会逐渐恶化（见图9-4）。如果诊断及时，该病有时可以利用药物或激光进行治疗。还有一些证据表明，多食用抗氧化的维生素（维生素C、维生素E和维生素A）可以减少罹患这种疾病的风险（Jager, Mieler, & Miller, 2008; Vingolo, Salvatore, & Limoli, 2013; Bainbridge & Wallhagen, 2014）。

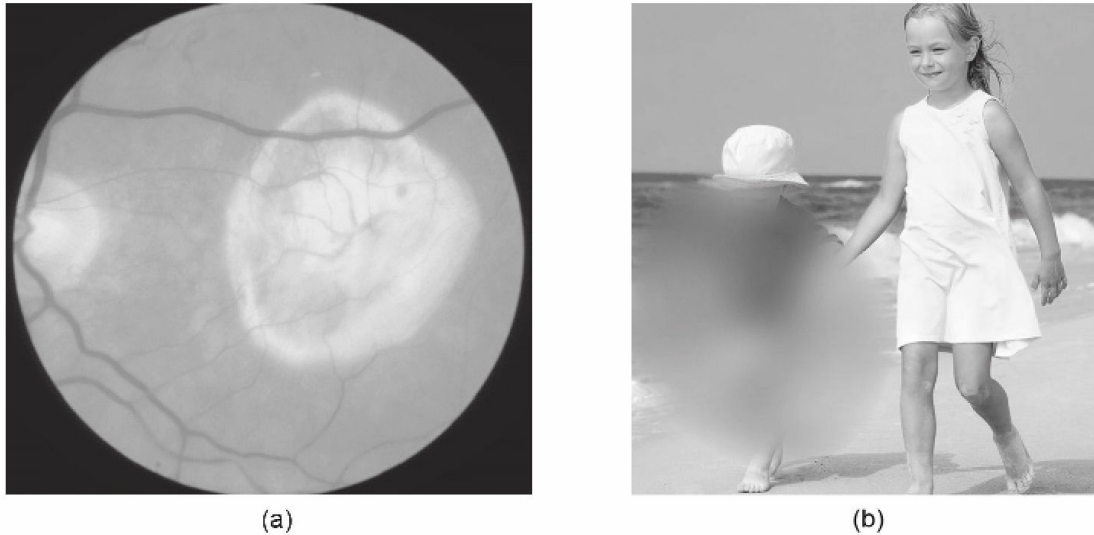


图9-4 黄斑退化者眼中的世界

(a) 老年性黄斑变性会影响视网膜附近的一个浅黄色区域——黄斑，当黄斑部分变薄退化时，人的视力就会逐渐恶化。

(b) 黄斑退化使视网膜中心的机能逐渐变差，只剩下外周视觉。这是一个黄斑退化患者可能看到的世界的例子。

资料来源：AARP, 2005, p. 34.

听觉 大约30%的65~74岁老人存在某种程度的听觉损伤，而超过50%的75岁以上老人存在听觉损伤。总的来说，美国有1 000万以上的老人存在某种听觉损伤（Chisolm, Willott, & Lister, 2003; Pacala & Yueh, 2012）。

衰老尤其会影响人们听到高频声音的能力。如果背景噪声很多或同时有多个人说话，那么高频听力受损的老人要听清对话就会很困难。此外，巨大的噪声还会让一些老年人感到痛苦。

尽管助听器可以在75%的时间内对存在听觉损伤的人有所帮助，但只有20%的老年人会使用它。原因之一是这些助听器并不完美。助听器放大背景噪声的倍数与放大对话的倍数一样多，这就很难让使用者从嘈杂的声音中分离出自己想要的内容。原因之二是许多老年人觉得使用助听器会让他们显得更老，而且很有可能被其他人当成残疾人（Lesner,

2003; Meister & von Wedel, 2003)。

听觉损伤会对老年人的社会生活造成致命影响。首先，由于无法完全听清对话，有些存在听觉损伤的老年人会远离他人，因为这些老年人会由于不确定别人对自己说了什么而不愿意回应他人，他们很容易感到被忽略和孤独。其次，听觉损伤还可能使老年人产生妄想，因为他们可能会根据心理恐惧而不是事实来推断未能听懂的话。例如，如果有老年人将“我不喜欢去那家卖场”听成“我不喜欢去他家拜访”，他就会将原本对购物中心的普通看法，误解为一种个人敌意（Myers, 2000; Goorabi, Hoseinabadi, & Share, 2008; Ozmeral et al., 2016）。

最后，听觉损伤会加速老年人的认知衰退。老年人在分辨谈话者所说的内容上感觉艰难，这会分流他们处理信息的心理资源，使得记住和理解信息更加困难（Wingfield, Tun, & McCoy, 2005; Mikkola et al., 2015）。

味觉和嗅觉 在成年晚期，味觉和嗅觉的敏感性会出现衰退，所以一向爱好饮食的人到了老年，其生活质量可能会大大下降。对这两类感觉的辨别力下降，会导致老年人觉得食物尝起来、闻起来都没有以前那样可口了（Kaneda et al., 2000; Nordin, Razani, & Markison, 2003; Murphy, 2008）。

味觉和嗅觉敏感性下降的原因之一是生理上的变化。老年人舌头上的味蕾逐渐减少，使他们觉得食物没有以前可口了。同时，脑中的嗅球也开始萎缩，这使情况进一步恶化。味觉依赖于嗅觉，这使得食物尝起来更加无味。

味觉和嗅觉敏感性的下降会带来有害的副作用。食物尝起来没有那么好吃，人们就可能吃得更少，从而引发营养不良。为了补偿味觉敏感性的下降，人们可能会在做菜时放更多的盐，因而增加了个体患高血压的风险，而高血压恰恰是老年人最常面临的健康问题之一（Smith et al., 2006）。

衰老对健康的影响

弗莱和别人传看着一张她父亲的照片。“拍照时他75岁，看上去很好，可以去航海，但是他已经开始忘记一些事，比如昨天干了什么，早餐吃了什么。”

弗莱加入了一个针对阿尔茨海默病患者家属的互助小组。她分享的第二张父亲的照片拍摄于上一张照片的10年后。“我很伤心，他跟我说话开始变得杂乱不清。然后他忘记了我是谁，忘记了他有一个弟弟，还忘记了他曾是参加过第二次世界大战的飞行员。照完这张照片一年后，他就卧床不起了。半年后他就过世了。”

当弗莱的父亲被诊断为阿尔茨海默病时，美国有450万人正在遭受这种病症的折磨。这是一种使人衰弱的疾病，会将人的体能和心智耗竭。在某种程度上，阿尔茨海默病助长了我们对于老年人身体不太健康、更易于患病的刻板印象。

但实际情况并非如此，大多数老年人在老年期的大部分时间内都相当健康。美国的一些调查研究显示，65岁及以上的老人中，将近3/4的人认为自己的健康状况良好、很好或非常棒（U.S. Department of Health and Human Services, 1990; Kahn & Rowe, 1999）。

同时，步入老年阶段的确意味着个体更容易患上很多疾病。现在，我们就来看看一些困扰老年人的主要的生理和心理障碍。

老年人的身心健康问题

学习目标9.4 总结老年人遭遇的健康问题，并列出影响个体健康状况的因素。

事实上，发现于成年晚期的大多数疾病并不是老年人特有的。例如，所有年龄段的人都有可能罹患癌症或心脏病，只是这些疾病的发病

率在随着年龄的增长而上升，致使老年人的总体患病率增加。另外，相对于年轻人而言，老年人患病后恢复得较慢，且不太可能完全恢复。

常见的生理疾病 导致老年人死亡的主要原因有心脏病、癌症和中风，将近3/4的老年人死于这些疾病。因为衰老会弱化身体免疫系统，所以老年人也更容易染上传染病（Feinberg, 2000）。

大多数老年人都至少患有一种长期的慢性疾病，例如关节炎，仅一个或多个关节发炎，就折磨过近半数的老年人。关节炎会引起胀痛甚至导致残疾，使患者连扭开罐头盖、用钥匙开锁这样最简单的日常生活活动都完成不了。尽管阿司匹林和其他药物可以缓解关节肿胀和疼痛，但关节炎是无法治愈的（Leverone & Epstein, 2010; National Council on Aging, 2016）。

有将近1/3的老年人患有高血压。很多高血压患者没有任何症状，所以他们并没有意识到自己患有高血压，这就引发了很大风险。如果不进行治疗，高压会使血管和心脏变得脆弱并对其造成损害，从而增加个体罹患中风的可能性（Wiggins & Uwaydat, 2006; Hermida et al., 2013）。

心理和精神障碍 有15%~25%的65岁及以上的老人表现出了心理障碍的某些症状，不过这个比例相较于中青年人来说要低一些。与这些疾病有关的行为症状在老年人身上的表现有时与中青年人有所不同（Whitbourne, 2001; National Council on Aging, 2016）。

心理障碍中最常见的问题之一是重度抑郁症，它以强烈的悲伤情绪、悲观和无望感为特征。老年人变得抑郁的原因，是他们不断地经受配偶和朋友死亡带来的痛苦以及体能和健康状况衰退带来的折磨（Kahn, Hessling, & Russell, 2003; Menzel, 2008; Vink et al., 2009; Taylor, 2014）。

一些老年人为了医治各种病症而同时服用不同的药物，这就会提高

他们患上药物所致的心理障碍的风险。他们服用的剂量也可能不当，因为老年人新陈代谢的能力相比年轻时有所变化，一剂适合25岁年轻人的药对75岁的老年人来说可能就过量了。这些风险的存在，使老年人必须如实告知医生自己的用药和剂量，同时避免自己随意服用一些非处方药物，以免因和处方药混用而造成危险。

老年人最常见的精神疾病是重度神经认知障碍（**major neurocognitive disorder**），先前被称为痴呆（**dementia**）。它是指表现出严重的记忆损失，并伴有其他心理功能衰退的一大类疾病。重度神经认知障碍有多种成因，但症状都很相似：记忆力衰退、智力下降和判断力受损。罹患重度神经认知障碍的概率会随着年龄的增长而不断升高。60~65岁老人中这一疾病的患病率不到2%，而65岁以上的老人每增加5岁，患病率就增加一倍，到了85岁，患病率会达到1/3左右。这一障碍也存在族裔差异，非裔美国人和拉丁裔美国人患重度神经认知障碍的概率高于白种人（National Research Council, 1997; Weissberger et al., 2013）。

阿尔茨海默病（**Alzheimer's disease**）即一种表现为记忆丧失和混乱的渐进性大脑障碍。美国每年约有10万人死于此病。19%的75~84岁老人、将近50%的85岁以上老人患有阿尔茨海默病。事实上，如果不能找到治愈方法，那么到2050年就会有1 400万人患上阿尔茨海默病，相当于目前数量的3倍（Cowley, 2000; Alzheimer's Foundation of America, 2016）。

阿尔茨海默病的首发症状通常是健忘。患者可能在与他人对话的过程中想不起某些词句，或在买过东西后又数次返回杂货店。刚开始时，患者的近期记忆会受到影响，然后远期记忆也会开始逐渐消退。接着，患者会陷入完全混乱的状态，吐字不清，甚至不能认出最亲密的家人和朋友。最后，患者会失去对肌肉的自主控制能力，卧床不起。因为患者在患病之初就知道这种病之后的病程，所以他们往往会产生焦虑、恐惧